

MATERI PENTING SEPUTAR UKOM KEBIDANAN

(Sesuai Blueprint UKOM dan KMK 320 Tahun 2020)

Sri Setiasih, S.SiT., Bdn., M.Kes.
Bd. Retno Wulan, S.S.T., Keb., M.K.M.
Bdn. Yulita Nengsih, S.SiT., M.Kes.
Siti Rofi'ah, S.ST, M.Kes, Bdn.
Ratna Suminar, S.ST., M.Tr.Keb.

Editor: Mas Koko



Materi Penting Seputar UKOM Kebidanan

(Sesuai Blueprint UKOM dan KMK 320 Tahun 2020)

Sri Setiasih, S.SiT., Bdn., M.Kes.
Bd. Retno Wulan, S.S.T., Keb., M.K.M.
Bdn. Yulita Nengsih, S.SiT., M.Kes.
Siti Rofi'ah, S.ST, M.Kes, Bdn.
Ratna Suminar, S.ST., M.Tr.Keb.

Editor: Mas Koko



Materi Penting Seputar UKOM Kebidanan (Sesuai Blueprint UKOM dan KMK 320 Tahun 2020)

Penulis: Sri Setiasih, S.SiT., Bdn., M.Kes.
Bd. Retno Wulan, S.S.T., Keb., M.K.M.
Bdn. Yulita Nengsih, S.SiT., M.Kes.
Siti Rofi'ah, S.ST, M.Kes, Bdn.
Ratna Suminar, S.ST., M.Tr.Keb.

Editor: Mas Koko

ISBN: 978-623-10-9317-2

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak : Achmad Faisal

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Materi penting seputar ukom kebidanan : sesuai blueprint ukom dan KMK 320 Tahun 2020 / Sri Setiasih, S.SiT., Bdn., M.Kes., Bd. Retno Wulan, S.S.T., Keb., M.K.M., Bdn. Yulita Nengsih, S.SiT., M.Kes., Siti Rofi'ah, S.ST, M.Kes., Bdn., Ratna Suminar, S.ST., M.Tr.Keb. ; editor, Mas Koko
EDISI	Cetakan pertama, Mei 2025
PUBLIKASI	Jakarta Barat : PT. Optimal Untuk Negeri, 2025
DESKRIPSI FISIK	x, 168 halaman ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-623-10-9317-2
SUBJEK	Ilmu kebidanan - Ujian, soal, dsb.
KLASIFIKASI	618.200 76 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1216976

Prakata

Teman-teman mahasiswa kebidanan yang saya banggakan,

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan semangat dalam menempuh perjalanan panjang pendidikan kebidanan ini. Kini, tibalah teman-teman pada tahap yang sangat penting, yaitu menghadapi Uji Kompetensi Nasional (UKOMNAS), gerbang utama menuju dunia profesi kebidanan yang sesungguhnya.

Ujian ini bukan sekadar menguji pengetahuan akademik saja, namun juga kesiapan mental, tanggung jawab, serta komitmen teman-teman sebagai calon bidan yang akan berperan besar dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Setiap usaha, kerja keras, dan semangat belajar yang telah teman-teman lakukan selama ini akan menjadi bekal kuat untuk menghadapi ujian penting ini.

Jangan pernah ragu akan kemampuan diri sendiri. Percayalah bahwa setiap langkah kecil yang teman-teman lakukan hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Hadapilah ujian dengan penuh ketenangan, keyakinan, dan sikap optimis. Yakinlah bahwa hasil terbaik akan datang dari usaha maksimal yang disertai dengan doa yang tulus.

Ingatlah selalu bahwa di balik profesi kebidanan ini terdapat tanggung jawab mulia untuk menyelamatkan nyawa, menjaga kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Jadikan momentum ini sebagai awal tekadmu untuk menjadi bidan yang profesional, kompeten, penuh empati, dan berdedikasi tinggi.

Akhir kata, selamat berjuang teman-teman. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan dan semangat. Saya percaya sepenuh hati bahwa teman-teman mampu melewati ini semua dengan gemilang.

Semangat, sukses selalu, dan jadilah bidan kebanggaan bangsa!

Salam hormat

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Tips dan Trik Menghadapi UKOMNAS Kebidanan.....	1
Strategi Belajar Terstruktur Menghadapi UKOMNAS Kebidanan	5
Area 1 Etik, Legal, dan Keselamatan Kerja.....	9
A. Konsep Dasar Etik dan Kode Etik Profesi Bidan.....	9
B. Hak dan Kewajiban Pasien serta Tenaga Kesehatan	12
C. Perlindungan Hukum dan Aspek Legal Praktik Kebidanan	16
D. Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kebidanan.....	20
Area 2 Komunikasi Efektif	24
A. Teknik Komunikasi Interpersonal Terapeutik dalam Kebidanan	24
1. Konsep Dasar Komunikasi Terapeutik	24
2. Tujuan Komunikasi Terapeutik.....	24
3. Prinsip-Prinsip Komunikasi Terapeutik.....	24
4. Teknik Komunikasi Interpersonal Terapeutik.....	25
5. Hambatan Komunikasi Terapeutik.....	25
6. Strategi Mengatasi Hambatan Komunikasi.....	26
B. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas, Neonatal, dan KB	27
1. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Antenatal Care (ANC)	27
2. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Persalinan	28
3. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Nifas	28
4. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Neonatal	28
5. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	29
6. Faktor Penunjang Komunikasi Efektif dalam Kebidanan	29
7. Tantangan dan Solusi dalam Komunikasi Efektif.....	29
C. Konseling dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi.....	31
1. Pengertian Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi.....	31
2. Tujuan Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi.....	32
3. Prinsip-prinsip Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi.....	32
4. Langkah-langkah Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi.....	32
5. Teknik Konseling yang Efektif dalam KB dan Kesehatan Reproduksi	33
6. Hambatan dalam Konseling KB dan Solusinya.....	33

Area 3 Profesionalisme, Pengembangan Diri, dan Kepemimpinan ... 35

A. Profesionalisme dalam Praktik Kebidanan.....	35
1. Konsep Profesionalisme Kebidanan.....	35
2. Karakteristik Profesionalisme Bidan.....	35
3. Prinsip Profesionalisme dalam Kebidanan	35
4. Tantangan Profesionalisme dalam Praktik Kebidanan.....	36
5. Strategi Meningkatkan Profesionalisme dalam Kebidanan	36
B. Pengembangan Keilmuan Bidan (Pendidikan Berkelanjutan).....	38
1. Konsep Dasar Pendidikan Berkelanjutan dalam Kebidanan.....	38
2. Tujuan Pendidikan Berkelanjutan bagi Bidan	38
3. Bentuk-bentuk Pendidikan Berkelanjutan.....	38
4. Manfaat Pendidikan Berkelanjutan	39
5. Tantangan dalam Pendidikan Berkelanjutan.....	39
6. Strategi untuk Mengatasi Tantangan.....	39
C. Kepemimpinan dalam Manajemen Kasus Kebidanan.....	40
1. Konsep Dasar Kepemimpinan dalam Kebidanan	40
2. Karakteristik Kepemimpinan Efektif dalam Manajemen Kasus Kebidanan	41
3. Fungsi Kepemimpinan dalam Manajemen Kasus Kebidanan	41
4. Gaya Kepemimpinan dalam Praktik Kebidanan	41
5. Tantangan dalam Kepemimpinan Kasus Kebidanan	41
6. Strategi Mengatasi Tantangan Kepemimpinan	41

Area 4 Landasan Ilmiah Kebidanan..... 44

A. Anatomi, Fisiologi, dan Patologi Reproduksi Perempuan.....	44
1. Anatomi Reproduksi Perempuan.....	44
2. Fisiologi Reproduksi Perempuan	47
3. Patologi Reproduksi Perempuan.....	49
B. Proses Fisiologis dan Patofisiologis dalam Siklus Hidup Perempuan.....	52
1. Proses Fisiologis Siklus Hidup Perempuan.....	52
2. Proses Patofisiologis dalam Siklus Hidup Perempuan.....	52
3. Gangguan pada Masa Menopause	53
4. Peran Bidan dalam Proses Fisiologis dan Patofisiologis	53
C. Dasar-Dasar Epidemiologi dalam Kebidanan	54
1. Pengertian Epidemiologi.....	54
2. Tujuan Epidemiologi dalam Kebidanan	54
3. Istilah-Istilah Epidemiologi dalam Kebidanan	54
4. Metode Epidemiologi.....	55
5. Peran Bidan dalam Epidemiologi Kebidanan.....	55

D. Evidence-Based Midwifery Practice (EBM).....	57
1. Konsep Dasar EBM.....	57
2. Tujuan Evidence-Based Midwifery.....	57
3. Langkah-langkah Praktik <i>Evidence-Based Midwifery</i>	57
4. Tingkatan Bukti Ilmiah dalam EBM.....	57
5. Manfaat Evidence-Based Midwifery	58
6. Tantangan dalam Penerapan EBM.....	58

Area 5 Keterampilan Klinis Praktik Kebidanan..... 60

A. Masa Pranikah dan Prakonsepsi	60
1. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin	60
2. Persiapan Kehamilan Sehat	60
3. Skrining Penyakit Genetik	61
B. Masa Kehamilan (Antenatal Care - ANC Terpadu)	62
1. Pemeriksaan Kehamilan Fisiologis (ANC Terpadu)	62
2. Identifikasi Dini dan Tatalaksana Komplikasi Kehamilan.....	64
3. Interpretasi Hasil Pemeriksaan USG Sederhana.....	67
C. Persalinan dan Kelahiran	69
1. Asuhan Persalinan Normal.....	69
2. Manajemen Kala Persalinan I hingga IV	77
3. Penatalaksanaan Penyulit Persalinan	80
4. Deteksi dan Penanganan Gawat Janin	83
D. Masa Nifas dan Menyusui	85
1. Pemantauan Ibu Nifas Normal.....	85
2. Edukasi Menyusui (IMD dan ASI Eksklusif).....	87
3. Tatalaksana Komplikasi Nifas.....	90
E. Bayi Baru Lahir dan Neonatus.....	93
1. Penilaian APGAR Score dan Perawatan Tali Pusat	93
2. Skrining Neonatal (Pendengaran, Hipotiroid, Kelainan Kongenital).....	95
3. Penanganan Kegawatdaruratan Neonatal.....	98
F. Bayi, Anak Balita, dan Prasekolah.....	100
1. Pemantauan Tumbuh Kembang Normal.....	100
2. Imunisasi Dasar Lengkap	103
3. Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang dan Gizi Buruk.....	106
G. Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	110
1. Metode Kontrasepsi Hormonal dan Non-Hormonal	110
2. Konseling KB Postpartum.....	113
3. Tatalaksana Efek Samping Kontrasepsi (KB).....	117
4. Pencegahan dan Pengelolaan Infeksi Menular Seksual (IMS) dengan IVA dan Pap Smear	121

Area 6 Manajemen Dokumentasi Kebidanan (Metode SOAP)	125
A. Manajemen Dokumentasi Kebidanan (Metode SOAP)	125
1. Pengertian Dokumentasi Kebidanan	125
2. Tujuan Dokumentasi Kebidanan	125
3. Pengertian Metode SOAP	125
4. Penjelasan Lengkap Komponen SOAP	125
5. Prinsip Penting Dokumentasi SOAP Kebidanan	127
6. Manfaat Dokumentasi SOAP dalam Praktik Kebidanan	127
7. Peran Bidan dalam Manajemen Dokumentasi Kebidanan	127
B. Sistem Rujukan Efektif dalam Pelayanan Kebidanan.....	128
1. Pengertian Sistem Rujukan dalam Kebidanan.....	128
2. Tujuan Sistem Rujukan Efektif.....	128
3. Prinsip Sistem Rujukan Efektif dalam Kebidanan.....	129
4. Kriteria Indikasi Rujukan dalam Pelayanan Kebidanan.....	129
5. Jenis-jenis Sistem Rujukan	129
6. Alur dan Prosedur Rujukan Efektif dalam Kebidanan	130
7. Dokumen Penting dalam Rujukan Kebidanan	130
8. Peran Bidan dalam Sistem Rujukan Efektif.....	130
C. Manajemen Kualitas dalam Pelayanan Kebidanan (Audit Klinik dan Evaluasi Pelayanan)	132
1. Pengertian Manajemen Kualitas Pelayanan Kebidanan	132
2. Tujuan Manajemen Kualitas dalam Kebidanan.....	132
3. Komponen Utama Manajemen Kualitas Kebidanan.....	132
4. Audit Klinik dalam Pelayanan Kebidanan	133
5. Evaluasi Pelayanan dalam Kebidanan.....	133
6. Indikator Evaluasi Mutu Pelayanan Kebidanan.....	134
7. Strategi Meningkatkan Manajemen Kualitas dalam Kebidanan.....	134
8. Peran Bidan dalam Manajemen Kualitas	134
 Area 7 Pengabdian Masyarakat dan Promosi Kesehatan	 136
A. Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja.....	136
1. Pengertian Kesehatan Reproduksi Remaja.....	136
2. Tujuan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	136
3. Ruang Lingkup Materi Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja.....	136
4. Strategi Edukasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja	137
5. Peran Bidan dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	137
6. Tantangan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja.....	137
7. Cara Mengatasi Tantangan Edukasi Reproduksi Remaja	137

8. Indikator Keberhasilan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja.....	138
B. Promosi Kesehatan Ibu dan Anak dalam Masyarakat.....	139
1. Pengertian Promosi Kesehatan Ibu dan Anak	139
2. Tujuan Promosi Kesehatan Ibu dan Anak.....	139
3. Ruang Lingkup Promosi Kesehatan Ibu dan Anak.....	140
4. Strategi Promosi Kesehatan Ibu dan Anak.....	140
5. Media Promosi Kesehatan Ibu dan Anak	141
6. Peran Bidan dalam Promosi Kesehatan Ibu dan Anak.....	141
7. Tantangan Promosi Kesehatan Ibu dan Anak di Masyarakat ..	141
8. Cara Mengatasi Tantangan Promosi Kesehatan Ibu dan Anak.	141
C. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.....	143
1. Pengertian Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.....	143
2. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.....	143
3. Dampak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.....	143
4. Faktor Risiko Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.....	143
5. Strategi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.....	144
6. Peran Bidan dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	144
7. Lembaga dan Pelayanan yang Dapat Diakses Korban.....	144
Area 8 Farmakologi Kebidanan	147
A. Penggunaan Obat Uterotonika (Oksitosin, Methergin, Misoprostol)	147
1. Pengertian Uterotonika	147
2. Jenis dan Mekanisme Kerja Uterotonika.....	147
3. Prinsip Penggunaan Uterotonika dalam Praktik Kebidanan....	148
4. Peran Bidan dalam Penggunaan Uterotonika.....	149
B. Tokolitik dan Analgesik dalam Kebidanan.....	150
1. Tokolitik Dalam Kebidanan	150
2. Analgesik Dalam Kebidanan	151
3. Peran Bidan dalam Penggunaan Tokolitik dan Analgesik.....	152
C. Manajemen Infeksi dalam Kebidanan.....	153
1. Pengertian Manajemen Infeksi dalam Kebidanan	153
2. Tujuan Manajemen Infeksi dalam Kebidanan.....	153
3. Infeksi yang Sering Terjadi dalam Kebidanan	154
4. Pencegahan Infeksi dalam Kebidanan.....	154
5. Penatalaksanaan Infeksi dalam Kebidanan (Kolaborasi dengan Dokter).....	154

6. Edukasi Pasien tentang Pencegahan Infeksi.....	155
7. Peran Bidan dalam Manajemen Infeksi	155
Area 9 Kegawatdaruratan dalam Praktik Kebidanan.....	158
A. Penanganan Kasus Syok Hipovolemik, Syok Septik, dan Emboli	
Air Ketuban.....	158
1. Syok Hipovolemik dalam Kebidanan	158
2. Syok Septik dalam Kebidanan.....	159
3. Emboli Air Ketuban dalam Kebidanan	159
4. Peran Bidan dalam Penanganan Kegawatdaruratan	
Kebidanan.....	160
B. Teknik Resusitasi Neonatus (RJP Neonatus)	162
1. Pengertian Resusitasi Neonatus	162
2. Tujuan Resusitasi Neonatus	162
3. Indikasi Resusitasi Neonatus	162
4. Langkah-Langkah Resusitasi Neonatus (Algoritma WHO)	162
5. Peran Bidan dalam Resusitasi Neonatus.....	163
6. Peralatan yang Dibutuhkan dalam Resusitasi Neonatus	163
7. Komplikasi dari Resusitasi Neonatus yang Tidak Tepat.....	163
8. Dokumentasi yang Harus Dilakukan oleh Bidan	163
Daftar Pustaka.....	166

Tips dan Trik Menghadapi UKOMNAS Kebidanan

Uji Kompetensi Nasional (UKOMNAS) merupakan tahap penting bagi mahasiswa kebidanan untuk mendapatkan lisensi praktik. Berikut ini tips dan trik mendetail agar Anda berhasil lulus dengan optimal.

1. Persiapan Materi Secara Terstruktur

a. Buat Jadwal Belajar yang Teratur

- Susun jadwal harian yang jelas.
- Fokuskan waktu lebih banyak pada materi yang paling sulit bagi Anda.

b. Identifikasi Kompetensi Inti

- Kuasai kompetensi utama dalam kebidanan:
 - ✓ Asuhan antenatal, intranatal, postnatal
 - ✓ Penanganan kegawatdaruratan obstetri
 - ✓ Asuhan neonatus dan bayi baru lahir
 - ✓ Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
 - ✓ Etika dan hukum dalam praktik kebidanan

c. Gunakan Teknik Belajar Aktif

- Mind mapping, summary notes, dan flashcards.
- Diskusi kelompok rutin untuk memperdalam pemahaman.

2. Pahami Pola Soal Ujian UKOMNAS

a. Kenali Bentuk Soal

- Pilihan ganda dengan 5 opsi jawaban.
- Soal berbasis studi kasus klinis.

b. Strategi Menjawab Soal

- Baca pertanyaan dengan hati-hati, fokus pada kata kunci (misal: "paling tepat," "tindakan awal").
- Gunakan metode eliminasi: hilangkan opsi jawaban yang jelas salah terlebih dahulu.
- Jika ragu, pilih jawaban yang sesuai prinsip asuhan berbasis bukti (EBM).

3. Kuasai Metode "Critical Thinking" dalam Studi Kasus

a. Langkah Menjawab Studi Kasus

- Identifikasi masalah utama.
- Analisis data klinis dan temukan korelasinya.
- Prioritaskan tindakan berdasarkan kegawatdaruratan, kebutuhan fisiologis pasien, atau aspek keselamatan.
- Evaluasi opsi tindakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

b. Contoh Pendekatan

• Kasus perdarahan postpartum:

Fokus utama pada stabilisasi hemodinamik (resusitasi cairan, manajemen aktif kala III, pemberian uterotonika).

4. Penguasaan Skill Praktik Klinis

a. Praktikkan Secara Rutin

- Keterampilan pemeriksaan fisik obstetri (Leopold, pengukuran tinggi fundus uteri, DJJ).
- Keterampilan penanganan persalinan normal dan kegawatdaruratan obstetri (distosia bahu, resusitasi neonatus, perdarahan postpartum).

b. Gunakan OSCE (Objective Structured Clinical Examination)

- Berlatih dengan simulasi OSCE secara rutin.
- Gunakan checklists untuk memastikan setiap langkah sudah terpenuhi.

5. Latihan dan Evaluasi Secara Berkala

a. Latihan Soal secara Konsisten

- Gunakan bank soal UKOMNAS dari sumber terpercaya.
- Ikuti Try Out secara teratur.

b. Evaluasi dan Feedback

- Catat hasil latihan, evaluasi kesalahan, dan pahami alasannya.
- Diskusikan kesalahan dengan dosen atau mentor untuk mendapatkan *feedback* langsung.

6. Kiat Manajemen Waktu Saat Ujian

a. Strategi Mengatur Waktu

- Hitung alokasi waktu per soal (misal: 180 menit untuk 180 soal = 1 menit per soal).
- Kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu, jangan terjebak terlalu lama pada satu soal.

b. Review Singkat di Akhir

- Sisakan 10-15 menit untuk mereview jawaban Anda secara cepat.

7. Persiapan Mental dan Fisik yang Baik

a. Jaga Kesehatan Mental dan Emosional

- Kelola stres dengan teknik relaksasi, seperti deep breathing, meditasi, atau yoga.
- Hindari belajar secara berlebihan pada malam sebelum ujian.

b. Kondisi Fisik Optimal

- Istirahat cukup minimal 7-8 jam sebelum ujian.
- Sarapan ringan dan sehat untuk menjaga stamina dan konsentrasi.

8. Tips Khusus untuk Hari H Ujian

- a. Datang lebih awal untuk adaptasi lokasi ujian.
- b. Pastikan dokumen yang diperlukan lengkap (KTP, kartu peserta, alat tulis).
- c. Jangan panik saat menemui soal yang sulit; tenangkan diri, lalu lanjutkan ke soal berikutnya terlebih dahulu.

9. Gunakan Sumber Referensi yang Kredibel

- a. Buku teks utama kebidanan (Sarwono Prawirohardjo, Varney's Midwifery, dll.)
- b. Panduan atau pedoman resmi dari organisasi profesi (IBI, WHO, Kemenkes RI).
- c. Akses jurnal ilmiah dan artikel terbaru sebagai referensi tambahan.

10. Doa dan Dukungan Keluarga

- a. Jangan remehkan dukungan emosional dari keluarga dan teman.
- b. Berdoa dan yakin bahwa usaha maksimal yang Anda lakukan akan membuahkan hasil terbaik.

Checklist Kesiapan UKOMNAS

☒	PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN
☐	Jadwal belajar teratur
☐	Kuasai kompetensi inti
☐	Kenali pola soal ujian
☐	Latihan soal secara rutin
☐	Latihan skill klinis secara berkala
☐	Persiapan mental dan fisik
☐	Dokumen ujian sudah lengkap
☐	Manajemen waktu saat ujian
☐	Referensi dan sumber belajar terpercaya
☐	Doa dan support system keluarga

Strategi Belajar Terstruktur Menghadapi UKOMNAS Kebidanan

Belajar secara terstruktur adalah kunci utama dalam mencapai keberhasilan di Uji Kompetensi Nasional Kebidanan. Dengan metode belajar yang sistematis, mahasiswa dapat mengelola waktu, materi, dan energi secara efisien.

1. Tetapkan Tujuan dan Target Jelas

a. Tujuan Belajar:

- Lulus UKOMNAS dengan nilai optimal.
- Menguasai kompetensi praktik kebidanan secara menyeluruh.

b. Target Spesifik:

- Target harian: Materi yang akan dikuasai tiap harinya.
- Target mingguan: Evaluasi kemajuan belajar setiap minggu.
- Target bulanan: Menguasai keseluruhan kompetensi inti sebelum ujian.

2. Buat Jadwal Belajar yang Realistis

WAKTU	KEGIATAN	MATERI
05.00 - 06.00	Review materi sebelumnya	Konsep dasar kebidanan
09.00 - 11.00	Belajar materi inti	Asuhan antenatal, intranatal, postnatal
13.00 - 15.00	Latihan soal atau try out	Soal UKOMNAS tahun-tahun sebelumnya
19.00 - 20.30	Diskusi kelompok	Studi kasus atau review soal sulit
21.00 - 22.00	Evaluasi dan catat progres belajar	Refleksi hasil belajar harian

- Istirahat singkat tiap 50 menit belajar.
- Hari Minggu digunakan untuk evaluasi dan review ulang materi seminggu.

3. Prioritaskan Materi dengan Teknik ABC

Bagilah materi berdasarkan tingkat prioritas:

a. Kategori A (Wajib kuasai sempurna):

- Kegawatdaruratan obstetri (preeklamsia, perdarahan postpartum, distosia, asfiksia neonatus).
- Asuhan antenatal, intranatal, postnatal fisiologis dan patologis.

b. Kategori B (Penting tapi lebih mudah):

- KB dan kesehatan reproduksi.
- Tumbuh kembang anak, imunisasi dasar.

c. Kategori C (Pelengkap):

- Aspek etika dan legal kebidanan.
- Komunikasi terapeutik.

4. Gunakan Teknik Belajar yang Efektif

a. Mind Mapping

- Visualisasi konsep penting dalam satu halaman.
- Mudah diingat karena melibatkan gambar dan warna.

Contoh topik mind map:

- Tahap persalinan fisiologis.
- Penanganan perdarahan postpartum.

b. Teknik Pomodoro

- Belajar 25 menit fokus, lalu istirahat 5 menit.
- Setelah 4 sesi, istirahat panjang selama 15-20 menit.

c. Flashcards

- Cocok untuk menghafal istilah medis, definisi, atau SOP.
- Buat kartu kecil dengan ringkasan poin-poin penting materi.

5. Optimalisasi Diskusi Kelompok

- Diskusi rutin seminggu 2-3 kali.
- Setiap sesi diskusi maksimal 1-2 jam dengan fokus topik tertentu.
- Bergiliran membuat presentasi mini untuk memperdalam pemahaman.

Topik diskusi yang dianjurkan:

- Studi kasus kebidanan dan penatalaksanaannya.
- Analisis soal-soal sulit dari try out sebelumnya.

6. Strategi Khusus dalam Menjawab Soal

• Metode Eliminasi:

Langsung hapus opsi yang jelas salah, kemudian bandingkan opsi yang tersisa.

- **Kata Kunci:**
Fokus pada kata-kata kunci seperti "kecuali", "utama", "prioritas", "segera".
- **Aspek Keselamatan Pasien:**
Jika ragu, pilih jawaban yang paling aman dan sesuai standar praktik kebidanan.

7. Gunakan Sumber Belajar Terpercaya

- Buku teks utama kebidanan terbaru (misalnya Sarwono Prawirohardjo, Varney's Midwifery).
- Panduan resmi (misalnya dari IBI, Kementerian Kesehatan RI).
- Bank soal resmi UKOMNAS yang telah diakui kredibilitasnya.

8. Evaluasi dan Catat Kemajuan Belajar

- Catat setiap *progress* dalam jurnal belajar.
- Tulis materi yang sudah dikuasai dan yang masih sulit.
- Lakukan review mingguan untuk menyesuaikan metode belajar selanjutnya.

Contoh Jurnal Evaluasi Belajar:

MATERI	SUDAH DIKUASAI	BELUM DIKUASAI	CATATAN PERBAIKAN
Manajemen Kala III	✓		
Asfiksia Neonatus		✗	Perlu review SOP RJP

9. Latihan Simulasi Ujian Rutin

- Lakukan try out minimal 1 kali seminggu.
- Simulasikan kondisi ujian sungguhan:
 - Waktu sesuai durasi ujian.
 - Tanpa akses buku, catatan, atau internet.
 - Evaluasi hasil dan diskusikan bersama dosen atau mentor.

10. Jaga Keseimbangan Hidup

- Tidur cukup 7-8 jam per hari.
- Nutrisi yang baik dan minum cukup air.
- Luangkan waktu untuk relaksasi dan olahraga ringan setiap hari (minimal 30 menit).

Checklist Strategi Belajar Terstruktur

Gunakan *checklist* ini untuk memastikan semua strategi sudah diterapkan secara teratur:

☒	AKTIVITAS BELAJAR TERSTRUKTUR
☐	Tujuan dan target jelas
☐	Jadwal belajar realistis
☐	Materi sudah dikelompokkan (ABC)
☐	Mind mapping rutin
☐	Teknik Pomodoro digunakan
☐	Flashcards dibuat dan dipakai
☐	Diskusi kelompok rutin
☐	Evaluasi kemajuan mingguan
☐	Try out rutin minimal mingguan
☐	Jurnal evaluasi belajar diisi
☐	Pola hidup sehat tetap terjaga

Area 1

Etik, Legal, dan Keselamatan Kerja

A. Konsep Dasar Etik dan Kode Etik Profesi Bidan

Etik adalah prinsip moral yang menjadi pedoman tindakan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan. Kode etik profesi bidan merupakan pedoman moral dalam menjalankan tugas profesional bidan.

Terdapat 7 prinsip etik utama dalam praktik kebidanan:

1. *Autonomy*

Menghormati hak pasien mengambil keputusan kesehatan secara mandiri berdasarkan informasi lengkap.

Contoh implementasi:

- Memberikan informasi lengkap sebelum tindakan (informed consent).
- Menghormati keputusan pasien yang menolak tindakan medis.

2. *Beneficence* (Berbuat Baik)

Melakukan tindakan yang memberi manfaat optimal bagi pasien.

Contoh implementasi:

- Memberikan pelayanan ANC sesuai standar agar ibu dan janin sehat.
- Memberi konseling gizi untuk ibu hamil.

3. *Non-maleficence* (Tidak Merugikan)

Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pasien.

Contoh implementasi:

- Menjaga sterilisasi alat untuk mencegah infeksi.
- Menghindari tindakan medis yang tidak diperlukan secara medis.

4. *Justice* (Keadilan)

Memberikan pelayanan adil, setara, tanpa diskriminasi.

Contoh implementasi:

- Memberikan pelayanan yang setara kepada semua pasien.
- Tidak membedakan pasien berdasarkan status sosial, ekonomi, ras, agama.

5. **Confidentiality (Kerahasiaan)**

Menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan medis pasien.

Contoh implementasi:

- Menyimpan rekam medis secara aman dan rahasia.
- Tidak memberikan informasi pasien tanpa persetujuan pasien.

6. **Veracity (Kejujuran)**

Memberikan informasi yang akurat, jujur, jelas kepada pasien.

Contoh implementasi:

- Menjelaskan kondisi kesehatan secara transparan.
- Menjelaskan risiko dan manfaat tindakan medis secara jujur.

7. **Fidelity (Kesetiaan)**

Menjaga komitmen profesional dalam pelayanan kebidanan.

Contoh implementasi:

- Melaksanakan tugas sesuai standar profesi.
- Menjalin kerjasama baik dengan tenaga kesehatan lain.

Ringkasan Prinsip Etik Praktik Kebidanan

NO.	PRINSIP ETIK	MAKNA INTI
1.	Autonomi	Menghormati keputusan pasien
2.	Beneficence	Berbuat baik dan memberikan manfaat
3.	Non-maleficence	Tidak melakukan tindakan yang merugikan pasien
4.	Justice	Memberikan pelayanan secara adil dan setara
5.	Confidentiality	Menjaga kerahasiaan pasien
6.	Veracity	Memberikan informasi secara jujur dan jelas
7.	Fidelity	Menjaga komitmen dan tanggung jawab profesi

Contoh Kasus Penerapan Prinsip Etik dalam UKOM:

Seorang pasien menolak pemeriksaan panggul karena rasa takut. Apa yang harus dilakukan bidan secara etik?

Jawaban:

Bidan harus menghormati keputusan pasien (*autonomy*), memberikan informasi jujur mengenai manfaat dan risikonya (*veracity*), menawarkan alternatif pemeriksaan lain yang nyaman bagi pasien (*beneficence*), dan menghindari tindakan pemaksaan yang bisa merugikan pasien (*non-maleficence*).

PERTANYAAN:**Soal 1:**

Seorang bidan menghadapi seorang pasien yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan dalam, meskipun prosedur tersebut penting untuk memastikan kondisi kehamilannya.

Prinsip etik apakah yang harus diutamakan oleh bidan dalam situasi ini?

- A. *Beneficence* (berbuat baik)
- B. *Justice* (keadilan)
- C. *Autonomy* (menghormati keputusan pasien)
- D. *Fidelity* (kesetiaan)
- E. *Confidentiality* (kerahasiaan)

Soal 2:

Seorang bidan mendapat informasi sensitif tentang seorang pasien yang mengalami kekerasan rumah tangga. Pasien memohon agar informasi ini dirahasiakan.

Berdasarkan prinsip etik profesi bidan, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan bidan?

- A. Segera melaporkan kepada keluarga pasien
- B. Menginformasikan kepada masyarakat sekitar agar pasien mendapatkan dukungan
- C. Menjaga kerahasiaan informasi kecuali ada kewajiban hukum yang mengharuskan melapor
- D. Memberitahukan kepada pimpinan klinik agar dapat ditindaklanjuti segera
- E. Menghubungi pihak kepolisian tanpa sepengetahuan pasien

Soal 3:

Seorang bidan dihadapkan pada situasi sulit dalam mengambil keputusan karena pasiennya mengalami komplikasi serius saat persalinan.

Prinsip etik apakah yang harus digunakan sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan medis tertentu?

- A. Non-maleficence (tidak merugikan)
- B. Veracity (kejujuran)
- C. Justice (keadilan)
- D. Fidelity (kesetiaan)
- E. Autonomi (menghormati keputusan pasien)

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar C

Pembahasan:

Prinsip etik **autonomy** menegaskan bahwa pasien memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri mengenai tindakan medis yang akan diterimanya setelah mendapat informasi yang jelas. Dalam kasus ini, bidan harus menghormati keputusan pasien tersebut, meskipun pasien menolak pemeriksaan.

Soal 2: Jawaban benar C

Pembahasan:

Prinsip etik **confidentiality (kerahasiaan)** mengharuskan bidan untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi pasien, kecuali ada kewajiban hukum atau kondisi tertentu yang mengharuskan informasi tersebut diungkapkan.

Soal 3: Jawaban benar A

Pembahasan:

Dalam situasi kritis dimana ada risiko komplikasi serius, prinsip **non-maleficence** harus menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan medis, yaitu memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak menimbulkan kerugian atau memperburuk kondisi pasien.

B. Hak dan Kewajiban Pasien serta Tenaga Kesehatan

Memahami hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan sangat penting dalam pelayanan kesehatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan melindungi kedua belah pihak secara hukum dan etika.

1. Hak Pasien

Setiap pasien memiliki hak sebagai berikut:

- a. **Hak atas Informasi (*Informed Consent*)**
Pasien berhak menerima informasi lengkap, jelas, akurat, dan mudah dipahami tentang kondisi kesehatannya, tindakan medis yang akan diberikan, serta risiko dan manfaatnya.
- b. **Hak atas Pelayanan yang Aman dan Berkualitas**
Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, bermutu tinggi, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi.
- c. **Hak Privasi dan Kerahasiaan**
Pasien berhak atas privasi selama menjalani perawatan medis serta jaminan kerahasiaan data pribadi dan rekam medisnya.
- d. **Hak Menolak atau Menghentikan Pengobatan**
Pasien berhak menolak atau menghentikan tindakan medis tertentu setelah memperoleh informasi yang cukup tentang konsekuensi keputusan tersebut.
- e. **Hak Mendapatkan Pendampingan**
Pasien berhak mendapat dukungan emosional atau pendampingan selama proses pelayanan kesehatan.
- f. **Hak Mendapatkan Pelayanan Darurat**
Pasien berhak mendapatkan pelayanan medis dalam kondisi darurat tanpa harus mempertimbangkan aspek administratif terlebih dahulu.

2. Kewajiban Pasien

Selain hak, pasien juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi:

- a. **Memberikan Informasi yang Jujur dan Lengkap**
Pasien wajib memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan akurat tentang riwayat kesehatan, gejala, dan kondisi lainnya yang relevan.
- b. **Mematuhi Aturan Pelayanan Kesehatan**
Pasien wajib mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku di fasilitas kesehatan.
- c. **Menghormati Hak Tenaga Kesehatan dan Pasien Lain**
Pasien wajib menghormati hak-hak tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan, serta menjaga ketertiban dan kenyamanan pasien lainnya.
- d. **Melunasi Kewajiban Administratif**
Pasien wajib memenuhi kewajiban administratif seperti pembayaran biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan.

3. Hak Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. **Perlindungan Hukum**
Berhak mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan tugas profesinya secara profesional dan sesuai standar.
- b. **Lingkungan Kerja yang Aman dan Nyaman**
Berhak bekerja dalam lingkungan yang aman, sehat, nyaman, dan kondusif.
- c. **Kompensasi yang Adil dan Layak**
Berhak menerima kompensasi yang layak dan adil sesuai dengan jasa dan kompetensi profesinya.
- d. **Pengembangan Kompetensi**
Berhak mendapatkan akses terhadap pelatihan, pendidikan berkelanjutan, serta pengembangan kompetensi profesional.

4. Kewajiban Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. **Memberikan Pelayanan Profesional**
Wajib memberikan pelayanan sesuai standar kompetensi profesi, kode etik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. **Menjaga Kerahasiaan Pasien**
Wajib menjaga kerahasiaan informasi medis dan data pribadi pasien.
- c. **Menghormati Keputusan Pasien**
Wajib menghormati hak pasien dalam mengambil keputusan terkait pelayanan kesehatan yang diberikan.
- d. **Memberikan Informasi Jelas dan Transparan**
Wajib memberikan informasi yang jelas, lengkap, akurat, dan mudah dipahami tentang kondisi pasien, tindakan medis, risiko, serta manfaatnya.
- e. **Bekerja Sama Secara Harmonis**
Wajib menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan rekan sejawat, tenaga kesehatan lain, serta pasien demi terciptanya pelayanan yang optimal.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Seorang pasien datang ke klinik kebidanan dan ingin mengetahui secara detail kondisi kehamilannya.

Sebagai seorang bidan, hak pasien apakah yang wajib Anda penuhi dalam situasi ini?

- A. Hak atas kerahasiaan informasi
- B. Hak untuk mendapatkan informasi lengkap (*informed consent*)
- C. Hak atas pendampingan keluarga
- D. Hak untuk menolak tindakan medis
- E. Hak mendapatkan pelayanan darurat

Soal 2:

Seorang ibu datang untuk pemeriksaan ANC, namun tidak kooperatif dalam memberikan informasi riwayat kesehatan sebelumnya kepada bidan.

Tindakan yang tepat sebagai bidan dalam mengingatkan kewajiban pasien tersebut adalah:

- A. Membiarkan pasien karena itu adalah hak pasien untuk tidak memberikan informasi
- B. Menolak memberikan pelayanan kepada pasien
- C. Menjelaskan secara santun bahwa pasien wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur demi keselamatan pasien sendiri
- D. Memaksa pasien untuk mengungkapkan informasi secara langsung
- E. Meminta keluarga pasien untuk memberikan informasi tentang pasien tanpa persetujuan pasien

Soal 3:

Seorang bidan di klinik merasa bahwa lingkungannya kurang nyaman dan aman dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Berdasarkan hak tenaga kesehatan, tindakan apa yang paling tepat dilakukan oleh bidan tersebut?

- A. Memutuskan untuk mengurangi kualitas pelayanan
- B. Mengabaikan kondisi lingkungan kerja dan tetap bekerja seperti biasa
- C. Menyampaikan keluhan kepada atasan untuk perbaikan kondisi kerja
- D. Berhenti memberikan pelayanan sampai kondisi diperbaiki
- E. Mengadu kepada pasien terkait ketidaknyamanan tersebut

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar B

Pembahasan:

Hak pasien atas informasi lengkap (informed consent) mewajibkan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat mengenai kondisi kesehatan dan tindakan medis yang akan diberikan.

Soal 2: Jawaban benar C

Pembahasan:

Kewajiban pasien adalah memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan akurat tentang kondisi kesehatannya demi keselamatan dan kualitas pelayanan. Bidan harus menjelaskan kewajiban tersebut dengan pendekatan yang santun dan persuasif.

Soal 3: Jawaban benar C

Pembahasan:

Tenaga kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif. Oleh karena itu, langkah yang paling tepat adalah menyampaikan keluhan tersebut kepada atasan atau manajemen klinik untuk mendapatkan solusi terbaik demi kualitas pelayanan.

C. Perlindungan Hukum dan Aspek Legal Praktik Kebidanan

Memahami perlindungan hukum dan aspek legal dalam praktik kebidanan sangat penting untuk menjamin keamanan pasien, tenaga kesehatan, serta menciptakan praktik profesional sesuai standar hukum yang berlaku.

1. Landasan Hukum Praktik Kebidanan

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam praktik kebidanan:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Mengatur kewenangan, tugas, tanggung jawab, serta perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, termasuk bidan.

b. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Mengatur tentang persyaratan, perizinan, dan kewajiban yang harus dipenuhi bidan dalam menjalankan praktik kebidanan.

c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan

Menentukan standar kompetensi profesional yang wajib dipenuhi oleh bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Bidan

a. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

- Setiap bidan wajib memiliki SIPB yang sah sebelum menjalankan praktik.
- SIPB merupakan bukti legalitas yang memberikan perlindungan hukum bagi bidan.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

- SOP menjadi pedoman wajib dalam menjalankan pelayanan kebidanan.
- Kepatuhan terhadap SOP dapat mengurangi risiko kesalahan praktik dan tuntutan hukum.

c. Rekam Medis (SOAP)

- Dokumentasi asuhan kebidanan harus dilakukan secara sistematis dan lengkap dengan format Subjektif, Objektif, Analisis, Plan (SOAP).
- Rekam medis merupakan bukti hukum penting yang digunakan saat menghadapi masalah hukum.

d. *Informed Consent*

- Pasien harus diberi informasi lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.
- Persetujuan pasien yang terdokumentasi merupakan bukti perlindungan hukum.

3. Aspek Legal Penting dalam Praktik Kebidanan

a. *Informed Consent*

- Merupakan persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien setelah menerima penjelasan lengkap.
- Harus didokumentasikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pasien atau wali.

b. Dokumentasi Medis (SOAP)

- Merupakan kewajiban hukum dan profesional.
- Dokumentasi yang akurat dapat melindungi bidan dari tuduhan malapraktik.

c. Surat Rujukan

- Merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pasien telah dirujuk ke fasilitas kesehatan lain yang lebih kompeten.
- Harus didokumentasikan dengan jelas, lengkap, dan disertai alasan medis yang jelas.

4. Penyebab Umum Terjadinya Masalah Hukum dalam Praktik Kebidanan

- a. Tidak adanya informed consent yang jelas dan terdokumentasi.
- b. Pelanggaran terhadap SOP dalam praktik kebidanan.
- c. Dokumentasi rekam medis yang tidak lengkap atau tidak akurat.
- d. Kesalahan komunikasi antara bidan dengan pasien atau antar tenaga kesehatan.

5. Upaya Pencegahan Masalah Hukum

- a. Patuh pada SOP dan standar profesi kebidanan.
- b. Melakukan dokumentasi medis yang lengkap dan akurat.
- c. Melakukan komunikasi efektif menggunakan metode SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*).
- d. Rutin mengikuti pelatihan hukum dan manajemen risiko kebidanan.

6. Langkah Hukum Bila Terjadi Masalah dalam Praktik Kebidanan

- a. Mengumpulkan bukti dokumentasi yang akurat dan lengkap.
- b. Segera melaporkan kepada organisasi profesi atau institusi terkait.
- c. Menjalinkan komunikasi yang transparan dan terbuka dengan pasien atau pihak keluarga.
- d. Konsultasi dengan tenaga hukum atau organisasi profesi untuk bantuan hukum.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Seorang bidan akan melakukan tindakan pemeriksaan dalam kepada pasien hamil. Sebelum tindakan tersebut, bidan memberikan penjelasan secara detail tentang prosedur, manfaat, serta risikonya, dan meminta pasien menandatangani dokumen persetujuan.

Aspek legal apakah yang telah dilakukan bidan dalam kasus ini?

- A. Melaksanakan rekam medis (SOAP)
- B. Menggunakan prinsip kerahasiaan pasien
- C. Menjalankan prosedur informed consent
- D. Mengeluarkan surat rujukan
- E. Memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

Soal 2:

Seorang bidan diminta memberikan pelayanan kebidanan di sebuah desa terpencil. Sebelum praktik, bidan memastikan bahwa ia telah memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) yang sah.

- Kepemilikan SIPB dalam kasus ini secara hukum bertujuan untuk
- A. Menjamin bahwa bidan memiliki standar kompetensi yang sesuai
 - B. Memastikan bahwa bidan mendapat gaji yang layak
 - C. Meningkatkan reputasi pribadi bidan di masyarakat
 - D. Menghindari persaingan antar bidan dalam wilayah tersebut
 - E. Memberikan kewenangan untuk meresepkan obat secara bebas

Soal 3:

Setelah melakukan tindakan pertolongan persalinan, bidan melakukan dokumentasi secara sistematis menggunakan format Subjektif, Objektif, Analisis, dan Plan (SOAP).

Fungsi utama dokumentasi tersebut dalam aspek hukum praktik kebidanan adalah

- A. Sebagai bukti kompetensi untuk kenaikan jabatan
- B. Sebagai bentuk pelaporan kepada masyarakat
- C. Sebagai syarat administratif di fasilitas kesehatan
- D. Sebagai alat bukti dalam menghadapi potensi masalah hukum
- E. Sebagai informasi untuk keperluan statistik Kesehatan

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar C

Pembahasan:

Bidan telah menjalankan prosedur *informed consent*, yaitu memberikan penjelasan lengkap kepada pasien tentang tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk manfaat dan risiko, serta mendapatkan persetujuan pasien secara tertulis.

Soal 2: Jawaban benar A

Pembahasan:

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) merupakan bukti legal bahwa bidan telah memenuhi standar kompetensi profesional sehingga berhak memberikan pelayanan kebidanan secara resmi dan terlindungi secara hukum.

Soal 3: Jawaban benar D

Pembahasan:

Dokumentasi SOAP merupakan kewajiban hukum dan berfungsi sebagai bukti yang kuat apabila terjadi tuntutan hukum atau perselisihan yang melibatkan tindakan medis yang dilakukan bidan.

D. Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kebidanan

Manajemen risiko merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengurangi, atau mengendalikan potensi risiko dalam praktik kebidanan. Hal ini sangat penting untuk memastikan keselamatan pasien, meningkatkan kualitas pelayanan, serta melindungi tenaga kesehatan dari risiko hukum.

1. Konsep Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya yang terstruktur untuk mengenali, menganalisis, mengatasi, dan mengevaluasi risiko potensial yang bisa terjadi selama pemberian pelayanan kebidanan.

2. Tujuan Manajemen Risiko dalam Kebidanan

- a. Menjamin keselamatan pasien dan tenaga kesehatan.
- b. Mengurangi risiko komplikasi atau kejadian tidak diinginkan.
- c. Meningkatkan kualitas asuhan kebidanan.
- d. Melindungi tenaga kesehatan dari tuntutan hukum akibat kesalahan praktik.

3. Langkah-Langkah Manajemen Risiko

- a. Identifikasi Risiko
Mengenali risiko potensial yang mungkin muncul dalam pelayanan kebidanan seperti infeksi, kesalahan medis, atau kegagalan komunikasi.
- b. Analisis Risiko
Menilai tingkat keparahan risiko dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut.
- c. Pengendalian Risiko
Melakukan tindakan preventif atau korektif guna mengurangi atau menghilangkan risiko yang sudah diidentifikasi.
- d. Evaluasi Risiko
Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap efektivitas pengendalian risiko.

4. Jenis Risiko dalam Praktik Kebidanan dan Pencegahannya

- a. Risiko Infeksi
 - Penyebab: Alat medis tidak steril, prosedur higienis yang tidak optimal.
 - Pencegahan: Melakukan sterilisasi alat, menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), dan menjaga kebersihan tangan (*hand hygiene*).
- b. Risiko Perdarahan Postpartum
 - Penyebab: Manajemen aktif kala III yang tidak tepat.
 - Pencegahan: Mengikuti SOP persalinan, pemberian uterotonika secara tepat waktu, dan observasi ketat pascapersalinan.

- c. Risiko Kesalahan Pemberian Obat
 - Penyebab: Human error, kelalaian, komunikasi yang tidak jelas.
 - Pencegahan: Menggunakan prinsip five rights (benar pasien, obat, dosis, waktu, cara pemberian) serta melakukan double-check sebelum memberikan obat.
- d. Risiko Kesalahan Komunikasi
 - Penyebab: Informasi yang tidak lengkap atau keliru.
 - Pencegahan: Menggunakan metode komunikasi SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) secara konsisten.

5. Strategi Meningkatkan Keberhasilan Manajemen Risiko

- a. Pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan mengenai manajemen risiko.
- b. Penyusunan SOP yang jelas, mudah dipahami, dan selalu diperbarui.
- c. Audit klinik secara berkala untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko.
- d. Penguatan budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*).

6. Dokumentasi dalam Manajemen Risiko

- a. Rekam Medis (SOAP)
Sebagai bukti hukum dan dokumentasi medis yang lengkap.
- b. *Informed Consent*
Sebagai dokumen persetujuan tindakan medis yang dapat melindungi bidan dari risiko hukum.
- c. Surat Rujukan
Sebagai dokumentasi resmi tindakan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih kompeten.

7. Tindakan yang Harus Dilakukan jika Terjadi Kejadian Tidak Diinginkan

- a. Segera tangani pasien sesuai SOP dan kondisi klinis.
- b. Laporkan kejadian kepada tim manajemen atau atasan.
- c. Dokumentasikan kejadian secara jelas dan lengkap.
- d. Evaluasi penyebab kejadian dan buat rekomendasi perbaikan agar tidak terulang.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Seorang bidan sedang melakukan tindakan persalinan. Setelah bayi lahir, terjadi perdarahan postpartum.

Untuk mencegah risiko komplikasi lebih lanjut, tindakan manajemen risiko yang tepat untuk segera dilakukan oleh bidan adalah:

- A. Melakukan dokumentasi dengan format SOAP
- B. Melakukan sterilisasi alat secara cepat
- C. Melakukan manajemen aktif kala III dengan pemberian uterotonika
- D. Melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi secara langsung tanpa intervensi
- E. Menjelaskan risiko perdarahan kepada keluarga pasien

Soal 2:

Bidan mencatat bahwa beberapa pasien mengalami keluhan terkait pelayanan komunikasi yang tidak jelas di kliniknya.

Untuk mengelola risiko tersebut, tindakan manajemen risiko apa yang paling tepat dilakukan oleh bidan?

- A. Meningkatkan biaya pelayanan kebidanan
- B. Mengurangi jumlah pasien dalam satu hari pelayanan
- C. Melakukan pelatihan komunikasi efektif bagi semua staf klinik
- D. Menghentikan pelayanan untuk sementara waktu
- E. Mengarahkan pasien agar pindah ke fasilitas lain

Soal 3:

Dalam pemeriksaan rutin, seorang bidan menyadari bahwa terdapat risiko infeksi yang tinggi pada alat-alat kebidanan di kliniknya. Tindakan preventif apa yang harus dilakukan bidan untuk meminimalkan risiko tersebut?

- A. Melakukan sterilisasi alat kebidanan secara rutin
- B. Menjelaskan risiko infeksi kepada semua pasien sebelum pemeriksaan
- C. Mengurangi jumlah tindakan medis yang dilakukan setiap hari
- D. Mengganti alat medis setiap enam bulan sekali
- E. Melaporkan ke atasan tanpa melakukan intervensi apapun

KUNCI JAWABAN:**Soal 1: Jawaban benar C****Pembahasan:**

Langkah utama dalam manajemen risiko untuk mencegah perdarahan postpartum adalah dengan melakukan manajemen aktif kala III yang mencakup pemberian uterotonika yang tepat dan segera.

Soal 2: Jawaban benar C**Pembahasan:**

Untuk mengelola risiko komunikasi yang tidak jelas dan meminimalkan risiko keluhan pasien, bidan harus melakukan tindakan preventif berupa pelatihan komunikasi efektif secara rutin bagi staf klinik.

Soal 3: Jawaban benar A**Pembahasan:**

Untuk mencegah risiko infeksi dalam praktik kebidanan, langkah utama dan tepat adalah melakukan sterilisasi alat kebidanan secara rutin sesuai SOP, sehingga alat-alat selalu berada dalam kondisi steril dan aman digunakan pada pasien.

Area 2

Komunikasi Efektif

A. Teknik Komunikasi Interpersonal Terapeutik dalam Kebidanan

Komunikasi interpersonal terapeutik adalah proses interaksi verbal dan non-verbal antara bidan dengan pasien yang bertujuan untuk mendukung proses penyembuhan, kenyamanan pasien, serta membangun hubungan saling percaya dalam asuhan kebidanan.

1. Konsep Dasar Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik merupakan bentuk komunikasi yang dirancang secara khusus untuk memberikan manfaat terapeutik, memperkuat hubungan pasien-tenaga kesehatan, dan memfasilitasi pasien dalam mengambil keputusan terkait kesehatannya.

2. Tujuan Komunikasi Terapeutik

- a. Meningkatkan kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan.
- b. Memberikan dukungan emosional dan psikologis pada pasien.
- c. Mengurangi kecemasan dan stres pasien.
- d. Mendorong pasien agar aktif dalam pengambilan keputusan.
- e. Meningkatkan pemahaman pasien tentang kondisi kesehatan dan tindakan medis yang akan dilakukan.

3. Prinsip-Prinsip Komunikasi Terapeutik

- a. Empati: Menunjukkan pemahaman terhadap perasaan dan pengalaman pasien.
- b. Kejujuran: Memberikan informasi yang jujur dan transparan.
- c. Keterbukaan: Menerima pasien tanpa menghakimi atau memberikan kritik negatif.
- d. Penghormatan: Menghormati nilai-nilai, budaya, dan kepercayaan pasien.
- e. Mendengarkan Aktif: Memberikan perhatian penuh pada pasien dan merespons dengan tepat.

4. Teknik Komunikasi Interpersonal Terapeutik

- a. Mendengarkan Aktif (*Active Listening*)
Menyimak dengan seksama, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung seperti kontak mata, mengangguk, atau ekspresi wajah yang sesuai.
- b. Memberikan Pertanyaan Terbuka (*Open-Ended Questions*)
Mengajukan pertanyaan yang memerlukan jawaban panjang dan penjelasan detail, misalnya, “Bagaimana perasaan ibu setelah mengetahui kondisi kehamilannya?”
- c. Refleksi (*Reflection*)
Mengulangi kembali perasaan atau informasi yang disampaikan pasien dengan bahasa sendiri, misalnya, “Ibu merasa khawatir tentang proses persalinan nanti, ya?”
- d. Klarifikasi (*Clarification*)
Mengajukan pertanyaan tambahan untuk memperjelas informasi yang disampaikan pasien, misalnya, “Apakah yang ibu maksudkan dengan rasa tidak nyaman tadi adalah nyeri atau rasa tegang?”
- e. Validasi (*Validation*)
Mengakui dan menghormati perasaan pasien, misalnya, “Wajar bila ibu merasa cemas dengan kehamilan pertama ini, banyak ibu yang merasakan hal serupa.”
- f. Memberikan Informasi (*Providing Information*)
Memberikan penjelasan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami tentang kondisi pasien, tindakan medis, serta risikonya.
- g. Menjaga Kontak Mata (*Maintaining Eye Contact*)
Menunjukkan perhatian dan ketertarikan yang tulus pada pasien.
- h. Menggunakan Bahasa Tubuh yang Sesuai (*Appropriate Body Language*)
Menggunakan gestur yang terbuka, seperti posisi tubuh condong ke pasien, ekspresi wajah yang ramah, dan senyum yang hangat.
- i. Diam yang Terapeutik (*Therapeutic Silence*)
Memberikan waktu bagi pasien untuk berpikir atau memproses informasi yang diterimanya tanpa terburu-buru.

5. Hambatan Komunikasi Terapeutik

- a. Bahasa atau istilah medis yang sulit dimengerti pasien.
- b. Sikap menghakimi atau tidak empati dari tenaga kesehatan.
- c. Lingkungan yang tidak kondusif (berisik, kurang privasi).
- d. Kecemasan atau stres yang tinggi pada pasien.

6. Strategi Mengatasi Hambatan Komunikasi

- a. Menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami pasien.
- b. Menciptakan suasana yang nyaman, tenang, dan aman.
- c. Menunjukkan sikap empati, sabar, dan penuh perhatian.
- d. Menggunakan media visual atau alat bantu edukasi jika diperlukan.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Seorang ibu hamil datang dengan keluhan kecemasan karena ini adalah kehamilan pertamanya. Sebagai seorang bidan, Anda ingin menggali lebih dalam mengenai perasaan ibu.

Teknik komunikasi terapeutik apakah yang paling tepat digunakan dalam situasi ini?

- A. Memberikan pertanyaan tertutup
- B. Menggunakan refleksi perasaan dan pertanyaan terbuka
- C. Memberikan nasihat secara langsung tanpa bertanya
- D. Menyuruh ibu membaca brosur yang tersedia
- E. Memusatkan perhatian pada pemeriksaan fisik saja

Soal 2:

Saat pelayanan nifas, seorang ibu tampak sedih dan enggan berbicara banyak. Anda merasa ibu membutuhkan waktu untuk mengolah perasaannya.

Teknik komunikasi interpersonal terapeutik manakah yang paling sesuai dilakukan oleh bidan dalam situasi ini?

- A. Memberikan penjelasan panjang untuk mengalihkan perhatian
- B. Memaksa ibu berbicara tentang perasaannya segera
- C. Menggunakan teknik diam terapeutik untuk memberikan ruang emosional bagi ibu
- D. Menyarankan ibu pulang untuk beristirahat di rumah
- E. Menyuruh keluarga untuk menemani ibu tanpa keterlibatan bidan

Soal 3:

Seorang ibu baru melahirkan mengalami kesulitan dalam menyusui bayinya. Ia tampak kecewa dan merasa gagal.

Sebagai seorang bidan, teknik komunikasi interpersonal terapeutik apakah yang paling tepat digunakan dalam menghadapi situasi ini?

- A. Memberikan edukasi secara cepat agar ibu tidak terlalu lama kecewa
- B. Mengabaikan perasaan ibu dan fokus pada pemberian susu formula
- C. Menjelaskan secara teknis menggunakan istilah medis yang lengkap

- D. Menunjukkan empati, validasi perasaan ibu, dan memberikan dukungan positif
- E. Mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang tidak berhubungan dengan menyusui

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar B

Pembahasan:

Teknik komunikasi refleksi perasaan dan pertanyaan terbuka membantu bidan memahami lebih mendalam perasaan ibu, menciptakan kenyamanan, dan mendorong ibu untuk berbicara lebih terbuka tentang kekhawatirannya.

Soal 2: Jawaban benar: C

Pembahasan:

Diam terapeutik adalah teknik komunikasi efektif yang memberikan pasien kesempatan untuk berpikir, memproses emosi, dan mengungkapkan perasaan ketika siap. Ini membantu pasien merasa dihargai dan tidak ditekan.

Soal 3: Jawaban benar: D

Pembahasan:

Dalam situasi emosional, teknik komunikasi terbaik adalah menunjukkan empati, validasi atas perasaan pasien, dan memberikan dukungan positif yang dapat membantu ibu merasa percaya diri dan tidak sendirian menghadapi kesulitannya.

B. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas, Neonatal, dan KB

Komunikasi efektif merupakan kunci penting dalam memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas, terutama pada pelayanan antenatal care (ANC), persalinan, masa nifas, perawatan neonatal, dan keluarga berencana (KB). Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pasien, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rencana perawatan.

1. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Antenatal Care (ANC)

Tujuan Komunikasi dalam ANC:

- Memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi kehamilan.
- Mengidentifikasi masalah atau komplikasi sejak dini.
- Meningkatkan kesiapan ibu menghadapi persalinan.

Teknik Komunikasi:

- Gunakan pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi perasaan dan kekhawatiran ibu.
- Jelaskan hasil pemeriksaan dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti.
- Berikan edukasi tentang nutrisi, tanda bahaya kehamilan, serta persiapan persalinan secara terperinci.

2. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Persalinan**Tujuan Komunikasi dalam Persalinan:**

- Memberikan dukungan emosional dan psikologis.
- Mengurangi rasa sakit dan kecemasan ibu.
- Menjaga ibu tetap tenang dan kooperatif selama proses persalinan.

Teknik Komunikasi:

- Berikan dukungan emosional melalui kata-kata positif dan motivasi secara terus-menerus.
- Jelaskan setiap tahap persalinan yang sedang berlangsung dengan tenang dan jelas.
- Gunakan sentuhan terapeutik yang lembut untuk memberikan kenyamanan tambahan.

3. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Nifas**Tujuan Komunikasi dalam Masa Nifas:**

- Memastikan ibu memahami pentingnya perawatan nifas yang tepat.
- Meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam merawat diri dan bayinya.
- Memberikan dukungan untuk keberhasilan menyusui.

Teknik Komunikasi:

- Jelaskan tentang tanda-tanda bahaya masa nifas dengan jelas dan spesifik.
- Berikan dukungan positif tentang kemampuan ibu dalam merawat bayinya.
- Dorong ibu untuk berbagi perasaan dan pengalaman masa nifas secara terbuka.

4. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Neonatal**Tujuan Komunikasi dalam Perawatan Neonatal:**

- Memberikan informasi lengkap tentang perawatan bayi baru lahir.
- Memastikan keluarga memahami tanda-tanda bahaya neonatal.
- Meningkatkan partisipasi keluarga dalam perawatan bayi.

Teknik Komunikasi:

- Berikan demonstrasi langsung tentang perawatan tali pusat, teknik menyusui, dan menjaga kehangatan bayi.
- Gunakan bahasa yang sederhana dan hindari istilah medis yang kompleks.
- Sediakan waktu khusus bagi keluarga untuk bertanya dan menjawab semua pertanyaan secara jelas dan sabar.

5. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Keluarga Berencana (KB)**Tujuan Komunikasi dalam KB:**

- Membantu pasien memilih metode KB yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya.
- Memberikan edukasi tentang efek samping dan manfaat metode KB yang dipilih.
- Meningkatkan kepatuhan pasien dalam penggunaan metode KB.

Teknik Komunikasi:

- Berikan informasi rinci tentang berbagai metode KB termasuk cara kerja, manfaat, risiko, dan efek sampingnya.
- Berikan kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan preferensi dan kekhawatirannya.
- Pastikan pasien memahami dengan jelas bagaimana menggunakan metode KB yang dipilih dengan benar.

6. Faktor Penunjang Komunikasi Efektif dalam Kebidanan

- Empati dan perhatian penuh terhadap kebutuhan pasien.
- Sikap ramah, terbuka, sabar, serta menghormati nilai budaya pasien.
- Lingkungan yang nyaman, tenang, dan privat.
- Menggunakan alat bantu visual atau materi edukasi yang sesuai.

7. Tantangan dan Solusi dalam Komunikasi Efektif**Tantangan:**

- Perbedaan budaya dan bahasa antara bidan dan pasien.
- Tingkat pemahaman pasien yang bervariasi.
- Keterbatasan waktu pelayanan.

Solusi:

- Menggunakan penerjemah atau alat bantu komunikasi yang tepat.
- Menyesuaikan informasi dengan tingkat pemahaman pasien.
- Memanfaatkan alat bantu visual seperti gambar atau video edukasi.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Seorang ibu hamil datang ke klinik kebidanan untuk pemeriksaan antenatal. Saat pemeriksaan, ibu terlihat gelisah dan takut karena ini adalah kehamilan pertamanya. Teknik komunikasi efektif manakah yang paling tepat dilakukan oleh bidan dalam situasi ini?

- A. Memberikan dukungan emosional dengan kalimat positif dan menenangkan
- B. Memberikan informasi singkat saja agar ibu tidak semakin gelisah
- C. Menggunakan pertanyaan tertutup agar tidak memperpanjang diskusi
- D. Menyarankan ibu untuk membaca sendiri materi edukasi yang tersedia
- E. Meminta ibu agar tidak terlalu khawatir karena kehamilannya normal

Soal 2:

Seorang ibu yang baru melahirkan mengeluhkan kesulitan dalam menyusui bayinya. Ia tampak frustrasi dan mulai menangis karena merasa gagal sebagai seorang ibu. Sebagai seorang bidan, komunikasi efektif seperti apakah yang paling tepat diterapkan pada kasus ini?

- A. Memberikan penjelasan singkat agar ibu tidak menangis lebih lama
- B. Menggunakan bahasa yang sangat teknis agar ibu memahami pentingnya menyusui
- C. Menyarankan ibu untuk langsung beralih ke susu formula agar lebih praktis
- D. Mendengarkan aktif, menunjukkan empati, dan memberikan validasi atas perasaan ibu
- E. Mengalihkan pembicaraan agar ibu lupa dengan kesulitannya dalam menyusui

Soal 3:

Seorang ibu datang ke klinik KB dengan kebingungan memilih metode kontrasepsi yang tepat untuk dirinya. Ia menyampaikan kekhawatirannya tentang efek samping dari beberapa metode KB. Sebagai bidan, komunikasi efektif seperti apakah yang paling tepat Anda lakukan dalam menghadapi situasi ini?

- A. Menjelaskan secara singkat saja karena waktu pelayanan terbatas
- B. Memberikan brosur metode KB tanpa penjelasan tambahan
- C. Memberi kesempatan ibu menyampaikan kekhawatiran, lalu menjelaskan secara rinci dan jelas tentang metode KB yang tersedia
- D. Menyarankan ibu untuk bertanya langsung ke dokter spesialis kebidanan agar lebih jelas

E. Memutuskan langsung metode KB yang paling baik menurut Anda, tanpa melibatkan keputusan ibu

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban yang benar A

Pembahasan:

Dalam kondisi kecemasan pasien, bidan harus menggunakan teknik komunikasi efektif berupa pemberian dukungan emosional secara langsung dengan kalimat yang positif dan menenangkan. Hal ini membantu ibu merasa lebih nyaman, tenang, dan percaya diri menghadapi kehamilannya.

Soal 2: Jawaban yang benar D

Pembahasan:

Komunikasi efektif yang paling tepat dalam situasi ini adalah mendengarkan aktif, menunjukkan empati, dan memberikan validasi atas perasaan ibu. Tindakan ini dapat mengurangi kecemasan, memberikan kenyamanan emosional, serta membantu ibu merasa dihargai dan tidak sendiri dalam menghadapi masalah tersebut.

Soal 3: Jawaban yang benar C

Pembahasan:

Komunikasi efektif dalam pelayanan KB adalah dengan memberikan kesempatan pasien menyampaikan kekhawatirannya terlebih dahulu. Setelah itu, bidan harus menjelaskan secara rinci, jelas, dan lengkap mengenai setiap metode KB, termasuk manfaat dan efek sampingnya, sehingga pasien mampu memilih metode KB yang paling tepat berdasarkan informasi yang jelas dan akurat.

C. Konseling dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi

Konseling dalam pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi merupakan interaksi interpersonal antara bidan dengan klien, bertujuan untuk membantu klien memahami berbagai informasi dan membuat keputusan mandiri yang tepat tentang metode KB dan perawatan kesehatan reproduksinya.

1. Pengertian Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi

Konseling KB dan kesehatan reproduksi adalah proses komunikasi dua arah antara bidan dan klien yang bertujuan memberikan informasi yang akurat, jelas, dan lengkap mengenai berbagai metode KB serta

perawatan kesehatan reproduksi untuk membantu klien mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya.

2. Tujuan Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi

- a. Memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang berbagai metode KB dan kesehatan reproduksi.
- b. Membantu klien mengidentifikasi metode KB yang paling sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman klien terhadap pentingnya menjaga kesehatan reproduksi.
- d. Membantu klien mengatasi masalah atau hambatan dalam penggunaan metode KB.

3. Prinsip-prinsip Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi

- a. **Kerahasiaan (*Confidentiality*):** Menjaga kerahasiaan semua informasi yang diberikan klien.
- b. **Non-diskriminasi:** Memberikan pelayanan tanpa membedakan suku, agama, ras, atau status sosial ekonomi klien.
- c. **Informasi Akurat dan Jelas:** Memberikan informasi yang tepat, lengkap, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan.
- d. **Keterbukaan dan Penghormatan:** Mendengarkan dengan penuh perhatian, menghormati pendapat klien, serta tidak menghakimi pilihan klien.

4. Langkah-langkah Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi

- a. **Tahap Awal (Membangun Hubungan dan Menggali Informasi)**
 - Membuka percakapan dengan hangat dan ramah.
 - Mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, kekhawatiran, dan harapan klien.
- b. **Tahap Pemberian Informasi**
 - Menjelaskan berbagai metode KB, cara kerja, efektivitas, manfaat, efek samping, dan risiko dari masing-masing metode.
 - Memberikan informasi mengenai pemeliharaan kesehatan reproduksi, tanda bahaya, serta cara penanganannya.
- c. **Tahap Pengambilan Keputusan**
 - Membantu klien mempertimbangkan pilihan berdasarkan informasi yang diberikan.
 - Memberikan kesempatan klien bertanya dan mengekspresikan kekhawatiran.
- d. **Tahap Implementasi dan Tindak Lanjut**
 - Menjelaskan secara detail penggunaan metode KB yang dipilih.

- Menjadwalkan pertemuan tindak lanjut untuk mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan dan memberikan dukungan lanjutan.

5. Teknik Konseling yang Efektif dalam KB dan Kesehatan Reproduksi

- Mendengarkan aktif dan empati.
- Menggunakan pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi kebutuhan klien.
- Refleksi perasaan klien untuk validasi emosional.
- Menggunakan alat bantu visual seperti brosur, gambar, atau model anatomi.

6. Hambatan dalam Konseling KB dan Solusinya

Hambatan:

- Informasi medis yang kompleks sulit dimengerti klien.
- Adanya mitos atau kepercayaan yang salah di masyarakat.
- Kurangnya keterampilan komunikasi dari tenaga kesehatan.

Solusi:

- Menggunakan bahasa sederhana dan alat bantu visual.
- Melakukan edukasi komunitas secara rutin.
- Mengadakan pelatihan komunikasi bagi tenaga kesehatan.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Seorang klien datang ke klinik KB untuk berkonsultasi tentang metode kontrasepsi yang cocok untuknya.

Sebagai bidan, langkah konseling manakah yang harus Anda lakukan pertama kali?

- Langsung memberikan rekomendasi metode KB yang paling efektif.
- Menggali informasi tentang kebutuhan dan kekhawatiran klien.
- Menjelaskan semua metode KB secara singkat.
- Meminta klien untuk memilih metode secara mandiri tanpa arahan.
- Menyarankan klien untuk konsultasi ke dokter spesialis terlebih dahulu.

Soal 2:

Dalam sesi konseling KB, klien menunjukkan ketidaknyamanan dalam menerima informasi mengenai efek samping metode KB tertentu.

Teknik komunikasi apakah yang paling tepat digunakan bidan untuk mengatasi situasi ini?

- A. Menghindari pembicaraan tentang efek samping agar klien tidak takut.
- B. Menjelaskan secara teknis menggunakan bahasa medis.
- C. Memberikan validasi terhadap perasaan klien dan menjelaskan secara empati.
- D. Menyuruh klien membaca sendiri brosur tentang KB.
- E. Segera memilihkan metode KB lain tanpa berdiskusi lebih lanjut.

Soal 3:

Klien telah memilih metode kontrasepsi yang diinginkannya. Sebagai bidan, tindakan selanjutnya yang paling tepat dalam konseling KB adalah:

- A. Mengakhiri konseling karena klien sudah memutuskan.
- B. Mengatur jadwal kunjungan tindak lanjut untuk evaluasi dan dukungan lanjutan.
- C. Menyarankan klien segera pergi ke apotek untuk membeli sendiri alat KB.
- D. Memberikan informasi tambahan tentang metode lain sebagai perbandingan.
- E. Menyarankan klien agar segera konsultasi ulang dengan keluarganya terlebih dahulu.

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar B

Pembahasan:

Langkah awal konseling adalah membangun hubungan dan menggali informasi kebutuhan serta kekhawatiran klien. Hal ini penting untuk memberikan informasi dan rekomendasi yang tepat sesuai kebutuhan klien.

Soal 2: Jawaban benar C

Pembahasan:

Validasi perasaan klien serta menjelaskan secara empati adalah teknik komunikasi terapeutik yang efektif untuk mengatasi ketidaknyamanan klien dalam menerima informasi yang sensitif atau menakutkan.

Soal 3: Jawaban benar B

Pembahasan:

Setelah klien memutuskan metode KB, tindakan tepat berikutnya adalah menjadwalkan pertemuan tindak lanjut untuk memastikan metode tersebut efektif dan memberikan dukungan lanjutan kepada klien.

Area 3

Profesionalisme, Pengembangan Diri, dan Kepemimpinan

A. Profesionalisme dalam Praktik Kebidanan

Profesionalisme dalam kebidanan adalah sikap dan perilaku bidan dalam menjalankan tugas profesinya sesuai dengan standar kompetensi, kode etik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi memberikan pelayanan yang optimal, aman, efektif, dan empatik kepada pasien.

1. Konsep Profesionalisme Kebidanan

Profesionalisme dalam praktik kebidanan mencakup:

- a. Kompetensi klinis yang tinggi.
- b. Sikap etis dan integritas dalam memberikan pelayanan.
- c. Tanggung jawab dan komitmen terhadap keselamatan pasien.
- d. Pengembangan diri melalui pendidikan berkelanjutan.

2. Karakteristik Profesionalisme Bidan

- a. **Kompetensi Teknis:** Kemampuan memberikan asuhan kebidanan yang aman, efektif, dan sesuai standar.
- b. **Etika dan Integritas:** Menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kode etik profesi.
- c. **Tanggung Jawab dan Akuntabilitas:** Bertanggung jawab terhadap setiap keputusan dan tindakan medis yang dilakukan.
- d. **Komunikasi Efektif:** Berkomunikasi dengan jelas, empatik, dan menghormati pasien serta rekan sejawat.
- e. **Pengembangan Diri:** Berkomitmen terhadap pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi.

3. Prinsip Profesionalisme dalam Kebidanan

- a. **Prinsip Kompetensi:** Selalu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kemampuan profesional yang dimiliki.

- b. **Prinsip Kesejawatan:** Bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain secara harmonis.
- c. **Prinsip Kejujuran (Veracity):** Memberikan informasi yang benar dan transparan kepada pasien.
- d. **Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality):** Menjaga privasi dan kerahasiaan pasien.
- e. **Prinsip Kemandirian:** Bertindak secara mandiri namun tetap dalam batas-batas kewenangan yang dimiliki.

4. Tantangan Profesionalisme dalam Praktik Kebidanan

- a. Adanya tekanan kerja yang tinggi.
- b. Kurangnya sumber daya dan fasilitas.
- c. Tingginya ekspektasi pasien dan keluarga.
- d. Dinamika interprofesional yang kompleks.

5. Strategi Meningkatkan Profesionalisme dalam Kebidanan

- a. Mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
- b. Aktif dalam organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
- c. Melakukan refleksi diri dan evaluasi berkala terhadap praktik klinis yang dilakukan.
- d. Menjaga keseimbangan antara profesionalisme dengan empati dalam memberikan pelayanan.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Seorang bidan menghadapi situasi di mana pasiennya menanyakan tentang risiko tindakan persalinan yang akan dilakukan. Sikap profesionalisme apakah yang harus ditunjukkan oleh bidan dalam situasi ini?

- A. Memberikan penjelasan secara jujur dan transparan mengenai risiko tindakan tersebut
- B. Menyederhanakan informasi agar pasien tidak khawatir
- C. Menyarankan pasien bertanya langsung kepada dokter spesialis
- D. Mengalihkan pembicaraan untuk menghindari kecemasan pasien
- E. Mengatakan bahwa semua tindakan medis pasti aman

Soal 2:

Seorang bidan sering mengikuti pelatihan kebidanan terbaru untuk meningkatkan keterampilan klinisnya.

Aktivitas ini mencerminkan prinsip profesionalisme kebidanan berupa:

- A. Kompetensi Teknis
- B. Pengembangan Diri
- C. Tanggung Jawab
- D. Komunikasi Efektif
- E. Kesejawatan

Soal 3:

Seorang bidan menerima informasi pribadi pasien tentang kondisi kehamilannya yang sensitif. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan bidan sebagai bentuk profesionalisme?

- A. Membagikan informasi kepada rekan sejawat sebagai bahan diskusi klinik
- B. Menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga pasien tanpa persetujuan pasien
- C. Menjaga kerahasiaan informasi kecuali ada persetujuan pasien atau kewajiban hukum
- D. Menyampaikan informasi tersebut secara terbuka dalam rapat tim kesehatan
- E. Menyimpan informasi tersebut tanpa dokumentasi resmi

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar A

Pembahasan:

Sikap profesionalisme menuntut bidan memberikan informasi secara jujur, transparan, dan jelas kepada pasien mengenai manfaat serta risiko dari tindakan yang akan dilakukan (prinsip kejujuran).

Soal 2: Jawaban benar B

Pembahasan:

Mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan merupakan implementasi dari prinsip pengembangan diri, yang menjadi bagian penting dari profesionalisme bidan.

Soal 3: Jawaban benar C

Pembahasan:

Menjaga kerahasiaan informasi pasien merupakan prinsip profesionalisme yang penting dalam praktik kebidanan, kecuali ada persetujuan pasien atau kewajiban hukum yang mengharuskan informasi tersebut disampaikan.

B. Pengembangan Keilmuan Bidan (Pendidikan Berkelanjutan)

Pengembangan keilmuan bidan atau pendidikan berkelanjutan merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat yang dilakukan oleh bidan untuk memperbaharui pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta mengembangkan kompetensi profesionalnya agar selalu relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kebidanan.

1. Konsep Dasar Pendidikan Berkelanjutan dalam Kebidanan

Pendidikan berkelanjutan bagi bidan merupakan pendidikan pasca formal yang mencakup berbagai pelatihan, seminar, workshop, maupun pendidikan informal yang bertujuan untuk memperbaharui dan meningkatkan kompetensi serta kualitas pelayanan kebidanan.

2. Tujuan Pendidikan Berkelanjutan bagi Bidan

- a. Memperbaharui pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu kebidanan terbaru.
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis dalam praktik kebidanan.
- c. Menjaga standar praktik kebidanan sesuai dengan ketentuan profesional.
- d. Meningkatkan kepuasan pasien melalui pelayanan yang kompeten dan berkualitas.

3. Bentuk-bentuk Pendidikan Berkelanjutan

a. Seminar dan Workshop

Mengikuti seminar atau workshop tentang kebidanan secara rutin untuk mendapatkan informasi terkini.

b. Pelatihan Klinis

Mengikuti pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan klinis yang spesifik, seperti penanganan kegawatdaruratan obstetri.

c. Pendidikan Formal Lanjutan

Melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, seperti program sarjana (S1), magister (S2), atau doktoral (S3).

d. Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Melakukan penelitian ilmiah di bidang kebidanan dan mempublikasikan hasilnya untuk memberikan kontribusi terhadap ilmu kebidanan.

e. Partisipasi dalam Organisasi Profesi

Aktif berpartisipasi dalam kegiatan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) untuk pengembangan keilmuan dan jaringan profesional.

4. Manfaat Pendidikan Berkelanjutan

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- b. Pengakuan profesional dalam masyarakat dan rekan sejawat.
- c. Peningkatan kepuasan kerja dan kepercayaan diri bidan.
- d. Menurunkan risiko kesalahan medis dalam praktik klinis.

5. Tantangan dalam Pendidikan Berkelanjutan

- a. Keterbatasan waktu karena beban kerja.
- b. Biaya pelatihan dan pendidikan yang tinggi.
- c. Akses terbatas pada pelatihan khusus, terutama bagi bidan di daerah terpencil.

6. Strategi untuk Mengatasi Tantangan

- a. Memanfaatkan pelatihan online dan webinar sebagai alternatif hemat waktu dan biaya.
- b. Menyediakan program pelatihan dan pendidikan gratis atau bersubsidi melalui kerjasama dengan instansi terkait.
- c. Mengembangkan jaringan dan komunitas belajar antar-bidan untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Seorang bidan mengikuti pelatihan penanganan kegawatdaruratan obstetri secara rutin setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bentuk pengembangan keilmuan berupa:

- A. Pendidikan formal lanjutan
- B. Penelitian ilmiah
- C. Pelatihan klinis
- D. Seminar nasional
- E. Partisipasi organisasi profesi

Soal 2:

Apa manfaat utama yang didapatkan bidan ketika rutin mengikuti pendidikan berkelanjutan?

- A. Mengurangi interaksi dengan pasien
- B. Menurunkan jumlah pasien yang dilayani
- C. Menurunkan kepercayaan diri
- D. Meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan
- E. Mengurangi beban administratif

Soal 3:

Bidan menghadapi tantangan dalam mengikuti pendidikan berkelanjutan karena tinggal di daerah terpencil. Strategi paling tepat yang dapat dilakukan oleh bidan tersebut adalah:

- A. Menghentikan upaya mengikuti pelatihan
- B. Memindahkan lokasi kerja ke kota besar
- C. Mengikuti pelatihan online atau webinar
- D. Mengikuti pelatihan di luar negeri
- E. Menunggu diadakan pelatihan di daerah terpencil

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar C

Pembahasan:

Mengikuti pelatihan khusus secara rutin merupakan bentuk pelatihan klinis yang bertujuan meningkatkan keterampilan teknis yang spesifik.

Soal 2: Jawaban benar D

Pembahasan:

Pendidikan berkelanjutan membantu bidan meningkatkan kompetensi klinisnya, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kebidanan.

Soal 3: Jawaban benar C

Pembahasan:

Pelatihan online atau webinar merupakan solusi yang efektif dan efisien bagi bidan yang tinggal di daerah terpencil untuk tetap dapat mengikuti pendidikan berkelanjutan.

C. Kepemimpinan dalam Manajemen Kasus Kebidanan

Kepemimpinan dalam manajemen kasus kebidanan adalah kemampuan bidan untuk mengelola, mengoordinasikan, dan mengarahkan sumber daya serta tim pelayanan kesehatan secara efektif demi mencapai hasil terbaik dalam asuhan kebidanan.

1. Konsep Dasar Kepemimpinan dalam Kebidanan

Kepemimpinan dalam kebidanan melibatkan:

- Kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
- Koordinasi tim multidisiplin yang efektif.
- Komunikasi yang jelas dan efektif.
- Manajemen sumber daya secara optimal.

2. Karakteristik Kepemimpinan Efektif dalam Manajemen Kasus Kebidanan

- a. **Komunikatif:** Menyampaikan instruksi secara jelas dan memastikan semua anggota tim memahami tugasnya.
- b. **Kolaboratif:** Bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk memberikan asuhan yang komprehensif.
- c. **Empati:** Memahami dan merespons kebutuhan pasien maupun anggota tim dengan penuh perhatian dan pengertian.
- d. **Visioner:** Memiliki visi jelas tentang tujuan akhir dalam pengelolaan kasus kebidanan.
- e. **Tegas dan Konsisten:** Menunjukkan ketegasan dalam keputusan dan konsistensi dalam menjalankan prosedur pelayanan.

3. Fungsi Kepemimpinan dalam Manajemen Kasus Kebidanan

- a. **Pengambilan Keputusan:** Memutuskan tindakan terbaik berdasarkan analisis kasus.
- b. **Koordinasi Tim:** Mengelola kerja tim kesehatan secara harmonis.
- c. **Pengawasan:** Memantau pelaksanaan tindakan sesuai standar operasional prosedur.
- d. **Evaluasi:** Menilai efektivitas asuhan kebidanan secara berkesinambungan.

4. Gaya Kepemimpinan dalam Praktik Kebidanan

- a. **Demokratis:** Melibatkan tim dalam pengambilan keputusan dan menghargai pendapat mereka.
- b. **Transformasional:** Memberikan inspirasi dan motivasi kepada tim untuk bekerja optimal demi mencapai tujuan.
- c. **Situasional:** Menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

5. Tantangan dalam Kepemimpinan Kasus Kebidanan

- a. Kompleksitas kasus yang ditangani.
- b. Dinamika kerja tim kesehatan yang beragam.
- c. Tekanan waktu dan kebutuhan keputusan cepat dalam kondisi darurat.

6. Strategi Mengatasi Tantangan Kepemimpinan

- a. Meningkatkan kompetensi pengambilan keputusan klinis melalui pelatihan khusus.
- b. Mengadakan diskusi reguler untuk meningkatkan kolaborasi antar tim.

- c. Mengembangkan komunikasi efektif dan empatik dalam tim kesehatan.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Dalam situasi persalinan darurat, seorang bidan dengan cepat mengambil keputusan tindakan medis yang diperlukan serta membagi tugas kepada anggota tim. Gaya kepemimpinan apakah yang paling tepat ditunjukkan oleh bidan dalam kasus ini?

- A. Demokratis
- B. Transformasional
- C. Situasional
- D. Otokratis
- E. Laissez-faire

Soal 2:

Seorang bidan secara rutin melakukan evaluasi terhadap tindakan asuhan kebidanan yang diberikan oleh timnya. Fungsi kepemimpinan apakah yang sedang dijalankan bidan tersebut?

- A. Pengambilan keputusan
- B. Pengawasan
- C. Koordinasi tim
- D. Evaluasi
- E. Kolaborasi

Soal 3:

Bidan selalu melibatkan timnya dalam pengambilan keputusan mengenai tindakan yang akan diambil dalam kasus-kasus kompleks. Gaya kepemimpinan manakah yang diterapkan oleh bidan tersebut?

- A. Demokratis
- B. Otokratis
- C. Transformasional
- D. Situasional
- E. Laissez-faire

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar C

Pembahasan:

Gaya kepemimpinan situasional paling tepat dalam situasi darurat, karena bidan mampu dengan cepat mengambil keputusan dan menyesuaikan tindakan berdasarkan situasi yang dihadapi.

Soal 2: Jawaban benar D

Pembahasan:

Evaluasi merupakan fungsi kepemimpinan penting dalam manajemen kasus kebidanan yang bertujuan memastikan efektivitas asuhan dan mencari area yang perlu perbaikan.

Soal 3: Jawaban benar A

Pembahasan:

Kepemimpinan demokratis dicirikan oleh keterlibatan seluruh anggota tim dalam pengambilan keputusan, yang menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap hasil yang dicapai.

Area 4

Landasan Ilmiah Kebidanan

A. Anatomi, Fisiologi, dan Patologi Reproduksi Perempuan

Memahami anatomi, fisiologi, dan patologi sistem reproduksi perempuan merupakan dasar penting bagi bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan yang efektif dan aman.

1. Anatomi Reproduksi Perempuan

a. Anatomi Organ Reproduksi Eksternal

1) Mons Pubis

Bantalan lemak yang melindungi tulang pubis, ditumbuhi rambut pubis setelah pubertas.

2) Labia Majora

Dua lipatan kulit tebal yang melindungi struktur genital internal.

3) Labia Minora

Dua lipatan kulit tipis yang terletak di dalam labia majora, melindungi lubang vagina dan uretra.

4) Klitoris

Organ kecil dan sangat sensitif, berperan dalam respon seksual.

5) Vestibulum

Area antara labia minora yang berisi pembukaan uretra dan vagina.

6) Hymen (Selaput Dara)

Membran tipis yang sebagian menutupi lubang vagina.

7) Kelenjar Bartholin

Dua kelenjar kecil yang terletak di kedua sisi lubang vagina, berfungsi menghasilkan cairan untuk melubrikasi vagina.

b. Anatomi Organ Reproduksi Internal

1) Vagina

Saluran elastis sepanjang 7-10 cm yang menghubungkan uterus dengan bagian luar tubuh.

2) Serviks (Leher Rahim)

Bagian bawah uterus yang menghubungkan uterus dengan vagina, memiliki fungsi penting dalam proses reproduksi dan melahirkan.

3) Uterus (Rahim)

Organ berotot berbentuk seperti buah pir terbalik yang merupakan tempat implantasi janin dan pertumbuhan janin selama kehamilan. Bagian uterus terdiri dari:

- Fundus
- Korpus
- Isthmus
- Serviks

4) Tuba Falopi (Saluran Telur)

Dua saluran sempit yang menghubungkan ovarium dengan uterus, merupakan tempat fertilisasi terjadi.

5) Ovarium (Indung Telur)

Dua kelenjar berbentuk oval yang berfungsi menghasilkan ovum (sel telur) serta hormon estrogen dan progesteron.

c. Fungsi Utama Organ Reproduksi Perempuan

- 1) Produksi ovum (sel telur).
- 2) Fasilitasi fertilisasi (pembuahan).
- 3) Mendukung implantasi embrio.
- 4) Tempat perkembangan janin.
- 5) Melahirkan bayi.
- 6) Produksi hormon reproduksi perempuan.

d. Peran Anatomi dalam Praktik Kebidanan

Memahami anatomi sistem reproduksi membantu bidan dalam:

- 1) Melakukan pemeriksaan antenatal.
- 2) Menentukan posisi janin dan kelahiran.
- 3) Menangani persalinan secara efektif.
- 4) Mengidentifikasi kelainan anatomi yang dapat mempengaruhi kehamilan atau persalinan.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Bagian manakah dari organ reproduksi perempuan yang berfungsi sebagai tempat implantasi dan pertumbuhan janin selama kehamilan?

- A. Serviks
- B. Tuba Falopi

- C. Ovarium
- D. Uterus
- E. Vagina

Soal 2:

Organ reproduksi internal perempuan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi adalah:

- A. Serviks
- B. Tuba Falopi
- C. Uterus
- D. Ovarium
- E. Vagina

Soal 3:

Kelenjar Bartholin memiliki peran penting dalam anatomi reproduksi perempuan. Apa fungsi utama dari kelenjar Bartholin?

- A. Menyimpan ovum
- B. Memproduksi hormon estrogen
- C. Melubrikasi vagina
- D. Tempat fertilisasi
- E. Memproduksi sel telur

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar D

Pembahasan:

Uterus merupakan organ reproduksi perempuan tempat terjadinya implantasi dan pertumbuhan janin selama kehamilan.

Soal 2: Jawaban benar B

Pembahasan:

Tuba falopi adalah organ yang menghubungkan ovarium dengan uterus, tempat bertemunya sperma dan ovum sehingga terjadi fertilisasi.

Soal 3: Jawaban benar C

Pembahasan:

Kelenjar Bartholin menghasilkan cairan pelumas yang membantu melubrikasi vagina selama aktivitas seksual.

2. Fisiologi Reproduksi Perempuan

Memahami fisiologi reproduksi perempuan sangat penting bagi mahasiswa kebidanan untuk memberikan asuhan yang tepat dan efektif dalam praktik klinis.

a. Siklus Menstruasi

Siklus menstruasi adalah siklus bulanan perubahan fisiologis pada perempuan yang dikendalikan oleh hormon dan ditandai dengan keluarnya darah menstruasi.

Siklus ini terdiri atas empat fase:

1) Fase Menstruasi (Hari 1-5)

Terjadi peluruhan endometrium yang menimbulkan perdarahan menstruasi akibat penurunan kadar estrogen dan progesteron.

2) Fase Folikuler (Hari 6-14)

- Hormon Follicle Stimulating Hormone (FSH) merangsang ovarium untuk menumbuhkan folikel.
- Estrogen meningkat secara bertahap yang menyebabkan penebalan endometrium.

3) Fase Ovulasi (Hari 14)

- Pelepasan sel telur matang dari folikel di ovarium akibat lonjakan hormon Luteinizing Hormone (LH).
- Ovum siap dibuahi di tuba falopi.

4) Fase Luteal (Hari 15-28)

- Terbentuk korpus luteum yang menghasilkan progesteron.
- Endometrium semakin menebal sebagai persiapan implantasi embrio.
- Jika fertilisasi tidak terjadi, kadar hormon progesteron dan estrogen menurun sehingga kembali ke fase menstruasi.

b. Fertilisasi (Pembuahan)

- Terjadi pertemuan antara sperma dengan ovum di tuba falopi.
- Ovum yang telah dibuahi disebut zigot, yang kemudian berkembang menjadi embrio.

c. Implantasi

- Embrio melekat dan tertanam ke dalam endometrium uterus.
- Terjadi sekitar 6-7 hari setelah fertilisasi.

d. Kehamilan

- Perkembangan janin terjadi selama kurang lebih 40 minggu.

- Plasenta terbentuk dan berfungsi menyediakan nutrisi, oksigen, dan membuang limbah dari janin.

e. Persalinan

- Proses kelahiran bayi akibat kontraksi uterus yang kuat.
- Dibagi dalam tiga kala: Kala I (pembukaan), Kala II (pengeluaran bayi), dan Kala III (pengeluaran plasenta).

PERTANYAAN:

Soal 1:

Pada fase apakah dalam siklus menstruasi perempuan terjadi peningkatan hormon LH secara signifikan?

- A. Fase Menstruasi
- B. Fase Folikuler
- C. Fase Ovulasi
- D. Fase Luteal
- E. Fase Implantasi

Soal 2:

Berapa lama waktu yang umumnya dibutuhkan dari fertilisasi hingga terjadi implantasi embrio pada endometrium uterus?

- A. 1-2 hari
- B. 3-4 hari
- C. 6-7 hari
- D. 10-12 hari
- E. 14 hari

Soal 3:

Hormon yang dominan pada fase luteal dalam siklus menstruasi adalah:

- A. FSH
- B. LH
- C. Estrogen
- D. Progesteron
- E. Prolaktin

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar C

Pembahasan:

Lonjakan hormon LH terjadi pada fase ovulasi, yang berperan dalam pelepasan ovum matang dari folikel.

Soal 2: Jawaban benar C**Pembahasan:**

Setelah fertilisasi, embrio bergerak ke uterus dan implantasi biasanya terjadi sekitar 6-7 hari kemudian.

Soal 3: Jawaban benar D**Pembahasan:**

Progesteron merupakan hormon dominan yang dihasilkan oleh korpus luteum pada fase luteal, berfungsi untuk mempertahankan endometrium agar siap menerima embrio jika fertilisasi terjadi.

3. Patologi Reproduksi Perempuan

Pemahaman tentang patologi atau gangguan pada sistem reproduksi perempuan penting bagi bidan untuk mengidentifikasi, mendiagnosis dini, dan memberikan asuhan yang efektif kepada pasien.

a. Infeksi Saluran Reproduksi**1) Vaginitis**

- Peradangan pada vagina yang disebabkan oleh bakteri, jamur, atau parasit.
- Gejala: gatal, keputihan, bau tidak sedap, nyeri saat berkemih.

2) Servitis

- Radang pada serviks, biasanya disebabkan oleh infeksi menular seksual.
- Gejala: keputihan abnormal, nyeri saat hubungan seksual, perdarahan intermenstrual.

3) Pelvic Inflammatory Disease (PID)

- Infeksi saluran reproduksi bagian atas yang melibatkan uterus, tuba falopi, atau ovarium.
- Gejala: nyeri panggul, demam, keputihan abnormal, infertilitas jika kronis.

b. Gangguan Siklus Menstruasi**1) Amenorea**

Tidak menstruasi selama minimal 3 bulan berturut-turut.

2) Dismenorea

Nyeri hebat selama menstruasi.

3) Menoragia

Perdarahan menstruasi yang sangat banyak atau lama.

4) Oligomenorea

Siklus menstruasi yang lebih panjang dari 35 hari.

c. Neoplasma atau Tumor

1) Mioma Uteri

- Tumor jinak pada dinding rahim.
- Gejala: perdarahan menstruasi berlebihan, nyeri panggul, tekanan pada kandung kemih.

2) Kista Ovarium

- Kantong berisi cairan pada ovarium.
- Gejala: nyeri panggul, menstruasi tidak teratur.

3) Kanker Serviks

- Keganasan pada serviks, sering dikaitkan dengan infeksi HPV.
- Gejala: perdarahan intermenstrual, keputihan abnormal, nyeri saat hubungan seksual.

d. Gangguan Fertilitas

1) Endometriosis

- Jaringan endometrium tumbuh di luar uterus.
- Gejala: nyeri menstruasi hebat, nyeri saat hubungan seksual, infertilitas.

2) Sindrom Ovarium Polikistik (PCOS)

- Gangguan hormonal dengan banyaknya kista kecil pada ovarium.
- Gejala: menstruasi tidak teratur, obesitas, hirsutisme, infertilitas.

e. Peran Bidan dalam Manajemen Patologi Reproduksi

1) Identifikasi dini gejala dan tanda.

2) Pendidikan pasien tentang gejala, pengobatan, dan pencegahan.

3) Merujuk ke fasilitas layanan kesehatan yang lebih tinggi untuk penanganan lanjut.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Seorang perempuan mengeluhkan keputihan abnormal berwarna kekuningan, bau tidak sedap, nyeri saat berkemih, dan gatal pada vagina. Gangguan apa yang paling mungkin dialami pasien?

- A. Endometriosis
- B. Vaginitis
- C. Mioma uteri
- D. Amenorea
- E. PCOS

Soal 2:

Pasien datang dengan keluhan nyeri hebat selama menstruasi, nyeri saat hubungan seksual, dan telah lama sulit memiliki keturunan. Diagnosis yang paling tepat untuk keluhan tersebut adalah:

- A. PID
- B. Endometriosis
- C. Kista ovarium
- D. Mioma uteri
- E. Oligomenorea

Soal 3:

Perempuan dengan sindrom ovarium polikistik (PCOS) biasanya mengalami gejala khas berikut ini, kecuali:

- A. Menstruasi tidak teratur
- B. Infertilitas
- C. Obesitas
- D. Rambut wajah berlebih (hirsutisme)
- E. Perdarahan menstruasi berlebihan

KUNCI JAWABAN:**Soal 1: Jawaban benar B****Pembahasan:**

Gejala seperti keputihan abnormal, gatal, dan nyeri saat berkemih sangat sesuai dengan vaginitis, yaitu peradangan pada vagina akibat infeksi.

Soal 2: Jawaban benar B**Pembahasan:**

Endometriosis ditandai oleh nyeri hebat selama menstruasi, nyeri saat hubungan seksual, dan infertilitas.

Soal 3: Jawaban benar E**Pembahasan:**

PCOS umumnya ditandai dengan menstruasi tidak teratur, infertilitas, obesitas, dan hirsutisme, tetapi tidak dengan perdarahan menstruasi yang berlebihan.

B. Proses Fisiologis dan Patofisiologis dalam Siklus Hidup Perempuan

Pemahaman terhadap proses fisiologis dan patofisiologis dalam siklus hidup perempuan sangat penting bagi bidan dalam memberikan asuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan perempuan.

1. Proses Fisiologis Siklus Hidup Perempuan

a. Pubertas

- Masa perubahan fisiologis saat tubuh perempuan mulai memproduksi hormon reproduksi (estrogen dan progesteron).
- Menarche (menstruasi pertama) terjadi sebagai tanda pubertas.

b. Siklus Menstruasi

- Siklus hormonal bulanan melibatkan fase folikuler, ovulasi, fase luteal, dan menstruasi.
- Tujuannya adalah mempersiapkan tubuh untuk potensi kehamilan.

c. Fertilisasi dan Kehamilan

- Pertemuan ovum dengan sperma menghasilkan zigot yang berkembang menjadi embrio.
- Implantasi embrio di dalam uterus dan perkembangan janin selama kurang lebih 40 minggu.

d. Persalinan

- Proses fisiologis keluarnya janin dari uterus melalui vagina.
- Terjadi melalui tiga kala: pembukaan serviks, pengeluaran bayi, dan pengeluaran plasenta.

e. Menopause

- Berhentinya siklus menstruasi secara permanen karena penurunan produksi hormon estrogen.
- Biasanya terjadi pada usia sekitar 45-55 tahun.

2. Proses Patofisiologis dalam Siklus Hidup Perempuan

a. Gangguan Menstruasi

- Amenorea: Tidak menstruasi minimal selama tiga bulan.
- Dismenorea: Nyeri menstruasi hebat.
- Menoragia: Perdarahan menstruasi berlebihan.

b. Gangguan Fertilitas

- Endometriosis: Jaringan endometrium tumbuh di luar rahim.
- PCOS (Polycystic Ovary Syndrome): Kelainan hormonal menyebabkan infertilitas.

c. Komplikasi Kehamilan dan Persalinan

- Preeklamsia dan eklamsia: Kondisi hipertensi selama kehamilan.
- Perdarahan postpartum: Perdarahan hebat setelah persalinan.

3. Gangguan pada Masa Menopause

- Osteoporosis: Penurunan kepadatan tulang akibat rendahnya estrogen.
- Penyakit jantung: Risiko meningkat setelah menopause akibat perubahan hormonal.

4. Peran Bidan dalam Proses Fisiologis dan Patofisiologis

- Melakukan edukasi terkait tahapan siklus hidup perempuan.
- Deteksi dini dan intervensi awal terhadap gangguan patofisiologis.
- Merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi bila diperlukan.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Apa istilah medis untuk kondisi ketika perempuan mengalami menstruasi yang sangat berat dan lama?

- A. Amenorea
- B. Dismenorea
- C. Menoragia
- D. Oligomenorea
- E. Polimenorea

Soal 2:

Seorang perempuan berusia 50 tahun datang dengan keluhan sering mengalami nyeri tulang dan mudah patah. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh:

- A. Endometriosis
- B. Osteoporosis akibat menopause
- C. PCOS
- D. Amenorea
- E. Dismenorea

Soal 3:

Komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, proteinuria, dan dapat berlanjut menjadi kejang disebut:

- A. Endometriosis
- B. Preeklamsia dan eklamsia
- C. Menoragia
- D. Amenorea
- E. Osteoporosis

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar C

Pembahasan:

Menoragia adalah perdarahan menstruasi yang berlebihan baik dari segi volume maupun durasi.

Soal 2: Jawaban benar B

Pembahasan:

Setelah menopause, produksi hormon estrogen menurun drastis sehingga meningkatkan risiko osteoporosis yang menyebabkan tulang mudah patah.

Soal 3: Jawaban benar B

Pembahasan:

Preeklamsia adalah kondisi kehamilan dengan gejala hipertensi dan proteinuria yang bila berlanjut bisa menyebabkan eklamsia, ditandai dengan kejang.

C. Dasar-Dasar Epidemiologi dalam Kebidanan

Pemahaman dasar tentang epidemiologi sangat penting bagi bidan dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan berbagai masalah kesehatan ibu dan bayi di komunitas.

1. Pengertian Epidemiologi

Epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan masalah kesehatan pada populasi tertentu, serta penerapan hasil studi tersebut dalam pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan.

2. Tujuan Epidemiologi dalam Kebidanan

- a. Mengidentifikasi faktor risiko yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan bayi.
- b. Menentukan distribusi kejadian penyakit atau masalah kesehatan di populasi tertentu.
- c. Merancang dan mengevaluasi program kesehatan ibu dan anak.
- d. Mengendalikan dan mencegah penyebaran penyakit di kalangan ibu dan bayi.

3. Istilah-Istilah Epidemiologi dalam Kebidanan

- a. Morbiditas: Angka kejadian penyakit dalam populasi tertentu.
- b. Mortalitas: Angka kematian dalam populasi tertentu.
- c. Insiden: Jumlah kasus baru suatu penyakit yang terjadi selama periode tertentu.

- d. Prevalensi: Jumlah total kasus penyakit yang ada pada waktu tertentu dalam suatu populasi.

4. Metode Epidemiologi

- a. Epidemiologi Deskriptif
- Menggambarkan distribusi penyakit menurut waktu, tempat, dan orang.
 - Contoh: Menghitung angka kematian ibu (AKI) di suatu daerah dalam periode tertentu.
- b. Epidemiologi Analitik
- Menyelidiki hubungan sebab-akibat penyakit dengan faktor risiko tertentu.
 - Contoh: Mengidentifikasi hubungan anemia selama kehamilan dengan kejadian perdarahan postpartum.
- c. Epidemiologi Eksperimental
- Menguji intervensi tertentu untuk mencegah atau mengontrol penyakit.
 - Contoh: Menguji efektivitas suplemen zat besi dalam mencegah anemia pada ibu hamil.

5. Peran Bidan dalam Epidemiologi Kebidanan

- Mengumpulkan data dan informasi kesehatan secara akurat dan lengkap.
- Berpartisipasi dalam surveilans epidemiologi untuk identifikasi dini masalah kesehatan.
- Edukasi masyarakat terkait pencegahan penyakit serta kesehatan ibu dan anak.
- Evaluasi efektivitas program kebidanan di komunitas.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Apa yang dimaksud dengan prevalensi dalam epidemiologi kebidanan?

- A. Jumlah kasus baru suatu penyakit dalam periode tertentu
- B. Jumlah total kasus penyakit yang ada pada waktu tertentu dalam suatu populasi
- C. Angka kematian dalam populasi tertentu
- D. Studi tentang hubungan sebab-akibat penyakit
- E. Studi intervensi kesehatan

Soal 2:

Jika seorang bidan melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara anemia pada ibu hamil dengan perdarahan postpartum, jenis epidemiologi apakah yang sedang dilakukan?

- A. Epidemiologi deskriptif
- B. Epidemiologi analitik
- C. Epidemiologi eksperimental
- D. Studi prevalensi
- E. Studi insiden

Soal 3:

Yang termasuk tujuan epidemiologi dalam kebidanan adalah, kecuali:

- A. Mengidentifikasi faktor risiko kesehatan ibu dan anak
- B. Mengendalikan dan mencegah penyakit di komunitas
- C. Merancang program kesehatan ibu dan bayi
- D. Mengobati penyakit kronis pada pasien individual
- E. Mengevaluasi efektivitas program kesehatan

KUNCI JAWABAN:**Soal 1: Jawaban benar B****Pembahasan:**

Prevalensi mengacu pada jumlah total kasus suatu penyakit atau kondisi yang ada pada waktu tertentu dalam suatu populasi.

Soal 2: Jawaban benar B**Pembahasan:**

Epidemiologi analitik bertujuan mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara penyakit dan faktor risikonya, seperti hubungan anemia selama kehamilan dengan perdarahan postpartum.

Soal 3: Jawaban benar D**Pembahasan:**

Epidemiologi berfokus pada studi populasi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit, bukan pengobatan individu secara langsung.

D. Evidence-Based Midwifery Practice (EBM)

Evidence-Based Midwifery (EBM) adalah praktik kebidanan yang menggunakan bukti ilmiah terkini, pengalaman klinis bidan, serta mempertimbangkan nilai dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis untuk memberikan asuhan kebidanan yang optimal.

1. Konsep Dasar EBM

EBM mengintegrasikan tiga komponen utama:

- a. **Bukti Ilmiah Terbaik:** Informasi ilmiah terbaru dari penelitian valid dan relevan.
- b. **Pengalaman Klinis Bidan:** Pengetahuan dan keterampilan praktis bidan dalam memberikan asuhan.
- c. **Preferensi dan Nilai Pasien:** Kebutuhan, keinginan, dan keyakinan pasien yang harus dihargai dalam asuhan.

2. Tujuan Evidence-Based Midwifery

- a. Meningkatkan kualitas asuhan kebidanan.
- b. Menjamin keamanan pasien melalui praktik klinis berbasis bukti.
- c. Mengurangi praktik yang tidak perlu atau berpotensi berbahaya.
- d. Mengoptimalkan hasil kesehatan ibu dan bayi.

3. Langkah-langkah Praktik *Evidence-Based Midwifery*

- a. Merumuskan Pertanyaan Klinis (PICO)
 - P (Population): Populasi pasien
 - I (Intervention): Intervensi yang akan dilakukan
 - C (Comparison): Pembandingan intervensi (jika ada)
 - O (Outcome): Hasil yang diharapkan
- b. Pencarian Bukti Ilmiah
Menggunakan basis data penelitian seperti PubMed, Cochrane Library.
- c. Penilaian Kritis Bukti Ilmiah
Mengevaluasi validitas, relevansi, dan aplikabilitas penelitian.
- d. Penerapan Hasil Penelitian dalam Praktik Klinis
Menerapkan intervensi yang sudah terbukti efektif dalam asuhan kebidanan.
- e. Evaluasi Praktik
Menilai efektivitas dan dampak praktik berbasis bukti pada pasien.

4. Tingkatan Bukti Ilmiah dalam EBM

- a. **Level I:** Systematic review atau meta-analysis dari randomized controlled trials (RCT).
- b. **Level II:** Randomized controlled trials tunggal.

- c. **Level III:** Studi kohort atau case-control.
- d. **Level IV:** Studi cross-sectional atau survei.
- e. **Level V:** Pendapat ahli atau laporan kasus.

5. Manfaat Evidence-Based Midwifery

- Menjamin keputusan klinis berdasarkan bukti yang terbaik.
- Meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan kebidanan.
- Mendukung profesionalisme bidan melalui praktik ilmiah.

6. Tantangan dalam Penerapan EBM

- Keterbatasan akses terhadap informasi ilmiah terbaru.
- Kurangnya keterampilan dalam pencarian dan penilaian kritis bukti ilmiah.
- Resistensi terhadap perubahan praktik klinis yang sudah ada.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Dalam praktik Evidence-Based Midwifery, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang bidan adalah:

- A. Menerapkan intervensi terbaru secara langsung
- B. Melakukan pencarian bukti ilmiah
- C. Merumuskan pertanyaan klinis menggunakan metode PICO
- D. Menilai hasil penelitian
- E. Mengubah prosedur klinis

Soal 2:

Studi atau penelitian dengan tingkat bukti ilmiah tertinggi dalam EBM adalah:

- A. Laporan kasus
- B. Studi cross-sectional
- C. Studi kohort
- D. Randomized controlled trials tunggal
- E. Systematic review atau meta-analysis dari RCT

Soal 3:

Seorang bidan kesulitan mendapatkan akses penelitian terbaru untuk praktik kebidanannya. Apa strategi yang paling tepat dilakukan bidan dalam mengatasi tantangan ini?

- A. Menggunakan pengalaman klinis sendiri tanpa referensi tambahan
- B. Mengabaikan hasil penelitian terbaru
- C. Mengikuti pelatihan dan workshop tentang pencarian literatur ilmiah

- D. Hanya bergantung pada protokol lama
- E. Menunggu rekan kerja yang mencari informasi ilmiah

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar C

Pembahasan:

Langkah pertama dalam EBM adalah merumuskan pertanyaan klinis dengan jelas menggunakan metode PICO untuk menentukan arah pencarian bukti ilmiah.

Soal 2: Jawaban benar E

Pembahasan:

Systematic review atau meta-analysis dari randomized controlled trials (RCT) dianggap sebagai tingkat bukti ilmiah tertinggi karena menyediakan ringkasan komprehensif dan valid dari berbagai studi berkualitas tinggi.

Soal 3: Jawaban benar C

Pembahasan:

Untuk mengatasi tantangan keterbatasan akses informasi, bidan disarankan mengikuti pelatihan atau workshop yang mengajarkan keterampilan dalam pencarian dan penilaian kritis bukti ilmiah.

Area 5

Keterampilan Klinis Praktik Kebidanan

A. Masa Pranikah dan Prakonsepsi

Keterampilan klinis bidan dalam memberikan asuhan selama masa pranikah dan prakonsepsi sangat penting untuk menjamin kesehatan calon pasangan serta mempersiapkan kehamilan yang optimal.

1. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin

a. Tujuan Pemeriksaan

- Mendeteksi kondisi kesehatan yang dapat mempengaruhi kehidupan reproduksi dan pernikahan.
- Mengidentifikasi risiko gangguan kesehatan reproduksi.
- Memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi.

b. Pemeriksaan yang Dilakukan

- Pemeriksaan fisik umum: tekanan darah, tinggi badan, berat badan, IMT.
- Pemeriksaan organ reproduksi: USG pelvis, pemeriksaan organ genital eksternal.
- Pemeriksaan laboratorium: hemoglobin, golongan darah, hepatitis B, HIV/AIDS, sifilis, gula darah, urin rutin.

c. Edukasi Penting

- Informasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan organ reproduksi.
- Pencegahan penyakit menular seksual.
- Pentingnya komunikasi antar pasangan tentang kesehatan seksual dan reproduksi.

2. Persiapan Kehamilan Sehat

a. Nutrisi

- Edukasi tentang diet seimbang yang kaya akan zat besi, kalsium, asam folat, protein, dan vitamin.
- Pemberian suplemen asam folat (400 mikrogram/hari) untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin.
- Konseling pengelolaan berat badan ideal.

b. Vaksinasi

- Vaksinasi Rubella (MMR) untuk mencegah sindrom rubella kongenital.
- Vaksinasi Hepatitis B untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke bayi.
- Vaksinasi Tetanus Toksoid untuk mencegah tetanus neonatal.

3. Skrining Penyakit Genetik

- Anamnesis dan identifikasi riwayat penyakit keturunan di keluarga.
- Rujukan pemeriksaan genetik jika ditemukan faktor risiko penyakit genetik (misalnya Thalassemia, Down Syndrome, cystic fibrosis).

PERTANYAAN:

Soal 1:

Apa tujuan utama dari pemberian suplemen asam folat selama masa prakonsepsi?

- A. Meningkatkan berat badan ibu
- B. Mencegah anemia pada ibu
- C. Mencegah cacat tabung saraf pada janin
- D. Mengurangi risiko diabetes gestasional
- E. Mencegah infeksi hepatitis B

Soal 2:

Seorang wanita calon pengantin belum mendapatkan vaksinasi rubella. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan bidan?

- A. Memberikan vaksinasi rubella segera sebelum menikah
- B. Menunda vaksinasi hingga setelah kelahiran anak pertama
- C. Memberikan vaksinasi rubella minimal satu bulan sebelum merencanakan kehamilan
- D. Memberikan vaksinasi rubella selama kehamilan trimester pertama
- E. Mengabaikan vaksinasi rubella karena tidak wajib

Soal 3:

Pemeriksaan kesehatan pranikah menemukan bahwa calon pengantin memiliki riwayat keluarga Thalassemia. Apa rekomendasi tindakan yang paling tepat?

- A. Segera melakukan vaksinasi lengkap
- B. Mengabaikan karena tidak berisiko
- C. Melakukan konseling nutrisi
- D. Merujuk ke pemeriksaan genetik lebih lanjut
- E. Menyarankan segera menikah

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar C

Pembahasan:

Pemberian suplemen asam folat sebelum kehamilan bertujuan utama untuk mencegah terjadinya cacat tabung saraf pada janin, seperti spina bifida dan anensefali.

Soal 2: Jawaban benar C

Pembahasan:

Vaksinasi rubella dianjurkan minimal satu bulan sebelum kehamilan direncanakan, untuk mencegah sindrom rubella kongenital pada janin.

Soal 3: Jawaban benar D

Pembahasan:

Jika ditemukan riwayat penyakit keturunan seperti Thalassemia, calon pengantin perlu dirujuk untuk melakukan pemeriksaan genetik lebih lanjut untuk menentukan risiko dan perencanaan kehamilan yang aman.

B. Masa Kehamilan (Antenatal Care - ANC Terpadu)

Pemeriksaan antenatal care (ANC) terpadu adalah pelayanan kesehatan komprehensif yang diberikan kepada ibu hamil untuk memastikan kondisi ibu dan janin tetap sehat selama masa kehamilan, serta mempersiapkan ibu menuju persalinan yang aman.

1. Pemeriksaan Kehamilan Fisiologis (ANC Terpadu)

a. Tujuan Pemeriksaan ANC Terpadu

- Memantau kesehatan ibu dan perkembangan janin secara berkala.
- Mendeteksi dini risiko dan komplikasi selama kehamilan.
- Memberikan edukasi kesehatan kepada ibu hamil tentang kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi baru lahir.

b. Komponen Pemeriksaan ANC Terpadu

1) Anamnesis

- Identifikasi keluhan ibu hamil.
- Riwayat kehamilan sekarang dan sebelumnya.
- Riwayat kesehatan pribadi dan keluarga.

2) Pemeriksaan Fisik Umum

- Tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, pernapasan.
- Tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh (IMT).

3) Pemeriksaan Obstetri

- Palpasi abdomen untuk menentukan posisi janin, tinggi fundus uteri, dan usia kehamilan.

- Pengukuran lingkar perut.
 - Deteksi denyut jantung janin menggunakan Doppler atau stetoskop khusus janin.
- 4) Pemeriksaan Laboratorium
Pemeriksaan hemoglobin, golongan darah, gula darah, urin rutin, tes HIV/AIDS, hepatitis B, dan sifilis.
- 5) Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)
- Menilai pertumbuhan dan perkembangan janin.
 - Menentukan usia kehamilan secara akurat.
 - Mengidentifikasi kelainan janin secara dini.
- 6) Imunisasi
Pemberian vaksinasi Tetanus Toksoid (TT) untuk mencegah tetanus neonatal.
- c. Jadwal Kunjungan ANC**
Minimal empat kali kunjungan: Trimester pertama (0-12 minggu), trimester kedua (13-28 minggu), trimester ketiga (minimal dua kunjungan pada 29-40 minggu).
- d. Edukasi Selama ANC**
- Nutrisi selama kehamilan.
 - Mengenali tanda bahaya kehamilan.
 - Pentingnya istirahat dan aktivitas fisik yang seimbang.
 - Persiapan persalinan dan rencana persalinan yang aman.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Seorang ibu hamil melakukan kunjungan ANC pertama pada usia kehamilan 8 minggu. Pemeriksaan apa yang paling tepat dilakukan pada kunjungan pertama ini?

- A. Pemeriksaan tinggi fundus uteri
- B. Pemeriksaan denyut jantung janin dengan Doppler
- C. Pemeriksaan USG untuk menentukan usia kehamilan secara akurat
- D. Pemeriksaan posisi janin
- E. Pemeriksaan laboratorium rutin

Soal 2:

Berapa jumlah minimal kunjungan ANC yang direkomendasikan selama masa kehamilan?

- A. Tiga kali
- B. Empat kali
- C. Lima kali

- D. Enam kali
- E. Dua kali

Soal 3:

Pemberian imunisasi Tetanus Toksoid (TT) pada ibu hamil bertujuan untuk:

- A. Mengurangi risiko diabetes gestasional
- B. Meningkatkan berat badan janin
- C. Mencegah tetanus neonatal
- D. Mencegah hipertensi kehamilan
- E. Meningkatkan produksi ASI

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar C

Pembahasan:

Pada usia kehamilan 8 minggu, pemeriksaan USG sangat penting untuk memastikan usia kehamilan secara akurat dan mengidentifikasi kondisi awal janin.

Soal 2: Jawaban benar B

Pembahasan:

Menurut standar pelayanan kesehatan ibu, minimal kunjungan ANC yang dianjurkan adalah empat kali selama masa kehamilan.

Soal 3 Jawaban benar C

Pembahasan:

Imunisasi TT diberikan kepada ibu hamil untuk mencegah terjadinya tetanus neonatal pada bayi yang baru lahir.

2. Identifikasi Dini dan Tatalaksana Komplikasi Kehamilan

Pemahaman mendalam tentang identifikasi dini dan tatalaksana komplikasi kehamilan sangat penting bagi bidan untuk memberikan intervensi yang tepat dan cepat demi keselamatan ibu dan janin.

a. Preeklamsia/Eklamsia

Identifikasi Dini:

- Tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu.
- Proteinuria (protein dalam urin ≥ 300 mg dalam 24 jam).
- Edema ekstremitas, wajah, atau tubuh bagian atas.

Tatalaksana:

- Istirahat total dengan pemantauan ketat.

- Pemantauan tekanan darah rutin.
- Pemberian antihipertensi jika tekanan darah tinggi persisten.
- Magnesium sulfat untuk mencegah kejang (eklamsia).
- Rujukan segera jika terjadi tanda perburukan.

b. Diabetes Mellitus Gestasional

Identifikasi Dini:

- Pemeriksaan gula darah pada trimester pertama dan kedua.
- Tes toleransi glukosa oral (TTGO).

Tatalaksana:

- Pengaturan diet dan aktivitas fisik.
- Pemantauan gula darah rutin.
- Insulin jika kadar gula darah tidak terkontrol dengan diet.
- Persiapan persalinan di fasilitas kesehatan dengan tenaga terlatih.

c. Anemia, Hiperemesis Gravidarum, KPD

Anemia

- Identifikasi dini: Pemeriksaan Hb rutin (Hb <11 g/dl).
- Tatalaksana: Suplementasi zat besi, edukasi diet tinggi zat besi, pemantauan Hb rutin.

Hiperemesis Gravidarum

- Identifikasi dini: Mual muntah hebat, dehidrasi, penurunan berat badan >5%.
- Tatalaksana: Koreksi cairan dan elektrolit, pemberian antiemetik, edukasi diet yang tepat.

Ketuban Pecah Dini (KPD)

- Identifikasi dini: Keluar cairan jernih dari vagina sebelum onset persalinan.
- Tatalaksana: Pemantauan infeksi, antibiotik profilaksis, mempertimbangkan induksi persalinan jika usia kehamilan cukup.

d. Perdarahan Antepartum

Plasenta Previa

- Identifikasi dini: Perdarahan tanpa nyeri, warna darah merah segar, biasanya setelah 28 minggu.
- Tatalaksana: Observasi, tirah baring, menghindari pemeriksaan vagina, persiapan persalinan secara sectio caesarea jika plasenta previa total.

Solusio Plasenta

- Identifikasi dini: Perdarahan dengan nyeri perut hebat, rahim tegang, tanda gawat janin.
- Tatalaksana: Penanganan segera di rumah sakit, persiapan tindakan emergensi, stabilisasi ibu dan janin, persalinan segera bila memungkinkan.

PERTANYAAN:**Soal 1:**

Seorang ibu hamil dengan tekanan darah 150/100 mmHg dan protein dalam urin positif. Apa diagnosis yang paling tepat?

- A. Diabetes mellitus gestasional
- B. Anemia
- C. Preeklamsia
- D. Hiperemesis gravidarum
- E. Plasenta previa

Soal 2:

Ibu hamil dengan riwayat mual muntah hebat selama satu minggu terakhir, mengalami penurunan berat badan hingga 6% dari berat awal. Diagnosis apa yang paling mungkin?

- A. Anemia
- B. Preeklamsia
- C. Diabetes mellitus gestasional
- D. Hiperemesis gravidarum
- E. Ketuban pecah dini (KPD)

Soal 3:

Seorang ibu hamil datang dengan keluhan perdarahan merah segar tanpa nyeri perut pada usia kehamilan 32 minggu. Pemeriksaan vagina tidak dilakukan. Diagnosis apa yang paling mungkin?

- A. Solusio plasenta
- B. Plasenta previa
- C. Preeklamsia
- D. Diabetes mellitus gestasional
- E. Hiperemesis gravidarum

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar C

Pembahasan:

Tekanan darah tinggi disertai proteinuria setelah 20 minggu kehamilan merupakan tanda klasik preeklamsia.

Soal 2: Jawaban benar D

Pembahasan:

Penurunan berat badan lebih dari 5% disertai mual muntah hebat menunjukkan diagnosis hiperemesis gravidarum.

Soal 3: Jawaban benar B

Pembahasan:

Perdarahan antepartum tanpa nyeri perut merupakan tanda khas plasenta previa. Pemeriksaan vagina harus dihindari untuk mencegah perdarahan lebih lanjut.

3. Interpretasi Hasil Pemeriksaan USG Sederhana

Ultrasonografi (USG) sederhana adalah alat diagnostik penting dalam praktik kebidanan untuk mengevaluasi kesehatan dan perkembangan janin selama kehamilan. Bidan harus memiliki keterampilan dasar dalam menginterpretasi hasil pemeriksaan USG sederhana.

a. Tujuan Pemeriksaan USG Sederhana dalam Kehamilan

- Menentukan usia kehamilan secara akurat.
- Memastikan letak dan posisi janin.
- Menilai jumlah cairan amnion.
- Menilai denyut jantung janin (DJJ).
- Mendeteksi kehamilan ganda.

b. Parameter yang Dinilai pada USG Sederhana

1) Usia Kehamilan

- Menggunakan ukuran Crown Rump Length (CRL) pada trimester pertama.
- Menggunakan Biparietal Diameter (BPD), Femur Length (FL), dan Head Circumference (HC) pada trimester kedua dan ketiga.

2) Posisi dan Presentasi Janin

Menilai apakah janin dalam posisi kepala (presentasi kepala), sungsang, atau melintang.

3) Cairan Amnion

Volume normal (AFI: 8-18 cm), oligohidramnion (<5 cm), polihidramnion (>24 cm).

4) Denyut Jantung Janin (DJJ)
Normal antara 120-160 kali per menit.

5) Jumlah Janin
Identifikasi kehamilan tunggal atau ganda.

c. Langkah-langkah Interpretasi Hasil USG Sederhana

- 1) Identifikasi struktur utama (kepala, badan, anggota tubuh janin).
- 2) Pengukuran parameter janin (CRL, BPD, FL, HC).
- 3) Penilaian posisi dan letak janin.
- 4) Penilaian volume cairan amnion.
- 5) Penilaian DJJ dan ritme jantung janin.

d. Edukasi kepada Ibu Hamil

- Penjelasan hasil pemeriksaan dengan jelas dan sederhana.
- Menginformasikan hasil normal dan memberikan rujukan segera jika ditemukan kelainan.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Bidan melakukan pemeriksaan USG sederhana pada ibu hamil usia 12 minggu. Parameter apakah yang paling tepat digunakan untuk menentukan usia kehamilan saat ini?

- A. Femur Length (FL)
- B. Crown Rump Length (CRL)
- C. Biparietal Diameter (BPD)
- D. Head Circumference (HC)
- E. Abdominal Circumference (AC)

Soal 2:

Hasil pemeriksaan USG sederhana menunjukkan volume cairan amnion (AFI) sebesar 3 cm. Bagaimana interpretasi hasil ini?

- A. Normal
- B. Polihidramnion
- C. Oligohidramnion
- D. Hidrops fetalis
- E. Normal atas

Soal 3:

Pemeriksaan USG sederhana menemukan DJJ sebesar 145 kali per menit. Interpretasi yang tepat dari hasil tersebut adalah:

- A. Bradikardia janin
- B. Takikardia janin
- C. Aritmia janin

- D. Hipoksia janin
- E. Denyut jantung janin normal

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar B

Pembahasan:

Crown Rump Length (CRL) merupakan parameter paling akurat untuk menentukan usia kehamilan pada trimester pertama.

Soal 2: Jawaban benar C

Pembahasan:

AFI kurang dari 5 cm menunjukkan kondisi oligohidramnion atau jumlah cairan ketuban yang rendah.

Soal 3: Jawaban benar E

Pembahasan:

Denyut jantung janin normal berkisar antara 120-160 kali per menit. Angka 145 kali per menit termasuk dalam rentang normal.

C. Persalinan dan Kelahiran

1. Asuhan Persalinan Normal

Asuhan Persalinan Normal (APN) adalah asuhan yang diberikan kepada ibu selama proses persalinan dan kelahiran bayi secara fisiologis, aman, bersih, dan sesuai standar terbaru.

a. Tahapan APN

60 Langkah Asuhan Persalinan Normal (APN Terbaru)

Kala I (Pembukaan Serviks) dalam Asuhan Persalinan Normal (APN)

Kala I persalinan adalah periode dari awal kontraksi teratur hingga pembukaan lengkap serviks (10 cm). Berikut penjelasan detail dari setiap langkah pada Kala I:

- 1) Menyambut ibu dengan ramah
Sambut ibu dan keluarga secara sopan, ramah, dan penuh perhatian untuk menciptakan suasana nyaman.
- 2) Mengidentifikasi ibu dan mencatat identitas lengkap
Catat identitas lengkap ibu (nama, umur, alamat, dan nomor kontak), untuk memastikan pelayanan tepat sasaran.
- 3) Mengisi partograf dengan data awal
Catat semua data awal persalinan di partograf termasuk waktu mulai kontraksi, tanda vital ibu, dan pembukaan serviks awal.

- 4) Melakukan anamnesis riwayat kehamilan
Tanyakan riwayat kehamilan sekarang dan sebelumnya, identifikasi risiko yang mungkin muncul selama persalinan.
- 5) Mengukur tanda-tanda vital ibu
Lakukan pengukuran tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan ibu untuk mendeteksi dini kelainan yang mungkin timbul.
- 6) Memeriksa tinggi fundus uteri
Ukur tinggi fundus uteri untuk menentukan perkiraan usia kehamilan dan pertumbuhan janin.
- 7) Melakukan palpasi abdomen untuk menentukan posisi dan presentasi janin
Palpasi abdomen ibu untuk memastikan posisi dan presentasi janin normal (misalnya presentasi kepala).
- 8) Mengukur denyut jantung janin (DJJ)
Monitor DJJ secara berkala untuk mengetahui kondisi janin, normalnya 120-160 kali per menit.
- 9) Melakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui pembukaan serviks
Pemeriksaan dalam secara steril dan hati-hati untuk menilai progres pembukaan serviks.
- 10) Mengobservasi kontraksi uterus
Observasi intensitas, durasi, dan frekuensi kontraksi untuk memastikan persalinan berlangsung normal.
- 11) Mengajarkan ibu teknik pernapasan saat kontraksi
Ajarkan ibu teknik bernapas lambat dan dalam untuk mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan relaksasi.
- 12) Memberikan dukungan emosional kepada ibu dan keluarga
Berikan dukungan moral, empati, dan semangat agar ibu dan keluarga merasa aman dan didukung.
- 13) Memberikan edukasi tentang tanda bahaya persalinan
Informasikan tanda bahaya seperti perdarahan berlebih, nyeri hebat, dan penurunan gerakan janin yang memerlukan tindakan segera.
- 14) Mengingatkan ibu untuk buang air kecil secara teratur
Anjurkan ibu untuk berkemih secara teratur untuk menjaga kenyamanan dan membantu proses persalinan.
- 15) Menyediakan cairan oral untuk ibu
Berikan minuman hangat atau air mineral agar ibu tetap terhidrasi dengan baik selama proses persalinan.

- 16) Membantu ibu untuk posisi nyaman
Bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman seperti duduk, jongkok, atau berbaring miring untuk mempercepat pembukaan serviks dan mengurangi nyeri kontraksi.

Kala II (Pengeluaran Bayi) dalam Asuhan Persalinan Normal (APN)

Kala II persalinan adalah tahap di mana terjadi proses pengeluaran bayi setelah pembukaan serviks lengkap (10 cm). Berikut penjelasan detail dari setiap langkah pada Kala II:

- 17) Mengatur posisi ibu (semi-duduk/jongkok)
Posisikan ibu dalam keadaan semi-duduk atau jongkok untuk memanfaatkan gravitasi sehingga memudahkan proses pengeluaran bayi dan mengurangi tekanan pada perineum.
- 18) Menganjurkan ibu mengejan secara alami
Dorong ibu untuk mengejan hanya ketika merasakan dorongan alami, hindari mengejan paksa atau terlalu lama untuk mengurangi risiko trauma jaringan.
- 19) Mengingatkan ibu beristirahat di antara kontraksi
Pastikan ibu beristirahat dan rileks di antara kontraksi untuk mengumpulkan energi dan mencegah kelelahan.
- 20) Memantau DJJ setiap 5 menit selama kala II
Monitor denyut jantung janin setiap 5 menit secara teratur untuk segera mendeteksi dan menangani potensi distress janin.
- 21) Melakukan teknik proteksi perineum
Gunakan teknik proteksi perineum seperti "hands-on" dengan menopang perineum saat kepala bayi keluar secara perlahan untuk mencegah ruptur.
- 22) Memastikan peralatan persalinan steril
Persiapkan dan pastikan semua peralatan yang digunakan untuk persalinan steril agar mencegah risiko infeksi pada ibu dan bayi.
- 23) Menyiapkan kain bersih untuk menyambut bayi
Siapkan kain bersih dan hangat yang akan digunakan untuk menerima bayi sesaat setelah dilahirkan.
- 24) Membantu kepala bayi lahir perlahan
Bantu kepala bayi lahir secara perlahan, kendalikan proses agar tidak terjadi trauma pada kepala bayi maupun perineum ibu.
- 25) Melakukan pengisapan lendir mulut dan hidung bayi jika perlu
Segera lakukan pengisapan lendir pada mulut dan hidung bayi jika ditemukan sumbatan lendir atau mekonium untuk memastikan jalan napas bayi bersih.

- 26) Membantu melahirkan bahu dan badan bayi dengan lembut
Bantu keluarnya bahu dan badan bayi secara perlahan dan lembut, hindari tarikan kuat yang dapat menyebabkan cedera pada bayi.
- 27) Segera menempatkan bayi di dada ibu untuk IMD
Letakkan bayi segera di dada ibu untuk melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), mendukung ikatan emosional ibu-bayi dan stabilisasi suhu bayi.
- 28) Mengeringkan tubuh bayi dengan kain bersih
Segera keringkan tubuh bayi dengan kain bersih untuk mencegah kehilangan panas tubuh dan hipotermia.
- 29) Melakukan penjepitan dan pemotongan tali pusat setelah denyut berhenti
Lakukan penjepitan dan pemotongan tali pusat secara hati-hati setelah denyut tali pusat berhenti untuk memastikan bayi menerima cukup darah dari plasenta.
- 30) Memberikan oksitosin 10 IU IM setelah bayi lahir
Segera setelah bayi lahir, berikan injeksi oksitosin 10 IU intramuskular kepada ibu untuk mencegah perdarahan postpartum dengan membantu kontraksi uterus.

Kala III (Pengeluaran Plasenta) dalam Asuhan Persalinan Normal (APN)

Kala III persalinan adalah tahap setelah kelahiran bayi hingga plasenta keluar secara lengkap. Berikut penjelasan detail setiap langkah pada Kala III:

- 31) Melakukan penegangan tali pusat terkendali (PTT)
Lakukan penegangan tali pusat terkendali dengan lembut dan hati-hati sambil menopang fundus uteri untuk membantu keluarnya plasenta secara aman dan mencegah inversio uteri.
- 32) Memastikan plasenta keluar utuh
Periksa dengan teliti plasenta setelah dikeluarkan untuk memastikan tidak ada bagian plasenta yang tertinggal di dalam uterus, yang dapat menyebabkan perdarahan postpartum dan infeksi.
- 33) Melakukan pemeriksaan plasenta dan selaput ketuban secara menyeluruh
Teliti plasenta dan selaput ketuban secara seksama untuk memastikan kelengkapan dan keutuhan, serta deteksi dini komplikasi seperti retensi plasenta.

- 34) Mengobservasi tanda-tanda vital ibu
Pantau tanda-tanda vital ibu (tekanan darah, nadi, suhu, respirasi) secara berkala untuk mendeteksi dini komplikasi pasca persalinan seperti perdarahan atau infeksi.
- 35) Melakukan pemeriksaan perdarahan
Observasi jumlah dan warna perdarahan secara teliti untuk mengidentifikasi perdarahan yang berlebihan dan mengambil tindakan segera jika terjadi perdarahan postpartum.
- 36) Memijat lembut fundus uteri setelah plasenta lahir
Pijat fundus uteri dengan lembut setelah plasenta keluar untuk memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan mencegah perdarahan postpartum.
- 37) Mengajarkan ibu mengenali tanda-tanda perdarahan abnormal
Berikan edukasi kepada ibu mengenai tanda-tanda perdarahan abnormal seperti darah keluar dalam jumlah banyak, peningkatan denyut nadi, atau pusing, sehingga ibu dapat segera melaporkan kondisi tersebut.
- 38) Memastikan kenyamanan ibu pasca persalinan
Pastikan kenyamanan ibu dengan menjaga kebersihan tubuhnya, menyediakan minuman hangat atau makanan ringan, dan membantu ibu dalam posisi yang nyaman setelah proses persalinan selesai.

Kala IV (Pemantauan Pasca Persalinan) dalam Asuhan Persalinan Normal (APN)

Kala IV adalah tahap pemantauan intensif terhadap kondisi ibu dan bayi setelah kelahiran plasenta hingga kondisi ibu stabil. Berikut penjelasan detail setiap langkah pada Kala IV:

- 39) Memeriksa tanda-tanda vital ibu setiap 15 menit selama satu jam pertama
Pantau tekanan darah, nadi, suhu, dan respirasi secara rutin setiap 15 menit untuk memastikan kondisi ibu stabil.
- 40) Memantau perdarahan vagina
Amati perdarahan vagina secara teratur untuk mendeteksi dini perdarahan postpartum yang abnormal.
- 41) Mengobservasi kontraksi uterus secara teratur
Pastikan uterus berkontraksi dengan baik untuk mencegah perdarahan postpartum dengan palpasi lembut secara berkala.

- 42) Memastikan ibu mendapatkan asupan cairan dan makanan ringan
Berikan cairan dan makanan ringan kepada ibu untuk mengembalikan energi yang hilang selama persalinan.
- 43) Memeriksa tinggi fundus uteri secara berkala
Ukur tinggi fundus uteri secara rutin untuk memastikan involusi uterus berjalan normal dan cepat mendeteksi kelainan.
- 44) Mengajarkan ibu menyusui bayi dengan benar
Ajarkan teknik menyusui yang benar agar bayi mendapatkan asupan nutrisi optimal dan mempercepat involusi uterus.
- 45) Menyediakan waktu untuk IMD minimal 1 jam
Berikan waktu minimal satu jam untuk proses Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang mendukung bonding dan menyusui eksklusif.
- 46) Menilai kondisi umum bayi (warna kulit, pernapasan, gerakan)
Evaluasi kondisi bayi dengan memperhatikan warna kulit, pola pernapasan, dan gerakan untuk memastikan kesehatannya optimal.
- 47) Mengukur berat badan bayi
Lakukan pengukuran berat badan bayi segera setelah kondisi stabil untuk mencatat berat lahir.
- 48) Memberikan vitamin K kepada bayi
Berikan injeksi vitamin K kepada bayi untuk mencegah perdarahan akibat defisiensi vitamin K.
- 49) Mengoleskan salep mata antibiotik pada bayi
Berikan salep mata antibiotik untuk mencegah infeksi mata neonatus akibat transmisi dari ibu saat persalinan.
- 50) Memastikan bayi dalam kondisi hangat dengan teknik kontak kulit ke kulit
Lakukan kontak kulit ke kulit untuk menjaga suhu tubuh bayi tetap hangat dan stabil.
- 51) Mengisi catatan persalinan dan kelahiran secara lengkap dan akurat
Lengkapi dokumentasi semua informasi penting mengenai proses persalinan dan kondisi ibu-bayi dengan rinci dan akurat.
- 52) Memberikan edukasi tentang perawatan luka perineum
Ajarkan ibu cara menjaga kebersihan dan merawat luka perineum untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan.

- 53) Mengingatnkan ibu tentang tanda bahaya pasca persalinan
Informasikan ibu mengenai tanda-tanda bahaya postpartum seperti demam, perdarahan berlebihan, dan nyeri hebat agar ibu dapat melaporkan segera jika terjadi.
- 54) Menyusun rencana tindak lanjut (kunjungan postpartum berikutnya)
Susun jadwal kunjungan postpartum untuk memantau kondisi ibu dan bayi selanjutnya secara terencana.
- 55) Menginformasikan pentingnya imunisasi bayi
Berikan edukasi mengenai pentingnya imunisasi untuk menjaga kesehatan bayi di masa depan.
- 56) Melakukan observasi pertama kali bayi buang air kecil dan besar
Catat waktu pertama kali bayi buang air kecil dan besar untuk memastikan fungsi ekskresi bayi normal.
- 57) Memberikan konseling KB postpartum
Berikan konseling keluarga berencana postpartum untuk membantu ibu merencanakan jarak kehamilan berikutnya secara aman dan sehat.
- 58) Menyediakan edukasi tentang kebersihan diri ibu dan bayi
Ajarkan ibu mengenai pentingnya kebersihan diri dan bayi untuk mencegah infeksi.
- 59) Menyediakan waktu untuk ibu bertanya dan menyampaikan keluhan
Berikan kesempatan kepada ibu untuk bertanya dan menyampaikan keluhan sehingga dapat segera ditangani.
- 60) Melakukan dokumentasi akhir dan memberikan salam penutup yang ramah
Selesaikan dokumentasi lengkap mengenai seluruh proses persalinan dan berikan salam penutup yang hangat kepada ibu dan keluarga.

b. Prinsip Dasar APN

- Asuhan berfokus pada ibu dan bayi.
- Mengurangi intervensi yang tidak diperlukan.
- Menjamin keamanan dan kenyamanan ibu selama persalinan.
- Mendorong peran aktif ibu dalam persalinan.

c. Edukasi Penting Selama APN

- Edukasi mengenai manfaat IMD dan menyusui eksklusif.
- Pentingnya mobilisasi dini pasca persalinan.
- Tanda bahaya postpartum yang harus segera dilaporkan ke tenaga kesehatan.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Apa tindakan pertama yang paling tepat dilakukan segera setelah bayi lahir menurut APN terbaru?

- A. Memberikan vitamin K pada bayi
- B. Melakukan penghisapan lendir rutin pada bayi
- C. Memandikan bayi dengan segera
- D. Mengukur berat badan bayi
- E. Memberikan oksitosin 10 IU intramuskular pada ibu

Soal 2:

Mengapa posisi semi-duduk atau jongkok dianjurkan saat ibu mengejan dalam persalinan normal?

- A. Untuk mempercepat pembukaan serviks
- B. Untuk mempermudah pemantauan denyut jantung janin
- C. Mengurangi risiko ruptur perineum dan mempermudah keluarnya bayi
- D. Untuk meningkatkan produksi hormon oksitosin
- E. Memudahkan pemberian oksitosin

Soal 3:

Pemantauan yang harus dilakukan oleh bidan pada kala IV persalinan adalah:

- A. Pemeriksaan pembukaan serviks setiap 15 menit
- B. Pemeriksaan tanda-tanda vital ibu dan kondisi kontraksi uterus setiap 15 menit
- C. Pemberian vitamin K pada bayi
- D. Pemeriksaan berat badan bayi
- E. Mengukur tinggi fundus uteri setiap 1 jam

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar E

Pembahasan:

Tindakan pertama menurut APN terbaru segera setelah bayi lahir adalah pemberian oksitosin 10 IU IM kepada ibu untuk mengurangi risiko perdarahan postpartum.

Soal 2: Jawaban benar C**Pembahasan:**

Posisi semi-duduk atau jongkok dianjurkan karena membantu mengurangi risiko ruptur perineum dan mempermudah proses kelahiran bayi dengan memanfaatkan gravitasi.

Soal 3: Jawaban benar B**Pembahasan:**

Pemantauan utama pada kala IV adalah tanda-tanda vital ibu dan kondisi kontraksi uterus setiap 15 menit pada satu jam pertama untuk memastikan tidak terjadi komplikasi seperti perdarahan postpartum.

2. Manajemen Kala Persalinan I hingga IV

Manajemen persalinan merupakan keterampilan klinis esensial bagi seorang bidan. Pemahaman yang baik tentang tahapan persalinan sangat penting untuk memberikan asuhan berkualitas kepada ibu dan bayi.

a. Manajemen Kala I (Pembukaan Serviks)**Tujuan:**

- Memastikan persalinan berlangsung aman dan nyaman bagi ibu.
- Memonitor progres pembukaan serviks secara teratur.

Tindakan:

- 1) Menyambut ibu dengan ramah.
- 2) Mengidentifikasi ibu dan mencatat identitas lengkap.
- 3) Melakukan anamnesis riwayat kehamilan.
- 4) Memeriksa tanda-tanda vital ibu secara berkala (tekanan darah, nadi, suhu, respirasi).
- 5) Melakukan pemeriksaan fisik (tinggi fundus uteri, palpasi abdomen).
- 6) Mengukur denyut jantung janin secara rutin.
- 7) Melakukan pemeriksaan dalam untuk menilai pembukaan serviks.
- 8) Memantau kontraksi uterus.
- 9) Memberikan dukungan emosional dan edukasi tentang proses persalinan.

b. Manajemen Kala II (Pengeluaran Bayi)**Tujuan:**

Memastikan kelahiran bayi secara aman dan tanpa komplikasi.

Tindakan:

- 1) Mengatur posisi ibu (semi-duduk atau jongkok).

- 2) Menganjurkan ibu mengejan secara alami dan terkontrol.
- 3) Melindungi perineum menggunakan teknik proteksi yang tepat.
- 4) Memantau DJJ setiap 5 menit.
- 5) Membantu kelahiran kepala, bahu, dan badan bayi secara perlahan.
- 6) Segera melakukan IMD setelah kelahiran.
- 7) Mengeringkan tubuh bayi dan menjaga suhu tubuh bayi.
- 8) Memberikan injeksi oksitosin setelah bayi lahir.

c. Manajemen Kala III (Pengeluaran Plasenta)

Tujuan:

Memastikan plasenta keluar utuh dan mencegah perdarahan postpartum.

Tindakan:

- 1) Melakukan penegangan tali pusat terkendali (PTT).
- 2) Memastikan plasenta keluar secara utuh.
- 3) Melakukan pemeriksaan kelengkapan plasenta dan selaput ketuban.
- 4) Memijat lembut fundus uteri setelah plasenta lahir untuk membantu kontraksi.
- 5) Mengobservasi perdarahan vagina.
- 6) Memberikan edukasi tentang tanda perdarahan abnormal.

d. Manajemen Kala IV (Pemantauan Pasca Persalinan)

Tujuan:

Memastikan ibu dan bayi dalam kondisi stabil dan aman setelah persalinan.

Tindakan:

- 1) Memeriksa tanda-tanda vital ibu setiap 15 menit pada satu jam pertama.
- 2) Memantau perdarahan vagina dan kontraksi uterus.
- 3) Memastikan ibu mendapatkan cairan dan nutrisi yang cukup.
- 4) Mengajarkan teknik menyusui yang benar.
- 5) Melakukan IMD minimal 1 jam.
- 6) Memantau kondisi umum bayi (warna kulit, pernapasan, gerakan).
- 7) Mengukur berat badan bayi.
- 8) Memberikan vitamin K dan salep mata antibiotik kepada bayi.
- 9) Memastikan bayi dalam kondisi hangat dengan kontak kulit ke kulit.

- 10) Memberikan edukasi tentang perawatan perineum, kebersihan ibu dan bayi, serta tanda bahaya postpartum.
- 11) Menyusun rencana tindak lanjut dan kunjungan postpartum.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Pada kala I persalinan, tindakan apa yang paling tepat dilakukan bidan secara rutin untuk menilai progres persalinan?

- A. Mengukur tinggi fundus uteri
- B. Melakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui pembukaan serviks
- C. Memberikan cairan infus
- D. Melakukan episiotomi
- E. Memantau pemberian oksitosin

Soal 2:

Apa tujuan utama pemberian oksitosin pada akhir kala II persalinan?

- A. Meningkatkan produksi ASI
- B. Mempercepat kelahiran bayi
- C. Mencegah perdarahan postpartum
- D. Mengurangi rasa nyeri kontraksi
- E. Mengurangi risiko infeksi

Soal 3:

Dalam pemantauan kala IV persalinan, berapa kali frekuensi pemeriksaan tanda-tanda vital ibu dalam satu jam pertama setelah persalinan?

- A. Setiap 30 menit
- B. Setiap 15 menit
- C. Setiap 60 menit
- D. Setiap 5 menit
- E. Setiap 45 menit

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar B

Pembahasan:

Pada kala I, pemeriksaan dalam secara berkala penting untuk menilai progres pembukaan serviks dan menentukan kemajuan persalinan.

Soal 2: Jawaban benar C**Pembahasan:**

Pemberian oksitosin setelah kelahiran bayi bertujuan untuk meningkatkan kontraksi uterus sehingga mencegah perdarahan postpartum.

Soal 3: Jawaban benar B**Pembahasan:**

Pemantauan tanda-tanda vital ibu selama kala IV harus dilakukan setiap 15 menit selama satu jam pertama setelah persalinan untuk memastikan kondisi ibu tetap stabil.

3. Penatalaksanaan Penyulit Persalinan

Memahami dan menguasai penatalaksanaan berbagai komplikasi selama persalinan sangat penting bagi bidan untuk mengurangi risiko morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi.

a. Distosia Bahu**Definisi:**

Distosia bahu adalah situasi di mana bahu anterior bayi tertahan dibelakang simfisis pubis setelah kelahiran kepala.

Penatalaksanaan:

- 1) Segera meminta bantuan tambahan.
- 2) Melakukan manuver McRoberts (flekksi maksimal paha ibu ke arah abdomen).
- 3) Memberikan tekanan suprapubik secara terarah untuk membantu bahu anterior turun.
- 4) Menghindari tarikan kuat pada kepala bayi untuk mencegah cedera pleksus brakialis.

b. Retensio Plasenta**Definisi:**

Plasenta tidak keluar dalam waktu 30 menit setelah kelahiran bayi.

Penatalaksanaan:

- 1) Mengidentifikasi adanya perdarahan aktif.
- 2) Melakukan kateterisasi urin untuk memastikan kandung kemih kosong.
- 3) Memberikan oksitosin tambahan jika perlu.
- 4) Melakukan rujukan untuk tindakan manual plasenta oleh dokter atau tenaga terlatih.

c. Perdarahan Postpartum Primer

Definisi:

Perdarahan >500 ml dalam 24 jam pertama setelah persalinan per vaginam atau >1000 ml setelah operasi caesar.

Penatalaksanaan:

- 1) Melakukan pemijatan fundus uteri untuk merangsang kontraksi.
- 2) Memberikan uterotonik tambahan seperti oksitosin atau misoprostol.
- 3) Memastikan kandung kemih kosong dengan kateterisasi urin.
- 4) Memantau tanda-tanda vital secara ketat dan segera rujuk jika perdarahan tidak terkendali.

d. Ruptur Perineum

Definisi:

Robekan pada perineum yang dapat terjadi spontan selama persalinan atau akibat episiotomi.

Penatalaksanaan:

- 1) Identifikasi derajat ruptur (tingkat I hingga IV).
- 2) Segera lakukan penjahitan dengan teknik aseptik.
- 3) Berikan edukasi perawatan luka kepada ibu (kebersihan dan tanda infeksi).
- 4) Kontrol nyeri dengan analgesik sesuai kebutuhan.

e. Persalinan Prematur

Definisi:

Persalinan yang terjadi antara usia kehamilan 20-37 minggu.

Penatalaksanaan:

- 1) Identifikasi tanda-tanda persalinan prematur (kontraksi uterus, perubahan serviks).
- 2) Rujuk segera ke fasilitas kesehatan dengan NICU jika usia kehamilan kurang dari 34 minggu.
- 3) Berikan kortikosteroid (misalnya dexamethasone) untuk membantu pematangan paru-paru janin.
- 4) Berikan tokolitik untuk menghambat kontraksi uterus sementara jika diindikasikan dan sesuai petunjuk dokter.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Langkah awal yang paling tepat dilakukan bidan jika menghadapi distosia bahu saat persalinan adalah:

- A. Menarik kuat kepala bayi
- B. Memberikan tekanan suprapubik dan manuver McRoberts
- C. Segera melakukan episiotomi
- D. Memberikan oksitosin
- E. Melakukan ekstraksi vakum

Soal 2:

Plasenta dianggap retensio jika tidak keluar setelah berapa lama pasca kelahiran bayi?

- A. 10 menit
- B. 15 menit
- C. 20 menit
- D. 25 menit
- E. 30 menit

Soal 3:

Apa tindakan awal utama dalam penanganan perdarahan postpartum primer?

- A. Memberikan cairan infus segera
- B. Melakukan pemijatan fundus uteri
- C. Melakukan episiotomi
- D. Memberikan antibiotik
- E. Melakukan transfusi darah segera

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar B

Pembahasan: Langkah awal dalam penanganan distosia bahu adalah meminta bantuan, melakukan manuver McRoberts, dan memberikan tekanan suprapubik untuk membantu bahu bayi melewati simfisis pubis.

Soal 2: Jawaban benar E

Pembahasan: Plasenta disebut retensio jika tidak keluar dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir, yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Soal 3: Jawaban benar B

Pembahasan: Tindakan utama dalam penanganan awal perdarahan postpartum primer adalah pemijatan fundus uteri untuk membantu uterus berkontraksi sehingga mengurangi perdarahan.

4. Deteksi dan Penanganan Gawat Janin

Gawat janin merupakan kondisi ketika janin mengalami hipoksia atau gangguan sirkulasi yang mengancam kehidupan janin. Deteksi dini dan penanganan yang cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius atau kematian janin.

a. Penyebab Gawat Janin

- Insufisiensi plasenta
- Lilitan tali pusat
- Solusio plasenta
- Prolaps tali pusat
- Distosia persalinan
- Hipertensi atau preeklamsia pada ibu

b. Tanda dan Gejala Gawat Janin

- Penurunan atau peningkatan frekuensi denyut jantung janin (DJJ <120 atau >160 kali per menit)
- Pola DJJ tidak teratur
- Mekonium dalam cairan ketuban
- Berkurangnya gerakan janin

c. Metode Deteksi Gawat Janin

- 1) Pemantauan DJJ
 - Menggunakan stetoskop janin atau Doppler fetal monitor
 - Pemantauan elektronik kontinu (CTG)
- 2) Observasi Cairan Ketuban

Identifikasi warna cairan ketuban (jernih atau bercampur mekonium)
- 3) Pemantauan Gerakan Janin

Mengamati pola dan jumlah gerakan janin secara rutin oleh ibu

d. Penanganan Gawat Janin

Tindakan Segera:

- 1) Mengubah posisi ibu ke posisi miring kiri untuk meningkatkan perfusi plasenta
- 2) Memberikan oksigen tambahan melalui masker wajah
- 3) Hidrasi ibu dengan cairan intravena

Penanganan Lanjut:

- 1) Evaluasi penyebab gawat janin secara cepat dan tepat
- 2) Segera lakukan persalinan jika kondisi janin tidak membaik, baik melalui tindakan vaginal cepat atau operasi caesar darurat

- 3) Pastikan kesiapan tim resusitasi neonatal untuk memberikan penanganan segera pada bayi

e. Pencegahan Gawat Janin

- Pemantauan rutin kehamilan melalui ANC
- Mengidentifikasi dan menangani faktor risiko sedini mungkin
- Edukasi ibu tentang pentingnya pemantauan gerakan janin dan kunjungan antenatal rutin

PERTANYAAN:

Soal 1:

Seorang ibu hamil mengeluhkan gerakan janin berkurang selama 12 jam terakhir. Pemeriksaan DJJ menunjukkan denyut jantung janin 110 kali per menit. Kondisi ini mengindikasikan:

- A. DJJ normal
- B. Gawat janin
- C. Polihidramnion
- D. Oligohidramnion
- E. Kelahiran prematur

Soal 2:

Tindakan pertama yang harus dilakukan oleh bidan saat menemukan tanda-tanda gawat janin adalah:

- A. Menyiapkan operasi caesar
- B. Memberikan oksigen tambahan
- C. Mengubah posisi ibu ke posisi miring kiri
- D. Memberikan uterotonika
- E. Melakukan pemeriksaan dalam

Soal 3:

Mengapa cairan ketuban yang bercampur mekonium merupakan tanda bahaya pada janin?

- A. Mengindikasikan infeksi ketuban
- B. Menunjukkan janin mengalami stres dan hipoksia
- C. Menunjukkan janin mengalami kelainan genetik
- D. Menunjukkan kehamilan normal
- E. Mengindikasikan polihidramnion

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar B

Pembahasan: Penurunan gerakan janin dan DJJ kurang dari 120 kali per menit menunjukkan adanya tanda gawat janin yang memerlukan tindakan segera.

Soal 2: Jawaban benar C

Pembahasan: Langkah pertama untuk meningkatkan perfusi plasenta dan memperbaiki kondisi janin adalah mengubah posisi ibu menjadi miring kiri.

Soal 3: Jawaban benar B

Pembahasan: Mekonium dalam cairan ketuban menunjukkan janin mengalami stres atau hipoksia yang merupakan tanda bahaya gawat janin.

D. Masa Nifas dan Menyusui

1. Pemantauan Ibu Nifas Normal

Masa nifas adalah periode sejak plasenta lahir hingga enam minggu (42 hari) setelah melahirkan. Pemantauan ibu nifas secara tepat bertujuan memastikan kondisi fisik dan emosional ibu pulih sepenuhnya, mendeteksi komplikasi dini, serta memberikan dukungan menyusui dan perawatan bayi baru lahir.

a. Tujuan Pemantauan Nifas

- 1) Memastikan ibu pulih secara fisik dan emosional setelah melahirkan.
- 2) Mendeteksi secara dini adanya komplikasi masa nifas seperti perdarahan, infeksi, atau depresi postpartum.
- 3) Memberikan edukasi tentang perawatan diri dan bayi.
- 4) Mendukung proses menyusui secara optimal.

b. Aspek Penting Pemantauan Nifas

- 1) Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital
 - Tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan pernapasan.
 - Frekuensi: setiap 15 menit pada satu jam pertama, lalu setiap 6 jam selama 24 jam pertama, kemudian setiap hari.
- 2) Pemantauan Uterus
 - Pastikan involusi uteri berjalan normal (uterus keras dan mengecil setiap hari).
 - Tinggi fundus uteri harus turun sekitar 1 cm per hari setelah persalinan.

3) Pemantauan Lokia

- Amati warna, jumlah, dan bau lokia (cairan nifas):
 - Lokia rubra (merah darah): hari 1-3
 - Lokia serosa (cokelat muda): hari 4-10
 - Lokia alba (putih kekuningan): hari 11 hingga minggu ke-6
- Jumlahnya harus berkurang setiap hari.

4) Pemantauan Perineum

- Observasi luka perineum atau luka jahitan untuk tanda infeksi seperti kemerahan, nyeri, atau pembengkakan.
- Berikan edukasi tentang kebersihan perineum yang baik.

5) Edukasi tentang Menyusui

- Ajarkan teknik menyusui yang benar.
- Evaluasi posisi dan perlekatan bayi saat menyusui.

6) Pemantauan Emosi Ibu

- Lakukan skrining untuk tanda-tanda baby blues atau depresi postpartum.
- Berikan dukungan emosional dan sosial.

7) Edukasi KB Pasca Persalinan

- Diskusikan tentang kontrasepsi yang sesuai dan waktu yang tepat untuk memulai penggunaan KB.

c. Tanda Bahaya Masa Nifas

- Perdarahan berlebihan atau mendadak.
- Demam tinggi atau menggigil.
- Nyeri perut hebat atau tidak berkurang.
- Luka perineum yang bernanah atau membengkak.
- Kesulitan berkemih.
- Emosi yang tidak stabil atau depresi berat.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Setelah persalinan normal, seberapa sering bidan harus memeriksa tanda-tanda vital ibu pada 24 jam pertama?

- A. Setiap 12 jam
- B. Setiap 8 jam
- C. Setiap 6 jam
- D. Setiap 4 jam
- E. Setiap 24 jam

Soal 2:

Pada hari ke-5 masa nifas, lochia yang normal memiliki karakteristik:

- A. Merah terang, jumlah banyak
- B. Putih kekuningan, jumlah sedikit
- C. Cokelat muda, jumlah sedang hingga sedikit
- D. Merah kehitaman, bau tidak sedap
- E. Kuning kehijauan dengan bau menyengat

Soal 3:

Apa tindakan pertama yang dilakukan bila ibu nifas mengalami perdarahan mendadak dengan jumlah banyak?

- A. Melakukan pemijatan fundus uteri
- B. Memberikan analgesik
- C. Melakukan pemeriksaan laboratorium
- D. Memberikan antibiotik
- E. Melakukan observasi selama 24 jam

KUNCI JAWABAN:**Soal 1: Jawaban benar C****Pembahasan:**

Pemantauan tanda-tanda vital ibu nifas pada 24 jam pertama setelah persalinan dilakukan setiap 6 jam untuk memastikan kondisi ibu stabil dan normal.

Soal 2: Jawaban benar C**Pembahasan:**

Pada hari ke-5 masa nifas, lochia biasanya berwarna cokelat muda (lochia serosa) dengan jumlah yang berkurang dari hari-hari sebelumnya.

Soal 3: Jawaban benar A**Pembahasan:**

Pemijatan fundus uteri merupakan langkah awal yang penting untuk membantu kontraksi uterus dan menghentikan perdarahan postpartum yang berlebihan.

2. Edukasi Menyusui (IMD dan ASI Eksklusif)

Menyusui merupakan proses pemberian ASI (Air Susu Ibu) kepada bayi sejak lahir hingga minimal usia 6 bulan secara eksklusif, dilanjutkan dengan makanan pendamping hingga usia 2 tahun atau lebih. Edukasi tentang menyusui penting dilakukan sejak masa kehamilan agar ibu siap secara fisik, mental, dan emosional.

a. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

1) Definisi

Inisiasi Menyusu Dini adalah proses meletakkan bayi yang baru lahir langsung di dada ibu untuk memungkinkan bayi menyusu segera dalam waktu 1 jam setelah kelahiran.

2) Langkah-langkah IMD

- a) Setelah bayi lahir, segera letakkan bayi di dada ibu tanpa mengelap cairan tubuh bayi secara berlebihan.
- b) Biarkan bayi merangkak sendiri menuju puting ibu.
- c) Berikan waktu minimal 60 menit agar bayi dapat menemukan puting dan mulai menyusu.
- d) Pastikan suhu tubuh bayi tetap hangat dengan kontak kulit ke kulit (skin-to-skin contact).

3) Manfaat IMD

- Membantu stabilisasi suhu tubuh, denyut jantung, dan pernapasan bayi.
- Merangsang produksi ASI lebih awal.
- Memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi.
- Menurunkan risiko perdarahan postpartum pada ibu.

b. ASI Eksklusif

1) Definisi

ASI eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja tanpa tambahan makanan atau cairan lain, bahkan air putih sekalipun, sejak lahir hingga usia bayi mencapai 6 bulan.

2) Manfaat ASI Eksklusif

- Menyediakan nutrisi lengkap yang optimal untuk tumbuh kembang bayi.
- Meningkatkan kekebalan tubuh bayi terhadap infeksi dan penyakit.
- Menurunkan risiko alergi pada bayi.
- Meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan bayi.
- Mengurangi risiko obesitas dan diabetes pada bayi dikemudian hari.

3) Teknik Menyusui yang Benar

- Posisi nyaman bagi ibu dan bayi.
- Kepala dan badan bayi dalam garis lurus.
- Dagunya menempel pada payudara ibu.
- Mulut bayi terbuka lebar, sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi.
- Bayi menyusu dengan ritme hisapan yang teratur.

c. Edukasi yang Perlu Disampaikan

- Pentingnya menjaga nutrisi dan hidrasi ibu selama menyusui.
- Mengenali tanda bayi mendapat cukup ASI (berat badan naik, bayi aktif, sering buang air kecil dan besar).
- Mengatasi kendala menyusui seperti puting lecet, mastitis, atau ASI tidak lancar.
- Mengajarkan teknik memerah ASI jika ibu harus berpisah dengan bayi sementara.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Berapa lama minimal waktu yang disarankan untuk melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)?

- A. 15 menit
- B. 30 menit
- C. 45 menit
- D. 60 menit
- E. 90 menit

Soal 2:

Berikut ini manfaat utama ASI eksklusif bagi bayi, kecuali:

- A. Menyediakan nutrisi lengkap
- B. Meningkatkan kekebalan tubuh
- C. Menurunkan risiko alergi
- D. Meningkatkan risiko obesitas
- E. Memperkuat ikatan ibu dan bayi

Soal 3:

Posisi menyusui yang benar ditandai dengan:

- A. Kepala bayi tidak sejajar dengan tubuh bayi
- B. Mulut bayi hanya memegang puting ibu saja
- C. Dagunya jauh dari payudara ibu
- D. Sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi
- E. Bayi tampak gelisah saat menyusui

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar D

Pembahasan:

Inisiasi Menyusu Dini disarankan dilakukan minimal selama 60 menit agar bayi dapat menemukan sendiri puting ibu dan menyusui.

Soal 2: Jawaban benar D**Pembahasan:**

ASI eksklusif justru mengurangi risiko obesitas pada bayi, bukan meningkatkan.

Soal 3: Jawaban benar D**Pembahasan:**

Posisi menyusui yang benar adalah ketika sebagian besar areola payudara ibu masuk ke dalam mulut bayi, yang membantu bayi menyusu secara efektif dan nyaman bagi ibu.

3. Tatalaksana Komplikasi Nifas

Komplikasi nifas adalah masalah kesehatan yang dapat terjadi selama periode nifas (6 minggu pasca persalinan). Pemahaman tentang komplikasi ini penting untuk mendeteksi dini dan melakukan penanganan secara tepat dan efektif.

a. Perdarahan Postpartum Lanjut**1) Definisi**

Perdarahan postpartum lanjut adalah perdarahan yang terjadi setelah 24 jam hingga 6 minggu pasca persalinan.

2) Penyebab

- Retensi sisa plasenta
- Infeksi endometrium
- Subinvolusi uterus

3) Tatalaksana

- a) Identifikasi penyebab utama melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik.
- b) Pemeriksaan ultrasonografi untuk deteksi retensi jaringan plasenta.
- c) Pengosongan uterus dari sisa plasenta jika ada.
- d) Terapi antibiotik jika ada tanda infeksi.
- e) Terapi uterotonika untuk membantu kontraksi uterus.
- f) Edukasi pasien untuk segera kembali jika perdarahan berulang atau bertambah banyak.

b. Infeksi Nifas (Sepsis Puerperalis)**1) Definisi**

Infeksi yang terjadi selama masa nifas akibat invasi bakteri ke organ reproduksi ibu.

2) Penyebab

- Kebersihan yang kurang baik saat persalinan

- Retensi jaringan plasenta
- Luka episiotomi atau luka jahitan yang terinfeksi

3) Gejala

- Demam tinggi ($>38^{\circ}\text{C}$)
- Nyeri abdomen bawah
- Lokia berbau tidak sedap
- Kelelahan ekstrem dan nyeri tubuh

4) Tatalaksana:

- Terapi antibiotik sesuai indikasi dan kultur bakteri jika diperlukan.
- Perawatan luka perineum atau bekas jahitan secara aseptik.
- Pemantauan tanda vital secara berkala.
- Memberikan analgesik untuk nyeri.
- Mengajarkan ibu tentang pentingnya kebersihan diri dan perawatan luka.

c. Gangguan Psikologis Postpartum

1) Definisi:

Gangguan emosional atau psikologis yang terjadi setelah melahirkan, seperti baby blues, depresi postpartum, atau psikosis postpartum.

2) Gejala:

- Perasaan sedih atau menangis tanpa sebab
- Rasa tidak mampu atau merasa gagal sebagai ibu
- Hilangnya minat terhadap bayi atau aktivitas sehari-hari
- Gangguan tidur dan nafsu makan
- Pikiran atau tindakan yang berbahaya terhadap diri sendiri atau bayi

3) Tatalaksana:

- Deteksi dini melalui skrining rutin.
- Dukungan psikologis dan emosional dari keluarga dan tenaga kesehatan.
- Konseling atau terapi psikologis jika diperlukan.
- Rujukan ke spesialis jiwa untuk kasus berat (psikosis postpartum).
- Edukasi keluarga tentang pentingnya dukungan dan pemahaman terhadap kondisi ibu.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Apa tindakan utama yang harus dilakukan jika ditemukan perdarahan postpartum lanjut akibat retensi jaringan plasenta?

- A. Segera memberikan analgesik
- B. Melakukan ultrasonografi dan pengeluaran jaringan sisa plasenta
- C. Memberikan antibiotik profilaksis
- D. Melakukan transfusi darah langsung
- E. Melakukan observasi selama 48 jam

Soal 2:

Tanda yang paling khas dari infeksi nifas (sepsis puerperalis) adalah:

- A. Demam tinggi dan lokia berbau tidak sedap
- B. Perdarahan postpartum hebat
- C. Tekanan darah tinggi
- D. Berat badan turun drastis
- E. Nyeri kepala hebat

Soal 3:

Langkah awal dalam manajemen ibu nifas yang menunjukkan gejala depresi postpartum adalah:

- A. Segera memberikan obat antidepresan
- B. Mengisolasi ibu dari bayinya
- C. Memberikan dukungan psikologis dan konseling awal
- D. Melakukan pemeriksaan laboratorium
- E. Merujuk langsung ke rumah sakit jiwa

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar B

Pembahasan:

Pada kasus retensi jaringan plasenta, tindakan utama adalah pemeriksaan ultrasonografi diikuti pengeluaran sisa jaringan plasenta untuk menghentikan perdarahan.

Soal 2: Jawaban benar A

Pembahasan:

Tanda utama infeksi nifas adalah demam tinggi ($>38^{\circ}\text{C}$) dan lokia yang berbau busuk sebagai tanda infeksi bakteri.

Soal 3: Jawaban benar C

Pembahasan:

Langkah awal dalam penanganan depresi postpartum adalah memberikan dukungan psikologis, emosional, serta konseling awal, sebelum mempertimbangkan intervensi farmakologis atau rujukan.

E. Bayi Baru Lahir dan Neonatus

1. Penilaian APGAR Score dan Perawatan Tali Pusat

Pengetahuan tentang penilaian APGAR dan perawatan tali pusat merupakan keterampilan klinis yang penting bagi bidan dalam asuhan bayi baru lahir.

a. Penilaian APGAR Score

Definisi:

Skor APGAR adalah penilaian kondisi bayi baru lahir yang dilakukan pada menit ke-1 dan ke-5 setelah lahir untuk menentukan kebutuhan bayi akan tindakan medis atau resusitasi segera.

Komponen APGAR:

- **Appearance (warna kulit)**
 - 0: Biru/pucat seluruh tubuh
 - 1: Badan merah muda, ekstremitas biru
 - 2: Merah muda seluruh tubuh
- **Pulse (denyut jantung)**
 - 0: Tidak ada denyut jantung
 - 1: <100 denyut/menit
 - 2: >100 denyut/menit
- **Grimace (respons refleks/iritabilitas)**
 - 0: Tidak ada respons
 - 1: Meringis atau respons lemah saat distimulasi
 - 2: Menangis kuat, respons baik
- **Activity (tonus otot)**
 - 0: Lemas, tidak ada gerakan
 - 1: Beberapa gerakan fleksi ekstremitas
 - 2: Gerakan aktif, ekstremitas terfleksi baik
- **Respiration (usaha bernapas)**
 - 0: Tidak bernapas
 - 1: Pernapasan lemah atau tidak teratur
 - 2: Menangis kuat dengan napas teratur

Interpretasi APGAR Score:

- 7-10: Kondisi bayi baik, hanya memerlukan pemantauan rutin
- 4-6: Bayi mengalami gangguan sedang, memerlukan tindakan stimulasi atau bantuan pernapasan sederhana

- 0-3: Kondisi bayi sangat buruk, memerlukan resusitasi segera

b. Perawatan Tali Pusat

Tujuan:

Mencegah infeksi dan memastikan pelepasan tali pusat secara aman.

Langkah-langkah:

- 1) Lakukan penjepitan tali pusat sekitar 1-3 menit setelah kelahiran atau setelah berhenti berdenyut.
- 2) Potong tali pusat dengan alat steril pada jarak sekitar 2-3 cm dari pangkal tali pusat bayi.
- 3) Pastikan kebersihan tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusat.
- 4) Biarkan tali pusat tetap kering dan bersih.
- 5) Jangan menutup tali pusat dengan bahan yang rapat atau lembab.
- 6) Pantau tanda infeksi seperti kemerahan, bau busuk, atau adanya nanah.

Edukasi kepada Orang Tua:

- Mengajarkan kebersihan tangan sebelum merawat tali pusat.
- Memberitahu tanda-tanda infeksi pada tali pusat yang harus diwaspadai.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Bayi lahir dengan warna kulit merah muda, denyut jantung 120 kali/menit, menangis kuat, gerakan aktif, dan napas teratur. Berapakah skor APGAR bayi tersebut?

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 7
- E. 6

Soal 2:

Apa langkah pertama yang harus dilakukan bidan dalam perawatan tali pusat setelah bayi lahir?

- A. Membersihkan tali pusat dengan alkohol
- B. Segera menjepit dan memotong tali pusat saat bayi lahir
- C. Menunggu tali pusat berhenti berdenyut sebelum dipotong
- D. Menutup tali pusat dengan kasa steril
- E. Memberikan salep antibiotik pada tali pusat

Soal 3:

Bayi lahir dengan kondisi kulit badan merah muda, ekstremitas biru, denyut jantung 90 kali/menit, respons refleks lemah, tonus otot lemas, dan napas tidak teratur. Skor APGAR bayi tersebut adalah:

- A. 5
- B. 6
- C. 4
- D. 7
- E. 3

KUNCI JAWABAN:**Soal 1: Jawaban benar C****Pembahasan:**

Bayi mendapatkan skor maksimal (2) untuk semua komponen (warna, denyut jantung, refleks, tonus otot, dan napas), sehingga skor totalnya adalah 10.

Soal 2: Jawaban benar C**Pembahasan:**

Penjepitan dan pemotongan tali pusat dilakukan setelah tali pusat berhenti berdenyut (sekitar 1-3 menit setelah bayi lahir) untuk memastikan bayi menerima darah yang optimal dari plasenta.

Soal 3: Jawaban benar C**Pembahasan:**

- Warna: 1 (badan merah, ekstremitas biru)
- Pulse: 1 (<100)
- Grimace: 1 (respons lemah)
- Activity: 0 (lemas)
- Respiration: 1 (tidak teratur) Total skor APGAR: $1+1+1+0+1 = 4$

2. Skrining Neonatal (Pendengaran, Hipotiroid, Kelainan Kongenital)

Skrining neonatal adalah pemeriksaan awal pada bayi baru lahir untuk mendeteksi dini gangguan kesehatan tertentu sehingga dapat segera dilakukan intervensi medis atau rehabilitasi yang diperlukan.

a. Skrining Pendengaran**Tujuan:**

Mendeteksi gangguan pendengaran sejak dini untuk mencegah keterlambatan bicara dan perkembangan bahasa.

Metode:

- Otoacoustic Emissions (OAE): mengukur respons koklea terhadap suara.
- Automated Auditory Brainstem Response (AABR): mengukur aktivitas saraf pendengaran hingga batang otak.

Waktu:

Dilakukan sebelum bayi pulang dari rumah sakit atau sebelum usia 1 bulan.

Tindak lanjut:

Jika hasil skrining abnormal, bayi dirujuk untuk evaluasi lanjutan oleh spesialis audiologi.

b. Skrining Hipotiroid Kongenital**Tujuan:**

Mendeteksi dini hipotiroid kongenital untuk mencegah retardasi mental dan pertumbuhan yang terhambat.

Metode:

- Mengambil sampel darah tumit bayi (heel prick test) untuk mengukur kadar hormon TSH (Thyroid Stimulating Hormone).

Waktu:

Idealnya pada usia 48–72 jam setelah kelahiran.

Tindak lanjut:

Hasil abnormal memerlukan konfirmasi dengan tes darah lanjutan dan rujukan ke dokter spesialis anak/endokrin.

c. Skrining Kelainan Kongenital**Tujuan:**

Mendeteksi dini kelainan kongenital seperti penyakit jantung bawaan, kelainan metabolisme, atau kelainan struktural lainnya.

Metode:

- Pemeriksaan fisik lengkap bayi baru lahir.
- Pulse oximetry untuk deteksi penyakit jantung bawaan kritis.
- USG abdomen atau pemeriksaan pencitraan tambahan jika diperlukan.

Waktu:

Dilakukan segera setelah kelahiran sebelum bayi pulang.

Tindak lanjut:

Kelainan yang ditemukan harus dirujuk ke spesialis terkait untuk evaluasi dan penanganan lebih lanjut.

d. Peran Bidan dalam Skrining Neonatal

- Memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya skrining neonatal.
- Melaksanakan skrining sesuai prosedur dan standar.
- Menginterpretasi hasil dan memberikan edukasi lanjutan serta rujukan bila diperlukan.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Metode pemeriksaan apa yang digunakan untuk skrining pendengaran pada bayi baru lahir?

- A. Otoacoustic Emissions (OAE)
- B. Pemeriksaan fisik rutin
- C. Heel prick test
- D. Pulse oximetry
- E. Pemeriksaan pencitraan (USG)

Soal 2:

Tujuan utama dari skrining hipotiroid kongenital adalah:

- A. Mencegah infeksi pada bayi
- B. Menilai fungsi jantung
- C. Mendeteksi retardasi mental dan gangguan pertumbuhan secara dini
- D. Memeriksa kelainan metabolisme umum
- E. Mendeteksi gangguan pendengaran

Soal 3:

Jika hasil skrining pendengaran bayi baru lahir abnormal, tindakan apa yang harus segera dilakukan?

- A. Memberikan antibiotik segera
- B. Mengulangi skrining pada usia 6 bulan
- C. Merujuk ke dokter spesialis audiologi
- D. Menunggu hingga usia 1 tahun
- E. Memberikan imunisasi tambahan

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar A

Pembahasan: OAE adalah metode utama yang digunakan dalam skrining pendengaran neonatal karena mampu mendeteksi gangguan pendengaran secara dini.

Soal 2: Jawaban benar C

Pembahasan: Skrining hipotiroid bertujuan mendeteksi dini gangguan tiroid yang dapat menyebabkan retardasi mental dan hambatan pertumbuhan jika tidak segera ditangani.

Soal 3: Jawaban benar C

Pembahasan: Jika skrining pendengaran menunjukkan hasil abnormal, bayi harus segera dirujuk untuk evaluasi lanjutan oleh spesialis audiologi untuk diagnosis pasti dan intervensi dini.

3. Penanganan Kegawatdaruratan Neonatal

Pengetahuan tentang kegawatdaruratan neonatal sangat penting dalam praktik kebidanan, karena intervensi yang tepat dan cepat dapat menyelamatkan nyawa bayi.

a. Asfiksia Neonatorum**Definisi:**

Gangguan pernapasan pada bayi baru lahir yang menyebabkan kekurangan oksigen.

Tanda Klinis:

- Tidak bernapas atau bernapas tidak teratur
- Detak jantung kurang dari 100 kali/menit
- Kulit kebiruan (sianosis)

Penanganan:

- Segera lakukan resusitasi neonatal (ventilasi bantuan).
- Pastikan jalur napas bebas dari sumbatan.
- Pantau tanda-tanda vital secara kontinu.
- Rujuk segera jika kondisi tidak membaik.

b. Ikterus Neonatorum**Definisi:**

Kondisi menguningnya kulit dan sklera mata bayi akibat kadar bilirubin yang tinggi.

Tanda Klinis:

- Kulit dan mata bayi tampak kuning
- Bayi malas menyusu, lemas, atau rewel

Penanganan:

- Pantau kadar bilirubin secara rutin.
- Terapi fototerapi jika bilirubin sangat tinggi.
- Tingkatkan frekuensi menyusui untuk membantu ekskresi bilirubin.
- Rujuk ke spesialis jika terjadi komplikasi seperti kernikterus.

c. Sepsis Neonatorum

Definisi:

Infeksi berat pada bayi baru lahir yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur.

Tanda Klinis:

- Demam atau hipotermia
- Lemas, malas minum, dan muntah
- Napas cepat atau sesak napas

Penanganan:

- 1) Lakukan pemeriksaan laboratorium (darah, urin, cairan serebrospinal).
- 2) Mulai antibiotik spektrum luas setelah kultur diambil.
- 3) Stabilkan suhu tubuh, cairan, dan elektrolit bayi.
- 4) Segera rujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan.

d. Hipotermi Neonatus

Definisi:

Kondisi suhu tubuh bayi baru lahir di bawah normal ($<36,5^{\circ}\text{C}$).

Tanda Klinis:

- Kulit bayi terasa dingin
- Bayi kurang aktif atau lesu
- Napas lambat atau tidak teratur

Penanganan:

- 1) Lakukan kontak kulit ke kulit (skin-to-skin) dengan ibu.
- 2) Bungkus bayi dengan selimut hangat dan tutup kepala bayi.
- 3) Pantau suhu tubuh bayi secara berkala.
- 4) Gunakan inkubator jika suhu tidak meningkat.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Langkah awal yang harus dilakukan pada bayi dengan asfiksia neonatorum adalah:

- A. Memberikan antibiotik segera
- B. Melakukan ventilasi bantuan
- C. Melakukan transfusi darah
- D. Menunggu kondisi membaik secara alami
- E. Memberikan imunisasi tambahan

Soal 2:

Ikterus neonatorum disebabkan oleh peningkatan kadar:

- A. Glukosa
- B. Protein
- C. Bilirubin
- D. Elektrolit
- E. Leukosit

Soal 3:

Tindakan pertama dalam menangani bayi baru lahir dengan hipotermi adalah:

- A. Memberikan antibiotik profilaksis
- B. Melakukan skin-to-skin contact dengan ibu
- C. Menghangatkan bayi menggunakan air panas
- D. Segera memberikan susu formula
- E. Memberikan obat antipiretik

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar B

Pembahasan:

Ventilasi bantuan merupakan tindakan pertama untuk memperbaiki oksigenasi pada bayi dengan asfiksia neonatorum.

Soal 2: Jawaban benar C

Pembahasan:

Ikterus neonatorum terjadi karena peningkatan kadar bilirubin dalam darah bayi.

Soal 3: Jawaban benar B

Pembahasan:

Skin-to-skin contact merupakan tindakan pertama dan efektif untuk menaikkan suhu tubuh bayi baru lahir yang mengalami hipotermi.

F. Bayi, Anak Balita, dan Prasekolah

1. Pemantauan Tumbuh Kembang Normal

Pemantauan tumbuh kembang normal merupakan proses penting dalam memastikan bahwa bayi, balita, dan anak prasekolah mencapai tahap perkembangan yang sesuai dengan usianya.

a. Tumbuh Kembang Bayi (0-12 bulan)

Parameter Pemantauan:

- Berat badan: dipantau setiap bulan.

- Panjang badan dan lingkar kepala: dipantau rutin untuk mendeteksi pertumbuhan normal.
- Perkembangan motorik kasar (mengangkat kepala, duduk, merangkak, berjalan).
- Perkembangan motorik halus (memegang benda, mengambil benda kecil).
- Perkembangan bicara dan bahasa (beroceh, kata pertama).

b. Tumbuh Kembang Balita (1-5 tahun)

Parameter Pemantauan:

- Pemantauan berat dan tinggi badan secara teratur (setiap 3 bulan hingga usia 2 tahun, kemudian setiap 6 bulan).
- Perkembangan motorik kasar (berjalan, berlari, melompat).
- Perkembangan motorik halus (menggambar, menyusun balok).
- Perkembangan bahasa (kemampuan berbicara kalimat sederhana, memahami instruksi).
- Perkembangan sosial-emosional (interaksi dengan teman sebaya, ekspresi emosi).

c. Tumbuh Kembang Anak Prasekolah (3-6 tahun)

Parameter Pemantauan:

- Pertumbuhan fisik: pengukuran tinggi badan dan berat badan minimal dua kali setahun.
- Motorik kasar dan halus: kemampuan aktivitas fisik lebih kompleks (bersepeda, menari, menulis).
- Bahasa dan komunikasi: bicara jelas, mampu bercerita singkat.
- Sosial-emosional: mulai berinteraksi secara mandiri dengan lingkungan sekitar, bermain dalam kelompok.

Cara Pemantauan:

- Gunakan grafik pertumbuhan WHO atau KMS (Kartu Menuju Sehat).
- Observasi langsung kemampuan dan keterampilan anak.
- Wawancara dan diskusi dengan orang tua terkait perkembangan anak sehari-hari.
- Pemeriksaan rutin oleh tenaga kesehatan.

d. Tindak Lanjut:

- Jika ditemukan penyimpangan dari pola normal, lakukan konseling kepada orang tua.
- Rujuk ke spesialis jika terdapat keterlambatan signifikan dalam perkembangan.

PERTANYAAN:

Soal 1:

Berapa frekuensi pemantauan berat badan pada bayi usia 0-12 bulan yang dianjurkan?

- A. Setiap minggu
- B. Setiap bulan
- C. Setiap 3 bulan
- D. Setiap 6 bulan
- E. Setiap tahun

Soal 2:

Pada usia berapa anak seharusnya mulai dapat berjalan secara mandiri?

- A. 6 bulan
- B. 9 bulan
- C. 12 bulan
- D. 18 bulan
- E. 24 bulan

Soal 3:

Apa tindakan yang tepat jika ditemukan keterlambatan berbicara pada anak berusia 3 tahun?

- A. Menunggu hingga anak berusia 5 tahun
- B. Memberikan stimulasi bicara lebih intensif di rumah
- C. Mengabaikan karena masih dalam batas wajar
- D. Memberikan obat untuk stimulasi perkembangan
- E. Segera merujuk ke dokter spesialis perkembangan anak

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban benar B

Pembahasan: Pemantauan berat badan pada bayi usia 0-12 bulan direkomendasikan dilakukan setiap bulan untuk memastikan pertumbuhan optimal.

Soal 2: Jawaban benar C

Pembahasan: Secara normal, bayi mulai dapat berjalan secara mandiri pada sekitar usia 12 bulan.

Soal 3: Jawaban benar E

Pembahasan: Jika pada usia 3 tahun anak menunjukkan keterlambatan bicara yang signifikan, rujukan ke dokter spesialis

perkembangan anak sangat penting untuk evaluasi lebih lanjut dan penanganan dini.

2. Imunisasi Dasar Lengkap

a. Pengertian Imunisasi

Imunisasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk merangsang sistem kekebalan agar menghasilkan antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu sehingga tubuh terlindungi dari infeksi atau dapat meringankan gejala apabila terinfeksi.

b. Tujuan Imunisasi

- Memberikan perlindungan terhadap penyakit berbahaya.
- Mencegah komplikasi penyakit menular.
- Mengurangi angka kesakitan dan kematian bayi serta balita.
- Mengurangi penularan penyakit dalam komunitas (*herd immunity*).

c. Jenis Imunisasi Dasar Lengkap di Indonesia

Imunisasi dasar lengkap yang wajib diberikan kepada anak-anak di Indonesia terdiri dari vaksin berikut:

1) Hepatitis B

Penyakit yang dicegah: Hepatitis B

Waktu pemberian:

- Dosis 1: Dalam waktu 24 jam setelah lahir (HB0)
- Dosis lanjutan diberikan dalam vaksin kombinasi pentavalen usia 2, 3, dan 4 bulan.

Dosis & Cara Pemberian: 0,5 ml, intramuskular (IM) di paha kanan atas (anterolateral).

Efek samping ringan: Demam ringan, nyeri di tempat suntikan.

2) BCG (Bacillus Calmette-Guérin)

Penyakit yang dicegah: Tuberkulosis (TB)

Waktu pemberian: Usia 1 bulan (optimal sebelum 2 bulan).

Dosis & Cara Pemberian: 0,05 ml untuk bayi <1 tahun, intradermal (ID) di lengan kanan atas.

Efek samping ringan: Bengkak kecil dan nanah di lokasi suntikan, sembuh sendiri dalam beberapa minggu.

3) Polio (OPV dan IPV)

Penyakit yang dicegah: Poliomiелitis

Waktu pemberian:

- OPV-0: saat kunjungan neonatal (0-1 bulan)
- OPV lanjutan: usia 2, 3, dan 4 bulan (bersama pentavalen)
- IPV: usia 4 bulan (bersamaan dengan OPV-4)

Dosis & Cara Pemberian:

- OPV: 2 tetes oral
- IPV: 0,5 ml, intramuskular di paha kiri atas.

Efek samping ringan: Jarang, kadang diare ringan atau muntah ringan (OPV), nyeri di lokasi suntikan (IPV).

4) DPT-HB-Hib (Pentavalen)

Kombinasi vaksin: Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, Haemophilus influenzae type b

Waktu pemberian: Usia 2, 3, dan 4 bulan.

Dosis & Cara Pemberian: 0,5 ml, intramuskular di paha kanan atas.

Efek samping ringan: Demam ringan, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, rewel, hilang nafsu makan sementara.

5) Campak-Rubela (MR)

Penyakit yang dicegah: Campak dan Rubela

Waktu pemberian: Usia 9 bulan (dosis tambahan pada usia 18 bulan dan kelas 1 SD).

Dosis & Cara Pemberian: 0,5 ml, subkutan (SC) di lengan kiri atas.

Efek samping ringan: Demam ringan, ruam merah, nyeri ringan pada tempat suntikan.

d. Kontraindikasi Umum Imunisasi

- Reaksi alergi berat terhadap pemberian vaksin sebelumnya.
- Imunosupresi berat (pada vaksin hidup seperti BCG dan MR).
- Penyakit akut berat dengan demam tinggi (ditunda sementara).

e. Prinsip Penting dalam Imunisasi

- Menjaga rantai dingin vaksin.
- Menggunakan teknik aseptik saat pemberian vaksin.
- Memberikan edukasi kepada orang tua tentang efek samping ringan dan manfaat vaksin.
- Mendokumentasikan imunisasi secara jelas pada buku KIA dan pencatatan di puskesmas/fasilitas kesehatan.

f. Jadwal Imunisasi Dasar Lengkap

UMUR	VAKSIN
0–24 jam	HB0
1 bulan	BCG, Polio-0
2 bulan	DPT-HB-Hib 1, Polio-1
3 bulan	DPT-HB-Hib 2, Polio-2
4 bulan	DPT-HB-Hib 3, Polio-3, IPV
9 bulan	MR

PERTANYAAN:

Soal 1

Seorang bayi baru lahir berumur 10 jam. Imunisasi apakah yang harus segera diberikan kepada bayi tersebut?

- A. BCG
- B. Hepatitis B (HB0)
- C. Polio IPV
- D. Pentavalen
- E. MR

Soal 2

Seorang ibu membawa bayi usia 2 bulan ke posyandu untuk imunisasi. Imunisasi apakah yang harus diberikan sesuai jadwal pada kunjungan ini?

- A. BCG dan Polio-0
- B. DPT-HB-Hib 1 dan Polio-1
- C. MR
- D. Hepatitis B0 dan IPV
- E. Polio IPV saja

Soal 3

Seorang bayi berusia 4 bulan akan menerima imunisasi polio lengkap. Manakah pernyataan berikut yang benar terkait imunisasi polio lengkap?

- A. Hanya diberikan vaksin OPV.
- B. IPV diberikan secara oral.
- C. IPV dan OPV diberikan bersamaan pada usia 4 bulan.
- D. OPV tidak boleh diberikan jika IPV sudah diberikan.
- E. IPV harus diberikan pada usia 9 bulan.

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban B (Hepatitis B)

Pembahasan: Imunisasi Hepatitis B (HB0) wajib diberikan segera dalam waktu 24 jam setelah lahir untuk mencegah infeksi hepatitis B perinatal.

Soal 2: Jawaban B (DPT-HB-Hib 1 dan Polio-1)

Pembahasan: Sesuai jadwal imunisasi, bayi usia 2 bulan harus menerima imunisasi pentavalen (DPT-HB-Hib) dosis pertama dan Polio dosis pertama (OPV-1).

Soal 3: Jawaban C (IPV dan OPV diberikan bersamaan pada usia 4 bulan)

Pembahasan: Imunisasi polio lengkap terdiri dari OPV dan IPV. IPV diberikan sekali bersamaan dengan OPV pada usia 4 bulan untuk memastikan proteksi terhadap virus polio secara optimal.

3. Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang dan Gizi Buruk

a. Pengertian

Deteksi dini adalah upaya mengidentifikasi gangguan atau keterlambatan tumbuh kembang anak serta masalah gizi sejak awal kehidupan. Deteksi dini bertujuan untuk mengantisipasi dampak negatif jangka panjang melalui intervensi tepat waktu.

b. Tujuan Deteksi Dini

- Mengidentifikasi secara dini gangguan tumbuh kembang anak.
- Mencegah terjadinya gangguan tumbuh kembang yang berat dan permanen.
- Mencegah komplikasi akibat gizi buruk.
- Memberikan intervensi yang tepat dan cepat guna meminimalisasi dampak buruk di kemudian hari.

c. Indikator Penting dalam Pemantauan Tumbuh Kembang

Tumbuh kembang dipantau melalui 4 aspek penting:

- 1) Pertumbuhan fisik (berat badan, tinggi badan, lingkar kepala)
- 2) Perkembangan motorik (kasar dan halus)
- 3) Perkembangan bahasa dan bicara
- 4) Perkembangan sosial-emosional dan kognitif

d. Gangguan Tumbuh Kembang

Tanda-tanda dini gangguan tumbuh kembang:

- Keterlambatan bicara atau tidak merespons suara hingga usia 12 bulan.
- Tidak mampu berdiri hingga usia 18 bulan.
- Belum bisa berjalan sendiri hingga usia 2 tahun.
- Tidak mampu mengucapkan kalimat sederhana pada usia 3 tahun.
- Sulit bersosialisasi, kurang kontak mata, atau kurang responsif terhadap lingkungan sekitar.

Metode skrining tumbuh kembang yang umum digunakan:

- **Denver Developmental Screening Test (DDST) II:** Mengukur perkembangan motorik kasar, halus, bahasa, personal-sosial pada anak usia 0-6 tahun.
- **Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan (KPSP):** Digunakan secara rutin di Posyandu/Puskesmas untuk menilai perkembangan anak usia 0-72 bulan.

e. Deteksi Dini Gizi Buruk

Definisi Gizi Buruk

Kondisi kekurangan gizi yang ditandai dengan penurunan berat badan yang sangat rendah (BB/PB atau BB/TB < -3SD).

Klasifikasi Status Gizi Anak (WHO)

- Gizi baik: BB/PB antara -2 SD s/d +2 SD
- Gizi kurang (underweight): BB/U antara -3 SD hingga < -2 SD
- Gizi buruk (severe wasting): BB/PB < -3 SD
- Stunting: TB/U < -2 SD (pertumbuhan tinggi badan yang terhambat)

Tanda dan Gejala Gizi Buruk

- Berat badan sangat rendah dibanding tinggi badan (wasting).
- Hilangnya massa otot.
- Tampak sangat kurus dengan tulang menonjol.
- Rambut tipis, rapuh, berubah warna kemerahan/kecoklatan.
- Mudah lelah, apatis, mudah marah, atau sangat pendiam.
- Edema atau pembengkakan pada kaki (marasmus-kwashiorkor).

f. Cara Deteksi Dini Gizi Buruk

- Melakukan pengukuran antropometri rutin setiap bulan (BB, PB/TB, LK).
- Plotting hasil pengukuran ke dalam grafik Kartu Menuju Sehat (KMS).

- Mengidentifikasi tanda klinis gangguan gizi (edema, rambut rapuh, kulit bersisik).
- Melakukan skrining rutin di Posyandu/Puskesmas melalui timbang dan ukur tinggi badan secara periodik.

g. Penatalaksanaan Awal Gizi Buruk

- Segera rujuk ke fasilitas kesehatan jika ditemukan anak dengan gizi buruk.
- Berikan edukasi kepada orang tua mengenai pemberian makanan tambahan bergizi tinggi.
- Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi nutrisi khusus (misalnya F-75, F-100).
- Lakukan pemantauan rutin terhadap anak selama masa pemulihan.

h. Strategi Pencegahan Gizi Buruk

- Promosi ASI eksklusif hingga usia 6 bulan.
- Edukasi pemberian MP-ASI bergizi mulai usia 6 bulan.
- Skrining rutin pertumbuhan anak.
- Pemberian suplemen mikronutrien (vitamin A, zat besi, zinc).

i. Peran Bidan dalam Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang dan Gizi Buruk

- Melakukan pengukuran antropometri secara berkala.
- Menggunakan KPSP/DDST dalam pemantauan perkembangan anak.
- Memberikan konseling pada orang tua tentang gizi seimbang.
- Menyediakan edukasi tentang tanda-tanda dini gangguan gizi dan perkembangan.

PERTANYAAN:

Soal 1

Seorang bayi berusia 12 bulan dibawa ibunya ke Posyandu. Bayi belum bisa duduk tegak tanpa bantuan. Tindakan paling tepat yang harus dilakukan bidan adalah:

- Menunggu hingga bayi berusia 18 bulan
- Melakukan stimulasi motorik halus
- Merujuk ke dokter spesialis anak untuk evaluasi lanjut
- Menyarankan ibu memberikan makanan tambahan
- Menyarankan ibu lebih sering menggendong bayi

Soal 2

Seorang anak usia 3 tahun memiliki berat badan 9 kg dengan tinggi badan 90 cm. Berdasarkan pengukuran antropometri ($BB/TB < -3 SD$), status gizi anak adalah:

- A. Gizi baik
- B. Gizi kurang
- C. Gizi buruk
- D. Stunting
- E. Obesitas

Soal 3

Seorang anak usia 2 tahun tampak sangat kurus, rambut kusam, apatis, dengan edema ringan di kedua tungkai. Kondisi ini mengarah pada diagnosis:

- A. Marasmus
- B. Kwashiorkor
- C. Marasmus-Kwashiorkor
- D. Anemia defisiensi besi
- E. Defisiensi vitamin A

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban C (Merujuk ke dokter spesialis anak untuk evaluasi lanjut)

Pembahasan:

Bayi usia 12 bulan yang belum mampu duduk tanpa bantuan merupakan indikasi keterlambatan motorik kasar yang memerlukan evaluasi lebih lanjut oleh dokter spesialis anak.

Soal 2: Jawaban C (Gizi buruk)

Pembahasan:

Anak dengan BB/TB di bawah $-3SD$ termasuk dalam kategori gizi buruk (severe wasting) yang memerlukan tindakan segera berupa rujukan dan pemberian terapi nutrisi intensif.

Soal 3: Jawaban C (Marasmus-Kwashiorkor)

Pembahasan:

Gejala kombinasi berupa sangat kurus (marasmus), edema ringan, rambut kusam dan apatis (kwashiorkor) merupakan karakteristik diagnosis Marasmus-Kwashiorkor yang merupakan bentuk gizi buruk yang sangat berat dan memerlukan penanganan khusus segera.

G. Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

1. Metode Kontrasepsi Hormonal dan Non-Hormonal

a. Pengertian Kontrasepsi

Kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Metode ini bertujuan untuk mengatur jumlah anak, menjaga jarak antar kehamilan, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

b. Jenis Metode Kontrasepsi

Metode kontrasepsi terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Metode Hormonal dan Metode Non-Hormonal.

c. Metode Kontrasepsi Hormonal

Kontrasepsi hormonal adalah metode kontrasepsi yang bekerja dengan mengubah keseimbangan hormon dalam tubuh wanita untuk mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan mengubah endometrium.

Jenis-Jenis Kontrasepsi Hormonal:

1) Pil Kombinasi (Estrogen-Progestin)

- Cara kerja: Menghambat ovulasi, menebalkan lendir serviks.
- Efektivitas: 99% jika digunakan benar.
- Keuntungan: Mengurangi nyeri haid, mengatur siklus menstruasi.
- Efek samping: Mual, nyeri payudara, perdarahan bercak.

2) Pil Progestin (Mini Pill)

- Cara kerja: Mengentalkan lendir serviks, menghambat implantasi.
- Efektivitas: 95-99% jika teratur.
- Keuntungan: Aman bagi ibu menyusui.
- Efek samping: Siklus haid tidak teratur.

3) Suntikan KB (Depo Provera / DMPA)

- Cara kerja: Menekan ovulasi, mengentalkan lendir serviks.
- Efektivitas: 99,7%.
- Interval pemberian: Setiap 3 bulan.
- Efek samping: Gangguan menstruasi, kenaikan berat badan.

4) Implan KB

- Cara kerja: Menekan ovulasi, mengubah lendir serviks.
- Efektivitas: 99,9%.
- Masa efektif: 3–5 tahun.
- Efek samping: Gangguan menstruasi, nyeri pada tempat pemasangan.

- 5) Susuk KB (Norplant, Implanon, Jadelle)
 - Termasuk jenis implan, efektivitas sangat tinggi (99,9%).
- 6) Koyo KB (Patch)
 - Cara kerja: Transdermal melepaskan hormon estrogen-progestin.
 - Efektivitas: 99% jika digunakan benar.
 - Penggantian: Mingguan.
- 7) Cincin Vagina (NuvaRing)
 - Cara kerja: Melepaskan hormon langsung di vagina.
 - Efektivitas: 98-99%.

d. Metode Kontrasepsi Non-Hormonal

Metode kontrasepsi yang tidak melibatkan penggunaan hormon.

Jenis-Jenis Kontrasepsi Non-Hormonal:

B. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD)

- Jenis:
 - IUD Tembaga (Copper T)
 - Efektivitas: 99,5%.
 - Masa pakai: Hingga 10 tahun.
- Cara kerja: Menghambat pergerakan sperma, mencegah implantasi.
- Efek samping: Perdarahan atau nyeri menstruasi meningkat pada beberapa wanita.

C. Kondom (Pria dan Wanita)

- Efektivitas: 85-95%.
- Keuntungan: Mencegah infeksi menular seksual (IMS).
- Kelemahan: Risiko robek/bocor.

D. Diafragma dan Spermisida

- Cara kerja: Menutup mulut rahim, membunuh sperma.
- Efektivitas: Sekitar 80-85%.
- Pemakaian: Harus dipasang sebelum hubungan seksual.

E. Metode Amenore Laktasi (MAL)

- Syarat: ASI eksklusif, ibu belum menstruasi, bayi <6 bulan.
- Efektivitas: Sekitar 98% jika memenuhi syarat.

F. Metode Kalender (Pantang Berkala)

- Cara kerja: Menghindari hubungan seksual pada masa subur.
- Efektivitas: 75-80%, tergantung konsistensi penggunaannya.

G. Metode Koitus Interruptus (Senggama Terputus)

- Cara kerja: Mengeluarkan sperma di luar vagina.
- Efektivitas: Kurang efektif (60-75%).

H. Sterilisasi (Tubektomi dan Vasektomi)

- Efektivitas: Hampir 100%.
- Sifat: Permanen.

e. Pertimbangan Pemilihan Metode Kontrasepsi

- Riwayat kesehatan dan kondisi medis klien.
- Preferensi pribadi pasangan.
- Frekuensi hubungan seksual.
- Efek samping yang bisa diterima.
- Jangka waktu kontrasepsi yang diinginkan.

f. Peran Bidan dalam Konseling Kontrasepsi

- Memberikan informasi jelas mengenai setiap metode.
- Menjelaskan keuntungan, efek samping, dan efektivitas.
- Mendukung klien dalam mengambil keputusan kontrasepsi sesuai kebutuhan individu.
- Melakukan tindak lanjut rutin pasca pemilihan metode kontrasepsi.

PERTANYAAN:

Soal 1

Seorang ibu menyusui berusia 25 tahun menginginkan kontrasepsi hormonal.

Metode apakah yang paling tepat diberikan untuk ibu tersebut?

- A. Pil kombinasi
- B. Pil progestin (mini pill)
- C. Suntikan KB kombinasi
- D. Implan kombinasi
- E. AKDR tembaga

Soal 2

Seorang wanita usia 30 tahun mengeluh perdarahan menstruasi yang berlebih setelah 3 bulan menggunakan kontrasepsi.

Metode kontrasepsi apakah yang paling mungkin digunakan wanita tersebut?

- A. Suntikan KB
- B. AKDR tembaga
- C. Pil progestin
- D. Implan progestin
- E. Pil kombinasi

Soal 3

Sepasang suami istri menginginkan metode kontrasepsi jangka panjang, tidak mengandung hormon, dan tidak permanen. Metode apakah yang tepat direkomendasikan?

- A. Pil kombinasi
- B. Suntikan KB
- C. AKDR tembaga
- D. Sterilisasi (tubektomi)
- E. Implan

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban B. Pil progestin (mini pill)

Pembahasan: Pil progestin aman digunakan selama masa menyusui karena tidak mempengaruhi produksi ASI.

Soal 2: Jawaban B. AKDR tembaga

Pembahasan: Salah satu efek samping dari AKDR tembaga adalah perdarahan menstruasi yang bertambah banyak atau lebih lama dari biasanya.

Soal 3: Jawaban C. AKDR tembaga

Pembahasan: AKDR tembaga adalah kontrasepsi non-hormonal yang efektif jangka panjang hingga 10 tahun, reversibel, dan bukan metode permanen.

2. Konseling KB Postpartum

a. Pengertian Konseling KB Postpartum

Konseling KB postpartum adalah proses pemberian informasi, edukasi, dan diskusi interaktif antara bidan dengan ibu atau pasangan tentang pemilihan metode kontrasepsi yang sesuai setelah persalinan hingga 42 hari (6 minggu) pasca persalinan.

b. Tujuan Konseling KB Postpartum

- Membantu ibu/pasangan memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi postpartum.
- Mengatur jarak kehamilan minimal 2 tahun.
- Mengurangi risiko komplikasi akibat jarak kehamilan yang terlalu dekat.
- Mendukung ibu dalam menjaga kesehatan reproduksi pasca persalinan.
- Menurunkan angka kehamilan yang tidak direncanakan (KTD).

c. Prinsip Konseling KB Postpartum

- Menggunakan pendekatan empatik dan menghargai keputusan klien.
- Memberikan informasi berbasis bukti yang jelas dan akurat.
- Memastikan klien memahami pilihan kontrasepsi dengan baik.
- Melibatkan pasangan dalam pengambilan keputusan.

d. Waktu Ideal Konseling KB Postpartum

- Antenatal: Mulai sejak trimester ketiga kehamilan.
- Persalinan dan Nifas Dini: Dalam 48 jam pertama setelah melahirkan.
- Kunjungan Nifas Lanjutan: Pada minggu pertama hingga 6 minggu pascapersalinan.

e. Metode Kontrasepsi yang Dianjurkan dalam Masa Postpartum

Pemilihan metode kontrasepsi postpartum bergantung pada kondisi ibu, pemberian ASI, serta preferensi ibu/pasangan.

1) Metode Hormonal

- Pil Progestin (Mini Pill)
Bisa digunakan segera setelah melahirkan, aman bagi ibu menyusui.
- Suntikan KB Progestin (DMPA)
Bisa diberikan segera setelah melahirkan atau dalam 6 minggu postpartum, aman bagi ibu menyusui.
- Implan KB
Aman untuk ibu menyusui, dapat dipasang segera setelah persalinan hingga 6 minggu postpartum.

2) Metode Non-Hormonal

- IUD Postpartum
IUD Tembaga dapat dipasang segera dalam waktu 10 menit hingga 48 jam pasca melahirkan atau setelah 4 minggu postpartum.
- Metode Amenore Laktasi (MAL)
Memberikan ASI eksklusif, bayi berusia kurang dari 6 bulan, dan ibu belum menstruasi kembali.
- Kondom
Bisa digunakan kapan saja setelah persalinan, aman untuk menyusui dan mencegah IMS.
- Sterilisasi (Tubektomi)
Pilihan metode permanen, biasanya dilakukan setelah persalinan (sesuai permintaan ibu).

f. Langkah-Langkah Konseling KB Postpartum

- 1) Membuka Sesi Konseling
Membangun hubungan baik dan saling percaya.
- 2) Eksplorasi Pengetahuan dan Sikap Klien
Mengidentifikasi pemahaman dan preferensi klien tentang KB postpartum.
- 3) Memberikan Informasi yang Tepat dan Jelas
Menjelaskan berbagai metode KB postpartum, keuntungan, efek samping, serta efektivitasnya.
- 4) Membantu Pengambilan Keputusan
Mendukung klien dalam menentukan metode kontrasepsi yang paling tepat.
- 5) Penutupan Sesi Konseling
Mengkonfirmasi pemahaman klien, membuat rencana tindak lanjut.

g. Peran Bidan dalam Konseling KB Postpartum

- Memberikan edukasi tentang pentingnya jarak kehamilan minimal 2 tahun.
- Menjelaskan keamanan metode KB selama menyusui.
- Memberikan dukungan emosional dan psikologis.
- Melakukan evaluasi pemakaian KB postpartum pada kunjungan nifas.

h. Informasi Penting dalam Konseling KB Postpartum

- Risiko kehamilan meningkat setelah nifas selesai jika tidak menggunakan KB.
- Menjelaskan manfaat kontrasepsi terhadap kesehatan ibu, bayi, dan keluarga.
- Penjelasan tentang efek kontrasepsi terhadap produksi ASI.
- Perlunya pemeriksaan rutin untuk mengevaluasi kecocokan kontrasepsi.

i. Hambatan dalam Konseling KB Postpartum

- Persepsi negatif terhadap kontrasepsi hormonal.
- Pengaruh mitos yang berkembang di masyarakat.
- Kurangnya keterlibatan pasangan dalam proses konseling.
- Rendahnya pemahaman tentang KB dan kesehatan reproduksi.

PERTANYAAN:

Soal 1

Seorang ibu usia 24 tahun, menyusui bayi usia 2 minggu, ingin segera menggunakan kontrasepsi hormonal.

Metode kontrasepsi hormonal yang paling tepat bagi ibu tersebut adalah

- A. Pil kombinasi
- B. Pil progestin (mini pill)
- C. Suntikan kombinasi
- D. Implan kombinasi
- E. AKDR Tembaga

Soal 2

Seorang ibu menyusui eksklusif dengan bayi berusia 4 bulan datang untuk konseling KB postpartum. Ibu belum menstruasi kembali. Metode kontrasepsi alami yang efektif untuk kondisi ibu tersebut adalah:

- A. Metode amenore laktasi (MAL)
- B. Metode kalender
- C. Koitus interruptus
- D. Diafragma
- E. Kondom

Soal 3

Seorang wanita usia 28 tahun baru melahirkan anak ketiga secara spontan 24 jam yang lalu. Ia meminta metode kontrasepsi jangka panjang dan ingin dipasang segera.

Metode kontrasepsi yang paling tepat direkomendasikan adalah:

- A. Pil kombinasi
- B. Suntikan KB
- C. Implan KB
- D. IUD postpartum
- E. Kondom

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban: B Pil progestin (mini pill)

Pembahasan:

Pil progestin (mini pill) aman digunakan segera setelah melahirkan dan tidak mempengaruhi produksi ASI.

Soal 2: Jawaban: A Metode amenore laktasi (MAL)

Pembahasan:

MAL efektif jika bayi di bawah usia 6 bulan, menyusui eksklusif, dan ibu belum mendapat menstruasi.

Soal 3: Jawaban: D IUD postpartum

Pembahasan:

IUD postpartum (tembaga) merupakan pilihan yang efektif, aman, jangka panjang, dan dapat dipasang segera setelah persalinan hingga 48 jam pasca persalinan.

3. Tatalaksana Efek Samping Kontrasepsi (KB)

a. Pengertian Efek Samping KB

Efek samping KB adalah reaksi yang tidak diharapkan atau keluhan yang muncul setelah pemakaian metode kontrasepsi tertentu. Efek samping ini bisa bersifat ringan hingga berat, bergantung pada jenis kontrasepsi dan respons tubuh pengguna.

b. Tujuan Tatalaksana Efek Samping KB

- Mengurangi ketidaknyamanan akibat efek samping KB.
- Mencegah komplikasi serius dari efek samping yang tidak ditangani.
- Meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan pengguna dalam penggunaan kontrasepsi.
- Mempertahankan efektivitas kontrasepsi yang dipilih.

c. Efek Samping dan Tatalaksana Menurut Metode KB

1) Pil Kombinasi (Estrogen-Progestin)

Efek Samping:

- Mual, nyeri payudara, sakit kepala.
- Perdarahan bercak atau spotting.
- Berat badan meningkat, gangguan mood.

Tatalaksana:

- Konseling untuk minum pil saat malam hari atau bersama makanan untuk mengurangi mual.
- Jelaskan efek samping akan berkurang dalam 3 bulan pemakaian.
- Jika spotting berlanjut, evaluasi kepatuhan penggunaannya, atau pertimbangkan ganti ke metode lain dengan dosis hormon yang berbeda.

2) Pil Progestin (Mini Pill)

Efek Samping:

- Gangguan siklus menstruasi (perdarahan tidak teratur atau amenore).
- Jerawat ringan, nyeri payudara.

Tatalaksana:

- Edukasi tentang perubahan menstruasi sebagai efek yang umum terjadi.
- Pastikan kepatuhan waktu minum pil yang sangat penting (tepat waktu setiap hari).
- Jika efek sangat mengganggu, pertimbangkan ganti ke metode lain.

3) Suntikan KB (Depo Provera)

Efek Samping:

- Amenore, spotting berkepanjangan, perdarahan tidak teratur.
- Kenaikan berat badan.
- Kembalinya kesuburan lambat setelah penghentian.

Tatalaksana:

- Edukasi bahwa gangguan menstruasi merupakan efek umum.
- Untuk perdarahan berkepanjangan, pertimbangkan terapi estrogen jangka pendek (sesuai konsultasi medis).
- Berikan konseling pola makan seimbang dan olahraga untuk mencegah kenaikan berat badan.

4) Implan KB

Efek Samping:

- Spotting atau perdarahan tidak teratur yang sering terjadi.
- Nyeri di tempat pemasangan, nyeri payudara, sakit kepala ringan.

Tatalaksana:

- Berikan edukasi efek samping umumnya hilang setelah 3–6 bulan.
- Jika perdarahan menetap, konsultasikan untuk terapi tambahan dengan estrogen (atas rekomendasi dokter).
- Nyeri lokal ringan dapat diatasi dengan analgesik ringan.

5) IUD Tembaga (Non-Hormonal)

Efek Samping:

- Perdarahan menstruasi yang lebih banyak atau lebih lama.
- Nyeri menstruasi (dismenore).
- Risiko ekspulsi spontan.

Tatalaksana:

- Jelaskan efek ini akan berkurang dalam 3-6 bulan pemakaian.

- Berikan analgesik (parasetamol atau NSAID) untuk mengatasi nyeri menstruasi.
- Pantau posisi IUD secara rutin; jika perdarahan berat menetap, pertimbangkan penggantian metode KB.

6) Kondom

Efek Samping:

- Alergi (iritasi, gatal, kemerahan).

Tatalaksana:

- Gunakan kondom dari bahan non-lateks atau hypoallergenic jika terjadi alergi.
- Berikan salep topikal untuk mengurangi iritasi ringan.

d. Prinsip Umum dalam Tatalaksana Efek Samping KB

- Edukasi mengenai efek samping yang bersifat sementara.
- Pemantauan rutin dan evaluasi kepuasan klien terhadap metode yang digunakan.
- Jika efek samping berat atau menetap, pertimbangkan penggantian metode KB.
- Lakukan konseling secara empatik dan berorientasi pada kebutuhan klien.

e. Tanda Efek Samping Berat yang Harus Dirujuk

- Nyeri dada hebat
- Nyeri kepala berat yang menetap
- Perdarahan hebat yang tidak berhenti
- Tanda infeksi di lokasi pemasangan implan/IUD
- Tanda trombosis vena dalam (bengkak kaki disertai nyeri hebat)

PERTANYAAN:

Soal 1

Seorang wanita usia 29 tahun menggunakan suntikan KB 3 bulan (DMPA) selama 6 bulan terakhir dan mengeluhkan perdarahan bercak (spotting) yang tidak berhenti.

Tatalaksana awal yang tepat dilakukan oleh bidan adalah:

- Segera lepas suntikan KB
- Memberikan edukasi bahwa spotting merupakan efek umum
- Memberikan antibiotik
- Memberikan suntikan tambahan DMPA
- Merujuk segera ke spesialis kandungan

Soal 2

Seorang ibu berusia 30 tahun datang dengan keluhan nyeri menstruasi hebat sejak menggunakan IUD tembaga selama 2 bulan.

Tindakan paling tepat yang dilakukan bidan adalah:

- A. Segera melepas IUD dan mengganti dengan kontrasepsi lain
- B. Memberikan analgesik dan edukasi bahwa nyeri akan berkurang setelah 3–6 bulan
- C. Merujuk langsung ke rumah sakit
- D. Memberikan terapi antibiotik oral
- E. Memberikan suntikan KB hormonal sebagai tambahan

Soal 3

Seorang wanita usia 25 tahun menggunakan pil KB kombinasi selama 1 bulan dan mengeluhkan mual yang mengganggu aktivitasnya.

Tindakan awal paling tepat adalah:

- A. Menghentikan pemakaian pil KB
- B. Mengganti ke suntikan KB DMPA
- C. Merujuk ke dokter spesialis kandungan
- D. Menyarankan minum pil KB pada malam hari atau sesudah makan
- E. Memberikan terapi antibiotik

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban B. Memberikan edukasi bahwa spotting merupakan efek umum

Pembahasan:

Spotting adalah efek samping yang umum terjadi pada awal pemakaian DMPA. Konseling tentang sifat sementara dari efek ini biasanya cukup menenangkan klien.

Soal 2: Jawaban B. Memberikan analgesik dan edukasi bahwa nyeri akan berkurang setelah 3–6 bulan

Pembahasan:

Nyeri menstruasi merupakan efek umum dari IUD tembaga pada awal pemakaian. Pemberian analgesik ringan (NSAID atau parasetamol) dan edukasi biasanya efektif mengatasinya.

Soal 3: Jawaban D. Menyarankan minum pil KB pada malam hari atau sesudah makan

Pembahasan:

Mual ringan sering terjadi pada awal penggunaan pil KB kombinasi. Mengubah waktu konsumsi pil (malam hari atau sesudah makan) efektif untuk mengurangi keluhan ini.

4. Pencegahan dan Pengelolaan Infeksi Menular Seksual (IMS) dengan IVA dan Pap Smear

a. Pengertian Infeksi Menular Seksual (IMS)

Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual, baik secara vaginal, oral, maupun anal. IMS dapat menyebabkan komplikasi serius seperti infertilitas, kehamilan ektopik, keguguran, kanker serviks, bahkan kematian.

b. Jenis IMS yang Sering Dijumpai

- Gonore
- Sifilis
- Klamidia
- Herpes genital
- HPV (Human Papilloma Virus)
- HIV/AIDS
- Kandidiasis vaginalis
- Trikomoniasis

c. Pencegahan IMS secara Umum

- Menggunakan kondom secara konsisten dan benar.
- Setia dengan satu pasangan seksual.
- Edukasi seksual yang komprehensif.
- Pemeriksaan rutin IMS terutama pada kelompok risiko tinggi.
- Vaksinasi HPV untuk mencegah kanker serviks.

d. Deteksi Dini IMS dan Kanker Serviks

Metode yang digunakan dalam deteksi dini kanker serviks dan lesi prakanker terkait IMS, terutama infeksi HPV:

1) IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat)

Merupakan pemeriksaan visual leher rahim menggunakan larutan asam asetat (3–5%). Bertujuan untuk deteksi dini lesi prakanker serviks.

Prosedur Pemeriksaan IVA:

- Pasien posisi litotomi.
- Masukkan spekulum steril untuk melihat serviks.
- Usap lendir serviks dengan kapas steril.
- Oleskan asam asetat 3–5% pada serviks.
- Tunggu selama 1 menit.
- Observasi perubahan warna serviks.

Interpretasi Hasil IVA:

- IVA Positif (+): Tampak area putih tebal (asetowhite), batas jelas.
- IVA Negatif (-): Tidak tampak area putih, serviks berwarna merah muda normal.

Tindak Lanjut:

- IVA positif dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut (kolposkopi/biopsi).
- IVA negatif disarankan pemeriksaan rutin setiap 3 tahun.

2) Pap Smear

- Pemeriksaan sitologi untuk mendeteksi lesi prakanker atau kanker serviks akibat infeksi HPV.
- Ideal dilakukan setiap 1-3 tahun pada wanita aktif seksual usia 21–65 tahun.

Prosedur Pap Smear:

- Posisi litotomi, pasang spekulum steril.
- Gunakan spatula Ayre untuk mengambil sampel dari permukaan serviks.
- Gunakan cytobrush untuk mengambil sampel dari kanal endoserviks.
- Sampel dioleskan tipis pada kaca objek, lalu difiksasi.
- Dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan sitologi.

Interpretasi Hasil Pap Smear:

- Normal: Sel serviks sehat, pemeriksaan ulang rutin 1–3 tahun.
- ASCUS (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance): perlu tindak lanjut tes HPV atau kolposkopi.
- LSIL (Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion): ada infeksi HPV ringan, tindak lanjut kolposkopi.
- HSIL (High-grade Squamous Intraepithelial Lesion): lesi prakanker, tindak lanjut kolposkopi/biopsi.

e. Peran Bidan dalam Pencegahan dan Pengelolaan IMS

- Memberikan edukasi dan konseling tentang perilaku seksual sehat.
- Melakukan pemeriksaan IVA dan Pap Smear rutin sebagai bagian dari deteksi dini kanker serviks.
- Merujuk kasus IVA positif atau Pap Smear abnormal ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.
- Memberikan dukungan psikologis selama proses pemeriksaan dan tindak lanjut.

f. Edukasi dan Konseling Pencegahan IMS

- Pentingnya hubungan seksual aman (penggunaan kondom, kesetiaan pasangan).
- Edukasi tentang pentingnya pemeriksaan rutin IVA dan Pap Smear.
- Konseling vaksinasi HPV bagi wanita usia produktif.
- Menjelaskan konsekuensi jangka panjang dari IMS yang tidak ditangani.

PERTANYAAN:

Soal 1

Seorang wanita usia 30 tahun menjalani pemeriksaan IVA. Setelah diberikan asam asetat 3%, tampak bercak putih tebal dengan batas yang jelas pada serviks. Tindakan selanjutnya yang paling tepat adalah:

- A. Memberikan antibiotik oral
- B. Merujuk untuk pemeriksaan lanjutan (kolposkopi)
- C. Memberikan vaksin HPV
- D. Melakukan Pap Smear rutin 3 tahun lagi
- E. Mengulang IVA 6 bulan kemudian

Soal 2

Hasil pemeriksaan Pap Smear seorang wanita usia 28 tahun menunjukkan hasil LSIL (Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion). Tindakan awal yang paling tepat dilakukan bidan adalah:

- A. Memberikan antibiotik
- B. Menyarankan pemeriksaan Pap Smear ulang setelah 5 tahun
- C. Memberikan vaksin HPV
- D. Merujuk untuk kolposkopi
- E. Memberikan obat anti-inflamasi

Soal 3

Seorang wanita usia 24 tahun menjalani IVA dengan hasil negatif. Edukasi yang tepat diberikan bidan kepada wanita tersebut adalah:

- A. IVA ulang setiap 10 tahun
- B. Tidak perlu lagi pemeriksaan lanjutan
- C. IVA ulang setiap 3 tahun sekali
- D. IVA ulang setelah menopause
- E. Memberikan antibiotik profilaksis

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban B. Merujuk untuk pemeriksaan lanjutan (kolposkopi)

Pembahasan:

IVA positif ditandai dengan bercak putih jelas (asetowhite). Langkah selanjutnya adalah rujukan ke fasilitas kesehatan untuk kolposkopi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Soal 2: Jawaban D. Merujuk untuk kolposkopi

Pembahasan:

Hasil Pap Smear LSIL menunjukkan adanya infeksi HPV ringan atau lesi prakanker tingkat rendah. Langkah tepat adalah rujuk ke kolposkopi untuk evaluasi lebih lanjut.

Soal 3: Jawaban C. IVA ulang setiap 3 tahun sekali

Pembahasan:

Wanita dengan hasil IVA negatif direkomendasikan pemeriksaan ulang secara rutin setiap 3 tahun untuk memastikan deteksi dini lesi prakanker serviks.

Area 6

Manajemen Dokumentasi Kebidanan (Metode SOAP)

A. Manajemen Dokumentasi Kebidanan (Metode SOAP)

1. Pengertian Dokumentasi Kebidanan

Dokumentasi kebidanan adalah proses pencatatan secara sistematis dan lengkap atas semua pelayanan kebidanan yang diberikan kepada klien/pasien. Salah satu metode pencatatan yang lazim digunakan dalam praktik kebidanan adalah **SOAP**.

2. Tujuan Dokumentasi Kebidanan

- Menyediakan bukti tertulis pelayanan yang diberikan.
- Mempermudah komunikasi antar tenaga kesehatan.
- Sebagai data legal dalam kasus hukum atau audit medis.
- Memastikan kesinambungan pelayanan kebidanan.
- Sebagai alat evaluasi mutu pelayanan.

3. Pengertian Metode SOAP

SOAP merupakan metode dokumentasi yang sistematis, terstruktur, dan terstandar yang terdiri dari empat komponen utama yaitu:

- *S (Subjective)*: Data subjektif pasien.
- *O (Objective)*: Data objektif hasil pemeriksaan bidan.
- *A (Assessment)*: Analisis/penilaian berdasarkan data subjektif dan objektif.
- *P (Planning)*: Rencana tindakan/intervensi yang akan dilakukan.

4. Penjelasan Lengkap Komponen SOAP

a. *Subjective* (Data Subjektif)

Merupakan data atau informasi yang didapat dari hasil anamnesis kepada pasien atau keluarga pasien. Informasi ini mencakup:

- Keluhan utama pasien.
- Riwayat penyakit saat ini.
- Riwayat kesehatan keluarga.

- Riwayat menstruasi, obstetri, kontrasepsi (pada pasien kebidanan).
- Riwayat sosial ekonomi dan psikologis.

Contoh:

Pasien mengatakan nyeri perut bawah sejak pagi tadi, menstruasi terakhir 8 minggu yang lalu.

b. Objective (Data Objektif)

Data objektif diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, laboratorium, atau penunjang lainnya yang dilakukan oleh bidan. Termasuk:

- Pemeriksaan tanda vital (TD, suhu, nadi, RR).
- Pemeriksaan fisik sistematis.
- Pemeriksaan obstetri (TFU, denyut jantung janin, posisi janin, kontraksi uterus).
- Pemeriksaan penunjang (USG, laboratorium).

Contoh:

TD 120/80 mmHg, Nadi 80 kali/menit, suhu 36,8°C, TFU setinggi simpisis pubis, perdarahan ringan ditemukan di vagina.

c. Assessment (Analisis/Penilaian)

Merupakan analisis dari data subjektif dan objektif, yang menghasilkan diagnosis kebidanan atau masalah kebidanan yang dialami klien.

Dalam assessment kebidanan bisa berupa:

- Diagnosis kebidanan.
- Masalah kebidanan.
- Risiko yang potensial muncul.

Contoh:

G1P0A0 usia kehamilan 8 minggu, abortus imminens.

d. Planning (Rencana Tindakan)

Berupa rencana tindakan atau intervensi yang akan dilakukan sesuai analisis atau diagnosis yang ditemukan, mencakup:

- Penatalaksanaan langsung (pemberian obat, tindakan kebidanan).
- Pendidikan kesehatan dan konseling.
- Rujukan jika diperlukan.
- Jadwal kontrol berikutnya.

Contoh:

- *Anjurkan bedrest.*
- *Berikan edukasi tanda bahaya kehamilan.*
- *Kolaborasi pemberian progesteron oral.*
- *Kontrol ulang dalam 1 minggu.*

5. Prinsip Penting Dokumentasi SOAP Kebidanan

- Jelas dan mudah dipahami
- Ringkas namun lengkap
- Akurat dan faktual
- Ditulis segera setelah tindakan dilakukan
- Tidak menghapus atau menutup kesalahan dengan tipe-x (koreksi dengan satu garis)

6. Manfaat Dokumentasi SOAP dalam Praktik Kebidanan

- Meningkatkan mutu pelayanan kebidanan.
- Mendukung pelayanan berkesinambungan.
- Menjadi bukti hukum apabila terjadi tuntutan.
- Memudahkan komunikasi antar tenaga kesehatan.

7. Peran Bidan dalam Manajemen Dokumentasi Kebidanan

- Melakukan pencatatan segera setelah tindakan kebidanan dilakukan.
- Memastikan kelengkapan dan kejelasan dokumentasi.
- Menjaga kerahasiaan data pasien.
- Menyimpan dokumentasi dalam kondisi aman, mudah ditemukan, serta terjaga dari kerusakan.

PERTANYAAN:

Soal 1

Dalam pencatatan SOAP, data berikut masuk dalam kategori objektif, yaitu:

- A. Keluhan nyeri perut
- B. Riwayat menstruasi terakhir
- C. Pasien cemas menghadapi persalinan
- D. Denyut jantung janin 140 kali/menit
- E. Riwayat keluarga diabetes mellitus

Soal 2

Dalam SOAP kebidanan, bidan menuliskan: "Pasien mengatakan mengalami mual muntah sejak 2 minggu terakhir." Data tersebut termasuk ke dalam komponen:

- A. Subjektif
- B. Objektif
- C. *Assessment*
- D. *Planning*
- E. Diagnosis

Soal 3

Dalam assessment pada pencatatan SOAP kebidanan, hal berikut yang harus dilakukan oleh bidan adalah:

- A. Merumuskan diagnosa kebidanan atau masalah kebidanan
- B. Menuliskan tindakan yang akan dilakukan
- C. Menuliskan hasil pemeriksaan fisik
- D. Menuliskan keluhan pasien
- E. Menentukan jadwal kunjungan berikutnya

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban D. Denyut jantung janin 140 kali/menit

Pembahasan:

Data objektif diperoleh dari pemeriksaan langsung oleh tenaga kesehatan, seperti hasil pemeriksaan fisik (denyut jantung janin).

Soal 2: Jawaban A. Subjektif

Pembahasan:

Keluhan yang dikatakan pasien kepada bidan adalah data subjektif, karena diperoleh melalui anamnesis pasien secara langsung.

Soal 3: Jawaban A. Merumuskan diagnosa kebidanan atau masalah kebidanan

Pembahasan:

Assessment adalah tahap analisis atau penilaian data subjektif dan objektif yang menghasilkan diagnosis kebidanan atau masalah kebidanan pasien.

B. Sistem Rujukan Efektif dalam Pelayanan Kebidanan

1. Pengertian Sistem Rujukan dalam Kebidanan

Sistem rujukan adalah suatu mekanisme pelayanan kesehatan yang mengatur alur pengiriman pasien dari fasilitas pelayanan kesehatan primer (puskesmas, klinik, atau praktik mandiri bidan) ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder atau tersier (rumah sakit) sesuai tingkat kebutuhan atau kondisi pasien.

2. Tujuan Sistem Rujukan Efektif

- Menjamin pasien mendapatkan pelayanan kesehatan tepat waktu dan sesuai kebutuhannya.
- Mengurangi angka kematian ibu dan bayi akibat keterlambatan penanganan.
- Mengoptimalkan sumber daya kesehatan.

- Meningkatkan kualitas dan kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

3. Prinsip Sistem Rujukan Efektif dalam Kebidanan

- a. Cepat dan Tepat Waktu
Segera dilakukan begitu indikasi rujukan ditemukan.
- b. Tepat Sasaran
Merujuk pasien sesuai kondisi yang memerlukan pelayanan lebih lanjut.
- c. Terkoordinasi
Adanya komunikasi antar fasilitas yang jelas dan terstruktur.
- d. Efisien dan Efektif
Menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal.
- e. Berkesinambungan
Adanya kesinambungan pelayanan antara fasilitas rujukan dan fasilitas perujuk.

4. Kriteria Indikasi Rujukan dalam Pelayanan Kebidanan

Indikasi Maternal:

- Preeklamsia berat/Eklamsia.
- Perdarahan antepartum/postpartum berat.
- Partus macet atau distosia.
- Retensio plasenta.
- Ruptur uteri.
- Sepsis puerperalis.
- Komplikasi abortus.

Indikasi Neonatal:

- Asfiksia neonatorum.
- Bayi prematur atau Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) <2500 gram.
- Ikterus neonatorum patologis.
- Sepsis neonatorum.
- Kelainan kongenital.
- Bayi dengan gangguan napas berat.

5. Jenis-jenis Sistem Rujukan

- a. Rujukan Horizontal
Rujukan antar fasilitas kesehatan setingkat (misalnya antar puskesmas).
- b. Rujukan Vertikal
Rujukan dari fasilitas tingkat primer ke tingkat yang lebih tinggi (puskesmas ke RS).

c. Rujukan Balik

Pengembalian pasien dari fasilitas rujukan lebih tinggi ke fasilitas primer setelah kondisi stabil.

6. Alur dan Prosedur Rujukan Efektif dalam Kebidanan

a. Identifikasi Indikasi Rujukan

- Menilai kondisi pasien secara cepat dan akurat.

b. Persiapan Rujukan

- Persiapkan pasien secara klinis (stabilisasi pasien).
- Persiapkan dokumen rujukan (surat rujukan, catatan medik).
- Informasikan kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi pasien dan tujuan rujukan.

c. Komunikasi dan Koordinasi dengan Tempat Rujukan

- Hubungi fasilitas kesehatan penerima untuk konfirmasi kesiapan.

d. Transportasi

- Pastikan transportasi aman dan nyaman, idealnya dengan ambulans khusus.

e. Pemantauan dan Evaluasi Pasca Rujukan

- Tindak lanjut informasi dari fasilitas rujukan.
- Pastikan pasien mendapatkan pelayanan lanjutan yang optimal.

7. Dokumen Penting dalam Rujukan Kebidanan

- Surat rujukan resmi (berisi identitas pasien, kondisi pasien, tindakan awal, alasan rujukan).
- Buku KIA atau rekam medis pasien.
- Hasil pemeriksaan penunjang jika ada (USG, laboratorium).
- Catatan pemberian obat/tindakan sebelum dirujuk.

8. Peran Bidan dalam Sistem Rujukan Efektif

- Mendeteksi dini kondisi yang memerlukan rujukan.
- Memberikan stabilisasi awal pasien sebelum dirujuk.
- Menyiapkan kelengkapan administrasi dan koordinasi rujukan.
- Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga.
- Melakukan follow-up setelah pasien kembali dari fasilitas rujukan.

PERTANYAAN:

Soal 1

Seorang ibu melahirkan di BPM mengalami perdarahan postpartum sebanyak 700 cc dalam 30 menit pertama setelah bayi lahir. Kondisi ibu pucat, denyut nadi cepat, dan TD turun. Tindakan paling tepat yang dilakukan bidan adalah:

- A. Melakukan rujukan segera ke rumah sakit
- B. Menunggu kondisi stabil sebelum dirujuk
- C. Memberikan edukasi saja kepada keluarga
- D. Memberikan obat antiinflamasi
- E. Menyarankan pulang dan kontrol minggu depan

Soal 2

Dokumen penting yang wajib disiapkan bidan sebelum merujuk pasien ke fasilitas rujukan, kecuali:

- A. Surat rujukan resmi
- B. Buku KIA atau catatan medis pasien
- C. Kartu keluarga pasien
- D. Hasil pemeriksaan penunjang
- E. Catatan pemberian obat sebelum dirujuk

Soal 3

Seorang bayi baru lahir dengan berat 2000 gram, tampak sianosis, dan kesulitan bernapas segera setelah lahir. Langkah awal paling tepat sebelum merujuk adalah:

- A. Menunggu keluarga setuju untuk rujukan
- B. Memberikan edukasi pada ibu
- C. Membiarkan bayi dalam perawatan ibu
- D. Merujuk tanpa melakukan tindakan stabilisasi
- E. Menstabilkan kondisi bayi dengan pemberian oksigen dan pemantauan tanda vital

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban A. Melakukan rujukan segera ke rumah sakit

Pembahasan:

Perdarahan postpartum berat (>500 cc) dengan tanda syok memerlukan rujukan segera setelah stabilisasi awal minimal.

Soal 2: Jawaban C. Kartu keluarga pasien**Pembahasan:**

Kartu keluarga bukan dokumen wajib untuk rujukan. Dokumen wajib adalah surat rujukan, buku KIA atau rekam medis, hasil penunjang, dan catatan tindakan awal.

Soal 3: Jawaban E. Menstabilkan kondisi bayi dengan pemberian oksigen dan pemantauan tanda vital**Pembahasan:**

Sebelum dirujuk, pasien (bayi) harus mendapatkan stabilisasi awal, seperti pemberian oksigen dan pemantauan tanda vital untuk meningkatkan keselamatan bayi selama transportasi.

C. Manajemen Kualitas dalam Pelayanan Kebidanan (Audit Klinik dan Evaluasi Pelayanan)**1. Pengertian Manajemen Kualitas Pelayanan Kebidanan**

Manajemen kualitas dalam pelayanan kebidanan adalah proses terstruktur yang dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan terukur untuk meningkatkan mutu layanan yang diberikan oleh bidan kepada pasien. Upaya ini mencakup audit klinik dan evaluasi pelayanan sebagai alat utama untuk menilai, mengontrol, dan meningkatkan kualitas layanan.

2. Tujuan Manajemen Kualitas dalam Kebidanan

- Menjamin keselamatan pasien (*patient safety*).
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kebidanan.
- Menurunkan angka kejadian kesalahan dalam praktik kebidanan.
- Memperbaiki mutu pelayanan kebidanan secara berkelanjutan.
- Memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Komponen Utama Manajemen Kualitas Kebidanan**a. Standar Pelayanan Kebidanan**

Panduan tertulis yang digunakan sebagai acuan dalam pemberian pelayanan kebidanan.

b. Audit Klinik

Penilaian sistematis terhadap praktik kebidanan melalui pencatatan dan analisis data pelayanan klinik untuk membandingkan antara praktik aktual dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelayanan

Proses penilaian sistematis terhadap hasil dan dampak pelayanan kebidanan terhadap pasien maupun institusi secara keseluruhan.

4. Audit Klinik dalam Pelayanan Kebidanan

a. Pengertian Audit Klinik

Audit klinik adalah proses evaluasi sistematis terhadap praktik klinik, prosedur, dan hasil tindakan, dengan membandingkan terhadap standar yang ditetapkan, bertujuan meningkatkan mutu pelayanan pasien.

b. Langkah-langkah Audit Klinik

- 1) Menentukan topik audit (misal: kasus kematian ibu, komplikasi persalinan, partograf, dll).
- 2) Menentukan kriteria dan standar audit (mengacu pada pedoman nasional atau internasional).
- 3) Pengumpulan data (melalui catatan medis, wawancara, observasi).
- 4) Analisis data (membandingkan hasil audit dengan standar).
- 5) Implementasi perubahan (perbaikan tindakan berdasarkan hasil audit).
- 6) Evaluasi ulang (Re-audit) untuk menilai keberhasilan intervensi perbaikan.

c. Manfaat Audit Klinik

- Mengidentifikasi area kelemahan pelayanan.
- Menyusun rencana tindakan perbaikan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
- Meningkatkan kesadaran profesionalisme tenaga kebidanan.

5. Evaluasi Pelayanan dalam Kebidanan

a. Pengertian Evaluasi Pelayanan

Evaluasi pelayanan adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, kualitas, serta kepuasan pengguna pelayanan kebidanan. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

b. Metode Evaluasi Pelayanan

• **Evaluasi Kepuasan Pasien**

Menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengukur tingkat kepuasan pasien.

- **Evaluasi Hasil Pelayanan (Outcome Evaluation)**

Menilai hasil akhir pelayanan terhadap pasien, seperti angka kematian ibu dan bayi, kejadian komplikasi, atau angka infeksi nosokomial.

- **Evaluasi Proses Pelayanan**

Menilai kesesuaian proses pelayanan dengan pedoman atau standar operasional yang berlaku.

6. Indikator Evaluasi Mutu Pelayanan Kebidanan

- Kepatuhan penggunaan partograf dalam persalinan.
- Kepatuhan standar prosedur operasional (SPO).
- Angka kejadian komplikasi dalam pelayanan kebidanan.
- Angka rujukan tepat waktu dan tepat indikasi.
- Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan.

7. Strategi Meningkatkan Manajemen Kualitas dalam Kebidanan

- Penyusunan standar pelayanan kebidanan yang jelas.
- Pelatihan berkala tenaga kebidanan dalam manajemen mutu.
- Audit klinik secara rutin dengan feedback hasil audit.
- Evaluasi berkala terhadap pelayanan kebidanan.
- Peningkatan komunikasi dan kolaborasi tim.

8. Peran Bidan dalam Manajemen Kualitas

- Mengikuti pelatihan manajemen kualitas.
- Berpartisipasi aktif dalam audit klinik.
- Menjalankan praktik sesuai standar pelayanan kebidanan.
- Melakukan dokumentasi yang baik dan lengkap.
- Mengikuti evaluasi berkala untuk peningkatan mutu pelayanan.

PERTANYAAN:

Soal 1

Audit klinik dalam pelayanan kebidanan bertujuan utama untuk:

- A. Memberikan tindakan medis langsung pada pasien
- B. Menentukan biaya pelayanan kebidanan
- C. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui evaluasi praktik klinis
- D. Menilai kompetensi tenaga kesehatan secara individu
- E. Menentukan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan

Soal 2

Dalam pelaksanaan audit klinik, langkah awal yang harus dilakukan adalah

- A. Mengumpulkan data
- B. Menentukan topik audit
- C. Implementasi perubahan
- D. Melakukan analisis data
- E. Mengevaluasi ulang hasil audit

Soal 3

Seorang bidan ingin mengevaluasi kepuasan pasien terhadap pelayanan kebidanan yang diberikan.

Metode evaluasi paling tepat yang dapat digunakan adalah

- A. Audit klinik
- B. Evaluasi proses
- C. Evaluasi outcome
- D. Evaluasi kepuasan pasien
- E. Observasi langsung

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban C. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui evaluasi praktik klinis

Pembahasan:

Audit klinik secara sistematis mengevaluasi praktik klinis dibandingkan standar dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan klinis.

Soal 2: Jawaban B. Menentukan topik audit

Pembahasan:

Langkah pertama audit klinik adalah menentukan topik audit, diikuti penetapan standar, pengumpulan data, analisis, implementasi perubahan, dan evaluasi ulang.

Soal 3: Jawaban D. Evaluasi kepuasan pasien

Pembahasan:

Evaluasi kepuasan pasien menggunakan kuesioner atau wawancara merupakan metode yang paling tepat untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan.

Area 7

Pengabdian Masyarakat dan Promosi Kesehatan

A. Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Pengertian Kesehatan Reproduksi Remaja

Kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi sehat yang mencakup sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada remaja, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Remaja memiliki hak untuk mendapatkan informasi akurat tentang kesehatan reproduksi demi masa depan yang lebih sehat.

2. Tujuan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

- Meningkatkan pengetahuan remaja tentang sistem reproduksi dan fungsinya.
- Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) pada remaja.
- Menurunkan angka kejadian infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS.
- Membentuk sikap positif remaja terhadap kesehatan reproduksi.
- Mempersiapkan remaja agar bertanggung jawab dalam kehidupan seksual dan reproduksi.

3. Ruang Lingkup Materi Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

- a. Anatomi dan fisiologi sistem reproduksi.
- b. Pubertas dan perubahan fisik serta psikologis pada remaja.
- c. Pencegahan kehamilan tidak diinginkan pada remaja.
- d. Pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS.
- e. Perilaku seksual berisiko dan dampaknya.
- f. Kesehatan menstruasi dan personal hygiene.
- g. Kekerasan seksual dan pencegahannya.
- h. Keterampilan hidup (life skills) untuk remaja, seperti keterampilan komunikasi asertif dan pengambilan keputusan.

4. Strategi Edukasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja

- a. Pendekatan Teman Sebaya (*Peer Group Education*)
Melibatkan remaja sebaya yang telah dilatih untuk memberikan edukasi kesehatan reproduksi kepada teman-temannya.
- b. Metode Interaktif
Diskusi kelompok, permainan peran, tanya jawab, brainstorming, simulasi, dan workshop.
- c. Media Informasi Menarik
Poster, leaflet, media sosial, video edukasi, dan aplikasi digital.
- d. Pendidikan Terstruktur
Melalui sekolah, program bimbingan konseling, organisasi remaja, atau komunitas.

5. Peran Bidan dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

- Memberikan edukasi dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan ramah remaja.
- Menjadi pendamping dan narasumber yang terpercaya dalam masalah kesehatan reproduksi.
- Melakukan advokasi agar program edukasi kesehatan reproduksi masuk dalam kurikulum sekolah.
- Melatih peer educator untuk kegiatan promosi kesehatan reproduksi remaja.
- Mengidentifikasi remaja yang berisiko tinggi untuk intervensi lebih lanjut.

6. Tantangan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

- Persepsi negatif atau tabu terhadap pembahasan seksual dan reproduksi di masyarakat.
- Informasi yang salah (mitos) tentang kesehatan reproduksi dikalangan remaja.
- Kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga atau sekolah.

7. Cara Mengatasi Tantangan Edukasi Reproduksi Remaja

- Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, orang tua, dan pihak sekolah.
- Menggunakan pendekatan yang ramah remaja dan menjunjung tinggi nilai budaya setempat.
- Memberikan edukasi berbasis fakta ilmiah yang sederhana dan mudah dimengerti.
- Menggunakan media sosial sebagai alat edukasi populer di kalangan remaja.

8. Indikator Keberhasilan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

- Peningkatan pengetahuan dan sikap positif remaja terhadap kesehatan reproduksi.
- Penurunan angka kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja.
- Penurunan angka IMS dan HIV/AIDS di kalangan remaja.
- Meningkatnya keterampilan remaja dalam mengambil keputusan sehat dalam perilaku seksual.

PERTANYAAN:

Soal 1

Strategi edukasi yang paling efektif digunakan dalam edukasi kesehatan reproduksi remaja adalah:

- A. Ceramah panjang dengan bahasa formal
- B. Menggunakan pendekatan teman sebaya (*peer group education*)
- C. Menggunakan buku tebal tanpa ilustrasi
- D. Hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan senior
- E. Menghindari diskusi interaktif

Soal 2

Tujuan utama dari edukasi kesehatan reproduksi pada remaja adalah

- A. Mempercepat usia pernikahan remaja
- B. Meningkatkan angka kehamilan pada remaja
- C. Menurunkan angka kejadian kehamilan tidak diinginkan
- D. Menghindari komunikasi tentang seksualitas
- E. Meningkatkan perilaku seksual bebas

Soal 3

Bidan melakukan edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Materi penting yang harus disampaikan kepada remaja perempuan terkait personal hygiene selama menstruasi adalah

- A. Pentingnya mengganti pembalut setiap 4–6 jam
- B. Menghindari mandi selama menstruasi
- C. Tidak perlu menjaga kebersihan alat kelamin
- D. Menggunakan pembalut selama 24 jam penuh
- E. Tidak boleh beraktivitas selama menstruasi

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban B Menggunakan pendekatan teman sebaya (*peer group education*)

Pembahasan: Pendekatan *peer group education* terbukti efektif karena remaja lebih nyaman dan terbuka berbicara dengan teman sebaya tentang isu kesehatan reproduksi.

Soal 2: Jawaban C. Menurunkan angka kejadian kehamilan tidak diinginkan

Pembahasan: Edukasi kesehatan reproduksi bertujuan mengurangi risiko kehamilan tidak diinginkan, IMS, dan HIV/AIDS melalui pemberian informasi yang akurat.

Soal 3: Jawaban A. Pentingnya mengganti pembalut setiap 4–6 Jam

Pembahasan:

Mengganti pembalut secara rutin setiap 4–6 jam sangat penting untuk mencegah infeksi genital akibat bakteri yang tumbuh di pembalut lembab.

B. Promosi Kesehatan Ibu dan Anak dalam Masyarakat

1. Pengertian Promosi Kesehatan Ibu dan Anak

Promosi kesehatan ibu dan anak adalah proses pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan kontrol terhadap kesehatan ibu dan anak. Ini dilakukan melalui edukasi, advokasi, dan berbagai kegiatan preventif untuk mencegah masalah kesehatan, komplikasi, atau penyakit yang berkaitan dengan ibu hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan balita.

2. Tujuan Promosi Kesehatan Ibu dan Anak

- Mengurangi angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).
- Meningkatkan kesadaran ibu tentang pentingnya perawatan antenatal (ANC), persalinan aman, perawatan nifas, serta perawatan neonatal.
- Meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak.
- Mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini.
- Membentuk perilaku hidup sehat di lingkungan keluarga dan masyarakat.

3. Ruang Lingkup Promosi Kesehatan Ibu dan Anak

- a. Kesehatan Ibu Hamil
 - Pentingnya ANC minimal 6 kali selama kehamilan.
 - Edukasi tanda bahaya kehamilan (perdarahan, preeklamsia, anemia).
 - Pentingnya nutrisi seimbang, konsumsi tablet zat besi, asam folat, dan kalsium.
 - Persiapan persalinan aman dan rencana persalinan (P4K).
- b. Kesehatan Persalinan
 - Pentingnya persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih.
 - Penggunaan partograf selama persalinan.
 - Deteksi dini dan penanganan komplikasi persalinan (perdarahan, distosia).
- c. Kesehatan Nifas
 - Pentingnya pemeriksaan nifas minimal 4 kali (KF1–KF4).
 - Edukasi tanda bahaya nifas (perdarahan postpartum, infeksi nifas).
 - Pentingnya perawatan payudara dan promosi ASI eksklusif.
- d. Kesehatan Neonatal dan Bayi
 - Pentingnya pemeriksaan bayi baru lahir minimal 3 kali (KN1–KN3).
 - Edukasi tanda bahaya neonatal (asfiksia, ikterus, hipotermia).
 - Imunisasi dasar lengkap untuk bayi.
- e. Kesehatan Anak dan Balita
 - Pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu.
 - Edukasi tentang pola makan bergizi, pencegahan stunting dan gizi buruk.
 - Pencegahan penyakit infeksi pada anak (diare, ISPA).

4. Strategi Promosi Kesehatan Ibu dan Anak

- a. Pendidikan Kesehatan (*Health Education*)
Ceramah, diskusi, konseling, demonstrasi.
- b. Pemberdayaan Masyarakat
Pelatihan kader kesehatan, pembentukan posyandu, kelompok ibu hamil, dan klub ibu menyusui.
- c. Advokasi
Kerjasama dengan tokoh masyarakat, pemimpin lokal, pemerintah daerah.
- d. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
Leaflet, poster, media sosial, radio, televisi, aplikasi kesehatan digital.

5. Media Promosi Kesehatan Ibu dan Anak

- Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak).
- Poster dan leaflet tentang gizi, ASI eksklusif, dan tanda bahaya.
- Media audio visual (video edukasi, animasi).
- Media digital dan aplikasi berbasis smartphone.

6. Peran Bidan dalam Promosi Kesehatan Ibu dan Anak

- Memberikan edukasi langsung kepada ibu, keluarga, dan masyarakat.
- Melatih kader kesehatan dan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak.
- Melakukan advokasi kebijakan kesehatan ibu dan anak kepada pemangku kepentingan.
- Menyediakan layanan kesehatan ibu dan anak yang promotif, preventif, dan kuratif.

7. Tantangan Promosi Kesehatan Ibu dan Anak di Masyarakat

- Masih adanya mitos dan kepercayaan yang salah terkait kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi.
- Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat.
- Kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil.
- Kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan sekitar.

8. Cara Mengatasi Tantangan Promosi Kesehatan Ibu dan Anak

- Pendekatan berbasis budaya setempat untuk mengatasi mitos dan kepercayaan yang salah.
- Melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam kegiatan promosi kesehatan.
- Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan keliling.
- Melibatkan kader kesehatan dan tenaga kesehatan setempat dalam edukasi komunitas.

PERTANYAAN:

Soal 1

Dalam promosi kesehatan ibu hamil, bidan perlu memberikan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan minimal sebanyak:

- A. 2 kali
- B. 3 kali
- C. 4 kali

- D. 5 kali
- E. 6 kali

Soal 2

Bidan sedang melakukan promosi kesehatan terkait pentingnya ASI eksklusif kepada kelompok ibu menyusui di posyandu. Edukasi penting yang harus disampaikan kepada ibu adalah:

- A. Memberikan ASI eksklusif hingga usia bayi 4 bulan
- B. Memberikan tambahan air putih pada bayi di bawah 6 bulan
- C. ASI eksklusif diberikan sampai bayi usia 6 bulan
- D. Menunda pemberian ASI sampai bayi berusia 3 hari
- E. Bayi boleh diberikan makanan padat mulai usia 2 bulan

Soal 3

Dalam promosi kesehatan neonatal, bidan mengedukasi ibu tentang tanda bahaya neonatus yang memerlukan rujukan segera ke fasilitas kesehatan, salah satunya adalah:

- A. Tidur nyenyak
- B. Refleks isap kuat
- C. Demam tinggi atau hipotermia
- D. Warna kulit kemerahan saat menangis
- E. Berat badan lahir >2500 gram

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban E. 6 kali

Pembahasan:

Berdasarkan standar terbaru Kemenkes RI, pemeriksaan antenatal care (ANC) minimal sebanyak 6 kali selama kehamilan, yaitu 2 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga.

Soal 2: Jawaban C. ASI eksklusif diberikan sampai bayi usia 6 bulan

Pembahasan:

WHO dan Kemenkes RI merekomendasikan pemberian ASI eksklusif tanpa makanan atau minuman tambahan lain selama 6 bulan pertama kehidupan bayi.

Soal 3: Jawaban C. Demam tinggi atau hipotermia

Pembahasan:

Demam tinggi ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau hipotermia ($< 36^{\circ}\text{C}$) merupakan tanda bahaya neonatal yang memerlukan rujukan segera karena berisiko tinggi mengalami komplikasi berat seperti sepsis neonatorum.

C. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

1. Pengertian Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah segala bentuk tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran pada perempuan dan anak, baik yang terjadi di lingkungan keluarga, komunitas, maupun dalam kehidupan publik.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

a. Kekerasan Fisik

Memukul, menendang, mencubit, mendorong, melempar benda.

b. Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, pencabulan.

c. Kekerasan Psikologis/Emosional

Penghinaan, intimidasi, ancaman, isolasi sosial, pembatasan kebebasan.

d. Kekerasan Ekonomi

Mengontrol akses terhadap uang, melarang bekerja, atau mengeksploitasi secara ekonomi.

e. Penelantaran

Tidak memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

3. Dampak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

a. Dampak Fisik

Cedera fisik, luka, memar, patah tulang, bahkan kematian.

b. Dampak Psikologis

Trauma, depresi, gangguan kecemasan, stres pasca trauma (PTSD).

c. Dampak Sosial

Stigma sosial, isolasi, kesulitan dalam hubungan interpersonal.

d. Dampak Jangka Panjang

Gangguan tumbuh kembang anak, gangguan kesehatan reproduksi pada perempuan, hingga gangguan kejiwaan.

4. Faktor Risiko Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Faktor Individu

- Riwayat pelaku atau korban pernah mengalami kekerasan.
- Ketergantungan ekonomi atau sosial korban terhadap pelaku.

Faktor Keluarga

- Ketidakharmonisan dalam keluarga.
- Adanya kekerasan dalam keluarga sebelumnya.

Faktor Sosial dan Budaya

- Norma sosial yang mendukung kekerasan atau patriarki.
- Stigma terhadap korban kekerasan.

5. Strategi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

- a. Pencegahan Primer (Mencegah Sebelum Terjadi)
 - Edukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak.
 - Pendidikan parenting positif kepada orang tua.
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif kekerasan.
 - Kampanye anti-kekerasan melalui media sosial, media massa, dan kelompok masyarakat.
- b. Pencegahan Sekunder (Deteksi Dini)
 - Melakukan skrining kekerasan dalam kunjungan kesehatan rutin.
 - Mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan pada perempuan dan anak sejak dini.
 - Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang deteksi dini dan penanganan korban kekerasan.
- c. Pencegahan Tersier (Penanganan Korban)
 - Memberikan dukungan psikologis dan rehabilitasi kepada korban.
 - Merujuk korban ke pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A).
 - Memberikan layanan medis dan psikososial secara menyeluruh.

6. Peran Bidan dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

- Memberikan edukasi dan konseling kepada ibu dan keluarga tentang pencegahan kekerasan.
- Melakukan deteksi dini dan identifikasi tanda-tanda kekerasan.
- Melaporkan kasus kekerasan kepada pihak yang berwenang (aparatus hukum atau lembaga perlindungan).
- Memberikan dukungan psikologis awal (psychological first aid) kepada korban.
- Menghubungkan korban dengan layanan rujukan dan perlindungan hukum.

7. Lembaga dan Pelayanan yang Dapat Diakses Korban

- P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak)
- Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak

- LSM/NGO yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak
- Kepolisian (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak – UPPA)
- Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan visum dan psikososial.

PERTANYAAN:

Soal 1

Seorang anak usia 7 tahun datang bersama ibunya dengan luka lebam yang tidak wajar di tubuhnya.

Tindakan pertama yang sebaiknya dilakukan oleh bidan adalah:

- Menanyakan kepada anak secara paksa tentang luka tersebut
- Melakukan deteksi dini dan melaporkan kasus ke pihak berwenang
- Mengabaikan luka karena menganggap hal biasa
- Menyarankan ibu memukul balik pelaku
- Memberikan obat analgesik tanpa investigasi lebih lanjut

Soal 2

Upaya pencegahan primer dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah:

- Memberikan pengobatan terhadap korban
- Melakukan deteksi dini setelah terjadi kekerasan
- Melakukan visum kepada korban kekerasan
- Menempatkan korban di pusat rehabilitasi
- Melakukan pendidikan parenting positif kepada orang tua

Soal 3

Bentuk kekerasan yang terjadi bila pasangan mengontrol penuh akses keuangan dan melarang perempuan bekerja termasuk kategori:

- Kekerasan fisik
- Kekerasan seksual
- Kekerasan psikologis
- Kekerasan ekonomi
- Penelantaran

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban B. Melakukan deteksi dini dan melaporkan kasus ke pihak berwenang

Pembahasan:

Bidan memiliki kewajiban melaporkan indikasi kekerasan anak kepada pihak berwenang dan melakukan penanganan awal dengan deteksi dini.

Soal 2: Jawaban E. Melakukan pendidikan parenting positif kepada orang tua

Pembahasan:

Pencegahan primer adalah tindakan sebelum kekerasan terjadi, termasuk edukasi dan pendidikan positif kepada keluarga.

Soal 3: Jawaban D. Kekerasan ekonomi

Pembahasan:

Mengontrol akses keuangan, melarang bekerja, atau memanfaatkan ekonomi seseorang merupakan kekerasan ekonomi.

Area 8

Farmakologi Kebidanan

A. Penggunaan Obat Uterotonika (Oksitosin, Methergin, Misoprostol)

1. Pengertian Uterotonika

Uterotonika adalah obat-obatan yang merangsang kontraksi otot polos rahim (uterus), digunakan untuk mencegah atau mengatasi perdarahan postpartum (perdarahan setelah persalinan), serta manajemen persalinan dan nifas.

2. Jenis dan Mekanisme Kerja Uterotonika

a. Oksitosin

Mekanisme kerja:

- Merangsang kontraksi otot polos rahim secara ritmik dan teratur.
- Mempercepat involusi uteri postpartum.

Indikasi penggunaan:

- Induksi dan augmentasi persalinan.
- Pencegahan dan penanganan perdarahan postpartum.

Dosis dan cara pemberian:

- Pencegahan perdarahan postpartum: 10 IU IM setelah kelahiran bayi.
- Terapi perdarahan postpartum: Infus IV 20–40 IU dalam 500 mL cairan RL/NaCl dengan tetesan diatur sesuai respons uterus.

Efek samping:

- Kontraksi berlebihan (hipertonus uterus).
- Nyeri atau kram uterus.
- Hipotensi jika diberikan IV bolus.

Kontraindikasi:

- Distosia akibat posisi janin abnormal.
- Riwayat hipersensitivitas terhadap oksitosin.

b. Methergin (Metilergometrin)

Mekanisme kerja:

- Menyebabkan kontraksi uterus kuat, berkelanjutan, serta vasokonstriksi pembuluh darah uterus.

Indikasi penggunaan:

- Penanganan perdarahan postpartum akibat atonia uteri.

Dosis dan cara pemberian:

- 0,2 mg IM, dapat diulang setiap 2–4 jam maksimal 5 dosis.
- Oral: 0,125–0,25 mg tiap 6–8 jam setelah perdarahan berhenti.

Efek samping:

- Hipertensi.
- Sakit kepala.
- Mual, muntah, pusing.

Kontraindikasi:

- Hipertensi kronis, preeklamsia/eklamsia.
- Penyakit jantung iskemik.
- Kehamilan (tidak untuk induksi persalinan).

c. **Misoprostol (Sitotek)**

Mekanisme kerja:

- Analog prostaglandin E1 yang menyebabkan kontraksi uterus.

Indikasi penggunaan:

- Pencegahan dan penanganan perdarahan postpartum, terutama jika oksitosin tidak tersedia.
- Induksi persalinan (dalam kondisi tertentu).
- Penanganan abortus inkomplit.

Dosis dan cara pemberian:

- Pencegahan perdarahan postpartum: 600 µg oral atau sublingual setelah bayi lahir.
- Penanganan perdarahan postpartum: 800 µg sublingual/rektal.
- Abortus inkomplit: 400–600 µg oral/sublingual.

Efek samping:

- Demam, menggigil.
- Diare, nyeri abdomen, mual.

Kontraindikasi:

- Hipersensitivitas terhadap prostaglandin.
- Kehamilan dengan riwayat operasi rahim sebelumnya (misalnya SC atau miomektomi) untuk induksi persalinan.

3. Prinsip Penggunaan Uterotonika dalam Praktik Kebidanan

- Gunakan uterotonika sesuai indikasi dan dosis yang tepat.
- Perhatikan kontraindikasi setiap uterotonika.
- Observasi ketat efek samping dan respon uterus setelah pemberian obat.
- Siapkan resusitasi atau rujukan apabila terjadi efek samping serius atau perdarahan tidak teratasi.

- Edukasi pasien tentang efek samping yang mungkin terjadi setelah pemberian uterotonika.

4. Peran Bidan dalam Penggunaan Uterotonika

- Mengidentifikasi indikasi penggunaan uterotonika secara dini.
- Memberikan uterotonika sesuai protokol yang berlaku.
- Memantau kondisi pasien secara intensif setelah pemberian uterotonika.
- Melakukan pencatatan dan dokumentasi pemberian obat secara lengkap dan jelas.
- Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang tujuan, manfaat, dan efek samping dari uterotonika.

PERTANYAAN:

Soal 1

Seorang bidan akan memberikan oksitosin untuk mencegah perdarahan postpartum segera setelah bayi lahir. Berapa dosis yang paling tepat untuk pencegahan tersebut?

- A. 5 IU IM
- B. 10 IU IM
- C. 20 IU IV bolus
- D. 15 IU oral
- E. 30 IU IV bolus

Soal 2

Seorang ibu postpartum mengalami perdarahan karena atonia uteri. Setelah pemberian oksitosin, perdarahan belum teratasi. Pilihan uterotonika berikutnya yang paling tepat diberikan, jika ibu tidak memiliki riwayat hipertensi atau preeklamsia adalah:

- A. Metilergometrin (Methergin)
- B. Penicillin
- C. Ampisilin
- D. Magnesium sulfat
- E. Diazepam

Soal 3

Efek samping yang paling sering terjadi setelah pemberian Misoprostol dalam dosis tinggi untuk perdarahan postpartum adalah:

- A. Hipertensi berat
- B. Diare dan menggigil
- C. Bradikardia

- D. Hipoglikemia
- E. Penurunan kesadaran

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban B. 10 IU IM

Pembahasan:

Dosis standar oksitosin untuk pencegahan perdarahan postpartum menurut WHO adalah 10 IU intramuskular setelah kelahiran bayi.

Soal 2: Jawaban A. Metilergometrin (Methergin)

Pembahasan:

Methergin efektif untuk atonia uteri yang tidak responsif terhadap oksitosin. Perhatikan bahwa Methergin dikontraindikasikan pada ibu hipertensi atau preeklamsia.

Soal 3: Jawaban B. Diare dan menggigil

Pembahasan:

Misoprostol sering menimbulkan efek samping berupa demam, menggigil, diare, dan nyeri abdomen, terutama pada dosis tinggi (800 µg).

B. Tokolitika dan Analgesik dalam Kebidanan

1. Tokolitika Dalam Kebidanan

a. Pengertian Tokolitika

Tokolitika adalah obat-obatan yang digunakan untuk menghambat atau menekan kontraksi uterus, terutama pada persalinan prematur, agar proses kelahiran dapat ditunda dan memberikan waktu untuk intervensi yang diperlukan (seperti pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru janin).

b. Indikasi Penggunaan Tokolitika

- Ancaman persalinan prematur antara usia kehamilan 24–34 minggu.
- Memberikan waktu tambahan untuk pemberian kortikosteroid guna pematangan paru-paru janin.
- Mengurangi risiko komplikasi akibat kelahiran prematur.

c. Jenis dan Contoh Obat Tokolitika

- Nifedipin (kalsium antagonis)
Dosis: 10 mg oral, dapat diulang setiap 15–20 menit hingga maksimal 40 mg dalam 1 jam pertama, lalu dilanjutkan 10–20 mg setiap 4–6 jam.
- Salbutamol/Terbutalin (agonis beta-2 adrenergik)

Dosis: Terbutalin 0,25 mg subkutan, bisa diulang maksimal 4 dosis/hari.

- **Magnesium Sulfat (MgSO₄)**

Lebih sering digunakan pada preeklamsia berat untuk pencegahan kejang, memiliki efek tokolitik sekunder.

Dosis: Loading dose 4–6 gram IV, dilanjutkan maintenance 1–2 gram per jam.

d. Efek Samping Tokolitik

- Takikardia, palpitasi, hipotensi (Terbutalin, Nifedipin).
- Pusing, sakit kepala, mual.
- Gangguan elektrolit atau kelemahan otot (MgSO₄).

e. Kontraindikasi Tokolitik

- Kehamilan dengan infeksi intrauterin.
- Perdarahan antepartum berat (plasenta previa, solusio plasenta).
- Kondisi janin yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan kehamilannya.

2. Analgesik Dalam Kebidanan

a. Pengertian Analgesik

Analgesik adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, termasuk nyeri selama persalinan, postpartum, maupun prosedur kebidanan lainnya.

b. Indikasi Penggunaan Analgesik

- Nyeri persalinan yang hebat dan tidak tertahankan.
- Nyeri postpartum seperti episiotomi atau ruptur perineum.
- Nyeri setelah tindakan kebidanan (misalnya pasca operasi caesar).

c. Jenis dan Contoh Obat Analgesik

- **Analgesik Non-narkotik**
 - Parasetamol (Acetaminophen) 500–1000 mg setiap 4–6 jam.
 - Ibuprofen 200–400 mg tiap 6–8 jam (setelah melahirkan).
- **Analgesik Narkotik (Opioid)**
 - Petidin 50–100 mg IM, dapat diulang 4–6 jam bila diperlukan.
 - Morfin (jarang digunakan di persalinan normal karena efek depresi pernapasan).
- **Anestesi lokal (Lidokain)** untuk episiotomi atau tindakan bedah kecil lainnya.

d. Efek Samping Analgesik

- Analgesik non-narkotik: Jarang efek samping, kadang mual atau gangguan lambung.

- Analgesik narkotik: Depresi pernapasan, mual, muntah, mengantuk.
- Anestesi lokal: Reaksi alergi lokal atau sistemik, nyeri di lokasi penyuntikan.

e. Kontraindikasi Analgesik

- Riwayat alergi berat terhadap analgesik tertentu.
- Pasien dengan gangguan pernapasan berat (untuk analgesik opioid).
- Riwayat ulkus lambung akut (untuk NSAID).

3. Peran Bidan dalam Penggunaan Tokolitik dan Analgesik

- Mengetahui indikasi, dosis, cara pemberian, dan kontraindikasi obat dengan tepat.
- Melakukan pemantauan ketat terhadap efek samping setelah pemberian obat.
- Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang tujuan dan efek samping obat.
- Dokumentasi penggunaan obat secara rinci dan akurat dalam rekam medis.

PERTANYAAN:

Soal 1

Seorang wanita hamil 30 minggu datang dengan keluhan kontraksi uterus setiap 10 menit sekali. Setelah pemeriksaan, didiagnosis dengan ancaman persalinan prematur.

Obat tokolitik yang paling tepat diberikan adalah:

- A. Metilergometrin
- B. Oksitosin
- C. Nifedipin
- D. Parasetamol
- E. Misoprostol

Soal 2

Seorang ibu postpartum mengeluhkan nyeri berat akibat jahitan episiotomi. Pilihan analgesik non-narkotik yang paling aman diberikan adalah:

- A. Ibuprofen
- B. Morfin
- C. Petidin
- D. Diazepam
- E. Fenobarbital

Soal 3

Bidan memberikan petidin untuk mengatasi nyeri persalinan. Efek samping yang harus dipantau secara ketat setelah pemberian obat tersebut adalah:

- A. Takikardia
- B. Hiperglikemia
- C. Depresi pernapasan
- D. Hipertensi
- E. Diare

KUNCI JAWABAN:**Soal 1: Jawaban C. Nifedipin****Pembahasan:**

Nifedipin merupakan pilihan utama tokolitik untuk menekan kontraksi uterus pada ancaman persalinan prematur.

Soal 2: Jawaban A. Ibuprofen**Pembahasan:**

Ibuprofen adalah analgesik non-narkotik yang aman dan efektif untuk nyeri postpartum akibat episiotomi atau ruptur perineum.

Soal 3: Jawaban C. Depresi pernapasan**Pembahasan:**

Petidin merupakan analgesik narkotik yang memiliki efek samping utama berupa depresi pernapasan, sehingga harus dipantau ketat setelah pemberian.

C. Manajemen Infeksi dalam Kebidanan**1. Pengertian Manajemen Infeksi dalam Kebidanan**

Manajemen infeksi dalam kebidanan adalah serangkaian tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan dalam upaya mencegah, mengenali, dan mengelola infeksi yang terjadi pada masa kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir.

2. Tujuan Manajemen Infeksi dalam Kebidanan

- Mencegah terjadinya infeksi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan neonatus.
- Mengurangi angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi akibat infeksi.
- Memberikan penanganan tepat dan cepat terhadap infeksi yang terjadi.

- Mengedukasi ibu dan keluarga mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan tanda-tanda infeksi dini.

3. Infeksi yang Sering Terjadi dalam Kebidanan

- a. Infeksi selama Kehamilan
 - Infeksi Saluran Kemih (ISK)
 - Korioamnionitis (infeksi cairan ketuban dan selaput ketuban)
 - Infeksi TORCH (Toksoplasmosis, Rubela, Cytomegalovirus, Herpes simplex)
- b. Infeksi selama Persalinan
 - Korioamnionitis
 - Infeksi luka episiotomi atau luka robekan perineum
- c. Infeksi selama Masa Nifas
 - Endometritis nifas (infeksi endometrium)
 - Mastitis puerperalis (infeksi payudara)
 - Infeksi luka operasi sectio caesarea
- d. Infeksi Neonatal
 - Sepsis neonatorum
 - Omfalitis (infeksi tali pusat)
 - Konjungtivitis neonatal

4. Pencegahan Infeksi dalam Kebidanan

- Menjaga kebersihan tangan dengan cuci tangan standar WHO (5 momen).
- Menggunakan alat steril dalam tindakan kebidanan.
- Teknik persalinan yang bersih dan aman (Asuhan Persalinan Normal/APN).
- Memberikan edukasi kepada ibu tentang kebersihan personal selama kehamilan dan nifas.
- Melakukan pemeriksaan antenatal care (ANC) rutin untuk deteksi dini infeksi.
- Imunisasi tetanus toksoid (TT) bagi ibu hamil.
- Pemberian antibiotik profilaksis dalam kolaborasi dengan dokter sesuai indikasi medis.

5. Penatalaksanaan Infeksi dalam Kebidanan (Kolaborasi dengan Dokter)

Bidan berperan dalam mengenali gejala dini infeksi, melakukan stabilisasi awal, dan segera melakukan kolaborasi atau rujukan kepada dokter dalam penggunaan antibiotik atau tindakan medis lainnya.

Langkah-langkah umum dalam penanganan infeksi:

a. **Identifikasi dan Deteksi Dini:**

Mengenali tanda-tanda infeksi seperti demam, nyeri lokal, bau tidak sedap, tanda radang (kemerahan, bengkak, nyeri), dan peningkatan leukosit.

b. **Stabilisasi Kondisi Pasien:**

- Monitor tanda vital (suhu, denyut nadi, respirasi, tekanan darah).
- Atasi nyeri dengan analgesik ringan sesuai kewenangan.

c. **Kolaborasi dengan Dokter:**

- Konsultasi terkait penggunaan antibiotik atau terapi lanjutan lainnya.
- Pelaksanaan terapi antibiotik sesuai rekomendasi dokter.

d. **Pengawasan dan Pemantauan Kondisi:**

- Observasi ketat terhadap respons klinis pasien setelah pemberian antibiotik atau tindakan medis lainnya.
- Edukasi tanda bahaya infeksi kepada pasien dan keluarga.

e. **Dokumentasi Lengkap dan Teratur:**

Mencatat semua tindakan, respon klinis, dan rencana kolaborasi secara jelas dalam rekam medis pasien.

6. Edukasi Pasien tentang Pencegahan Infeksi

Bidan wajib memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang:

- Pentingnya menjaga kebersihan personal selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas.
- Mengenali tanda bahaya infeksi sejak dini.
- Pentingnya pemeriksaan antenatal rutin.
- Pentingnya ASI eksklusif untuk mengurangi risiko infeksi neonatal.

7. Peran Bidan dalam Manajemen Infeksi

- Melakukan upaya pencegahan infeksi dalam setiap asuhan kebidanan.
- Melakukan deteksi dini terhadap tanda-tanda infeksi.
- Melakukan kolaborasi efektif dengan dokter dalam penanganan infeksi.
- Memberikan edukasi yang jelas dan tepat kepada pasien dan keluarga tentang infeksi dan pencegahannya.

PERTANYAAN:

Soal 1

Seorang ibu postpartum hari ke-5 datang dengan keluhan payudara kanan terasa nyeri, keras, merah, disertai demam 38,5°C.

Tindakan awal yang tepat dilakukan oleh bidan adalah:

- A. Memberikan antibiotik tanpa konsultasi dokter
- B. Menyarankan ibu berhenti menyusui
- C. Hanya memberikan edukasi tanpa tindakan
- D. Melakukan kolaborasi dengan dokter untuk terapi antibiotik
- E. Menunggu kondisi ibu membaik dengan sendirinya

Soal 2

Seorang ibu hamil 34 minggu datang dengan keluhan nyeri berkemih, frekuensi berkemih meningkat, dan nyeri suprapubik. Bidan mencurigai infeksi saluran kemih. Langkah tepat bidan adalah:

- A. Memberikan antibiotik langsung
- B. Memberikan analgesik tanpa antibiotik
- C. Menyarankan minum air putih saja
- D. Tidak melakukan intervensi
- E. Melakukan kolaborasi dengan dokter untuk terapi antibiotik

Soal 3

Pada persalinan, bidan mencurigai adanya korioamnionitis karena cairan ketuban berwarna keruh dan berbau busuk disertai demam pada ibu. Langkah manajemen awal yang paling tepat dilakukan bidan adalah:

- A. Memberikan antibiotik segera tanpa konsultasi dokter
- B. Melakukan observasi saja tanpa tindakan
- C. Segera melakukan kolaborasi dengan dokter untuk terapi antibiotik
- D. Hanya memberikan antipiretik saja
- E. Tidak melakukan tindakan sampai persalinan selesai

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban D. Melakukan kolaborasi dengan dokter untuk terapi antibiotik

Pembahasan:

Gejala menunjukkan mastitis puerperalis yang memerlukan terapi antibiotik. Bidan wajib berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian antibiotik sesuai kewenangan.

Soal 2: Jawaban E. Melakukan kolaborasi dengan dokter untuk terapi antibiotik

Pembahasan:

Infeksi saluran kemih pada kehamilan memerlukan pengobatan antibiotik dengan rekomendasi dokter melalui kolaborasi.

Soal 3: Jawaban C. Segera melakukan kolaborasi dengan dokter untuk terapi antibiotik

Pembahasan:

Korioamnionitis merupakan infeksi serius yang memerlukan intervensi antibiotik segera melalui kolaborasi dengan dokter.

Area 9

Kegawatdaruratan dalam Praktik Kebidanan

A. Penanganan Kasus Syok Hipovolemik, Syok Septik, dan Emboli Air Ketuban

Kegawatdaruratan dalam kebidanan adalah kondisi kritis yang dapat membahayakan nyawa ibu dan bayi, memerlukan tindakan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Tiga kondisi gawat darurat kebidanan yang sering dijumpai adalah syok hipovolemik, syok septik, dan emboli air ketuban.

1. Syok Hipovolemik dalam Kebidanan

a. Pengertian

Syok hipovolemik adalah kondisi kegawatan akibat penurunan volume darah secara tiba-tiba akibat perdarahan hebat, yang menyebabkan penurunan perfusi jaringan.

b. Penyebab dalam Kebidanan

- Perdarahan antepartum: solusio plasenta, plasenta previa
- Perdarahan postpartum: atonia uteri, retensio plasenta, ruptur uteri, robekan jalan lahir berat.

c. Tanda dan Gejala Klinis

- Hipotensi (tekanan darah turun)
- Takikardia (nadi cepat dan lemah)
- Kulit pucat, dingin, berkeriat
- Penurunan kesadaran, gelisah
- Produksi urin menurun drastis (<30 ml/jam)

d. Penatalaksanaan oleh Bidan

- Segera lakukan kolaborasi dengan dokter
- Berikan oksigen 6–8 liter/menit
- Posisikan ibu dalam posisi Trendelenburg (kepala lebih rendah dari kaki) untuk meningkatkan perfusi otak
- Siapkan akses IV (kolaborasi pemasangan infus kristaloid)
- Segera rujuk pasien ke rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap
- Pantau tanda vital terus menerus selama persiapan rujukan

2. Syok Septik dalam Kebidanan

a. Pengertian

Syok septik adalah kondisi syok yang disebabkan oleh infeksi berat yang menyebabkan gangguan perfusi jaringan.

b. Penyebab dalam Kebidanan

- Endometritis nifas berat
- Korioamnionitis berat
- Infeksi luka operasi sectio caesarea atau episiotomi yang parah
- Mastitis berat yang berkembang menjadi abses luas

c. Tanda dan Gejala Klinis

- Demam tinggi ($>38^{\circ}\text{C}$) atau hipotermia ($<36^{\circ}\text{C}$)
- Hipotensi berat yang sulit diatasi dengan cairan
- Takikardia dan napas cepat
- Penurunan kesadaran
- Kulit kemerahan hangat awalnya, kemudian berubah pucat atau kebiruan

d. Penatalaksanaan oleh Bidan

- Identifikasi dini tanda-tanda infeksi berat dan segera lakukan kolaborasi dengan dokter untuk terapi antibiotik IV
- Pemberian oksigen 6–8 liter/menit
- Pasang akses IV, kolaborasi pemberian cairan intravena kristaloid (NaCl/RL)
- Segera lakukan rujukan emergensi ke rumah sakit dengan fasilitas perawatan intensif
- Pantau tanda vital secara ketat selama proses persiapan rujukan

3. Emboli Air Ketuban dalam Kebidanan

a. Pengertian

Emboli air ketuban adalah masuknya cairan ketuban ke dalam sirkulasi darah ibu, yang menyebabkan gangguan berat pada sistem pernapasan dan peredaran darah secara mendadak.

b. Faktor Risiko

- Pecah ketuban dini atau manipulasi rahim
- Persalinan dengan distosia atau trauma uterus
- Riwayat plasenta previa atau solusio plasenta
- Persalinan instrumental atau operasi caesar

c. Tanda dan Gejala Klinis

- Dispnea berat secara tiba-tiba
- Sianosis, gelisah, atau penurunan kesadaran tiba-tiba
- Hipotensi hebat mendadak dan gagal jantung akut

- Kejang atau henti jantung dalam beberapa menit setelah onset gejala

d. Penatalaksanaan oleh Bidan

- Segera panggil bantuan medis darurat
- Berikan oksigen aliran tinggi (8–10 liter/menit dengan masker non-rebreathing)
- Segera pasang jalur IV dengan kolaborasi dokter untuk pemberian cairan dan obat emergensi
- Segera rujuk ke fasilitas kesehatan dengan ICU atau NICU secara darurat
- Pantau terus tanda vital, kondisi kesadaran ibu, serta kondisi janin selama proses rujukan

4. Peran Bidan dalam Penanganan Kegawatdaruratan Kebidanan

- Mendeteksi dini tanda-tanda syok atau komplikasi kebidanan lainnya.
- Melakukan stabilisasi awal (posisi, oksigenasi, monitoring tanda vital).
- Melakukan kolaborasi segera dengan dokter untuk terapi definitif.
- Melakukan rujukan secara cepat, tepat, dan aman.
- Dokumentasi lengkap dan jelas selama proses kegawatdaruratan.

PERTANYAAN:

Soal 1

Seorang ibu postpartum mengalami perdarahan hebat, tampak pucat, keringat dingin, tekanan darah turun drastis, nadi cepat dan lemah. Tindakan awal yang paling tepat dilakukan oleh bidan adalah:

- A. Segera melakukan rujukan tanpa stabilisasi
- B. Memberikan antibiotik oral
- C. Mengabaikan gejala karena dianggap normal
- D. Memberikan oksigen, pasang infus, dan segera rujuk dengan kolaborasi dokter
- E. Menginstruksikan pasien untuk istirahat saja

Soal 2

Ibu nifas hari ke-4 mengalami demam tinggi, tekanan darah turun, napas cepat, kesadaran menurun, dan lokia berbau busuk. Penanganan awal yang tepat adalah:

- A. Segera berikan oksitosin saja
- B. Lakukan kolaborasi segera dengan dokter untuk antibiotik IV, berikan oksigen, dan segera rujuk

- C. Hanya observasi kondisi ibu
- D. Berikan antibiotik oral tanpa kolaborasi
- E. Berikan analgesik saja

Soal 3

Seorang ibu dalam persalinan tiba-tiba mengalami sesak napas hebat, sianosis, kejang, dan tekanan darah turun drastis setelah pecah ketuban. Kondisi tersebut kemungkinan adalah:

- A. Syok hipovolemik
- B. Preeklamsia
- C. Emboli air ketuban
- D. Syok anafilaktik
- E. Hipertensi berat

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban D. Memberikan oksigen, pasang infus, dan segera rujuk dengan kolaborasi dokter

Pembahasan:

Gejala mengarah ke syok hipovolemik akibat perdarahan postpartum. Stabilisasi awal dengan oksigen, infus, dan kolaborasi dokter sebelum rujukan adalah tindakan tepat.

Soal 2: Jawaban B. Lakukan kolaborasi segera dengan dokter untuk antibiotik IV, berikan oksigen, dan segera rujuk

Pembahasan:

Gejala mengarah pada syok septik akibat infeksi nifas berat. Kolaborasi dengan dokter untuk antibiotik IV dan rujukan darurat adalah langkah tepat.

Soal 3: Jawaban C. Emboli air ketuban

Pembahasan:

Gejala klasik emboli air ketuban berupa sesak mendadak, sianosis, kejang, dan penurunan kesadaran setelah ketuban pecah.

B. Teknik Resusitasi Neonatus (RJP Neonatus)

1. Pengertian Resusitasi Neonatus

Resusitasi neonatus adalah serangkaian tindakan cepat dan terorganisasi yang dilakukan untuk membantu bayi baru lahir yang mengalami kesulitan bernapas atau gagal bernapas spontan, bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan organ dan kematian.

2. Tujuan Resusitasi Neonatus

- Memastikan bayi bernapas secara efektif.
- Mencegah asfiksia berat yang menyebabkan kerusakan otak.
- Menurunkan angka kematian dan morbiditas neonatal akibat asfiksia.

3. Indikasi Resusitasi Neonatus

Bayi baru lahir dengan salah satu kondisi berikut membutuhkan resusitasi:

- Tidak menangis atau tidak bernapas spontan setelah lahir.
- Tonus otot lemah atau bayi tampak lemas.
- Frekuensi jantung <100 kali per menit.
- Warna kulit kebiruan atau pucat (sianosis).

4. Langkah-Langkah Resusitasi Neonatus (Algoritma WHO)

Resusitasi neonatus dilakukan dalam "golden minute" (1 menit pertama kelahiran):

a. *Initial Steps* (Langkah Awal):

- Segera setelah lahir, lakukan penilaian cepat.
- Lakukan penghangatan bayi, posisikan kepala bayi (sedikit ekstensi), bersihkan jalan napas (jika ada sekret), keringkan tubuh bayi, dan stimulasi taktil (gosok punggung/telapak kaki).

b. Evaluasi Respirasi dan Frekuensi Jantung

Jika bayi masih tidak bernapas atau napas megap-megap (gaspings) setelah 30 detik langkah awal, segera lakukan ventilasi tekanan positif (VTP).

c. Ventilasi Tekanan Positif (VTP)

- Berikan ventilasi dengan bag and mask.
- Frekuensi 40–60 kali/menit, tekanan cukup untuk menaikkan dada bayi.
- Evaluasi setiap 30 detik.

d. Evaluasi Setelah VTP 30 Detik

Jika denyut jantung masih <60 kali per menit, lanjutkan ke kompresi dada.

- e. Kompresi Dada (*Chest Compression*)
 - Teknik kompresi dada: gunakan 2 jempol, letakkan kedua tangan melingkari dada bayi di bawah garis puting.
 - Kedalaman kompresi: 1/3 diameter dada bayi.
 - Rasio kompresi dan ventilasi: 3 kompresi: 1 ventilasi (90 kompresi dan 30 ventilasi per menit).
- f. Evaluasi Setelah Kompresi 60 Detik
Evaluasi kembali denyut jantung. Jika tetap <60 kali/menit, lanjutkan kompresi dada dan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat (adrenalin IV).
- g. Pemberian Obat (Kolaborasi dengan dokter)
Adrenalin (Epinefrin) IV/IO: dosis 0,01–0,03 mg/kg.

5. Peran Bidan dalam Resusitasi Neonatus

- Mengenali secara dini bayi yang memerlukan resusitasi.
- Melakukan langkah awal resusitasi secara efektif.
- Melakukan ventilasi tekanan positif (VTP) dengan benar.
- Melakukan kompresi dada secara tepat jika diperlukan.
- Melakukan kolaborasi segera dengan dokter jika bayi tidak merespon ventilasi dan kompresi dada.
- Mendokumentasikan semua langkah tindakan yang dilakukan dengan jelas dan rinci.

6. Peralatan yang Dibutuhkan dalam Resusitasi Neonatus

- Meja resusitasi bayi dengan sumber pemanas.
- Handuk atau kain hangat.
- Suction bulb atau alat penghisap sekret.
- Alat ventilasi (bag and mask neonatal) yang ukurannya sesuai.
- Oksigen tambahan jika tersedia.
- Jam atau timer untuk evaluasi tindakan setiap 30 detik.

7. Komplikasi dari Resusitasi Neonatus yang Tidak Tepat

- Hipoksia atau asfiksia berat dengan kerusakan otak.
- Pneumotoraks akibat ventilasi berlebihan.
- Fraktur iga akibat kompresi dada berlebihan.

8. Dokumentasi yang Harus Dilakukan oleh Bidan

- Waktu lahir bayi.
- Tindakan resusitasi yang dilakukan secara kronologis.
- Respons bayi terhadap setiap langkah resusitasi.

- Tanda vital bayi (denyut jantung, pernapasan, warna kulit).
- Waktu pemulihan bayi (menangis atau bernapas spontan).

PERTANYAAN:

Soal 1

Seorang bayi baru lahir tidak menangis spontan, tonus otot lemah, dan frekuensi jantung 80 kali per menit setelah langkah awal resusitasi. Tindakan selanjutnya yang paling tepat adalah:

- Melakukan kompresi dada
- Memberikan obat epinefrin segera
- Memberikan ventilasi tekanan positif (VTP) dengan bag and mask
- Menunggu bayi bernapas spontan
- Menghisap sekret secara berulang

Soal 2

Setelah 30 detik ventilasi tekanan positif, denyut jantung bayi turun menjadi 50 kali per menit. Tindakan berikutnya yang tepat dilakukan oleh bidan adalah:

- Melanjutkan ventilasi tekanan positif tanpa kompresi
- Melakukan kompresi dada dengan rasio 3:1 (kompresi : ventilasi)
- Memberikan antibiotik intramuskular
- Memberikan oksigen tambahan saja
- Melakukan observasi ketat tanpa tindakan lanjutan

Soal 3

Dalam teknik kompresi dada neonatus yang tepat, kedalaman kompresi dada yang dianjurkan adalah:

- $\frac{1}{4}$ diameter dada
- $\frac{1}{3}$ diameter dada
- $\frac{1}{2}$ diameter dada
- $\frac{2}{3}$ diameter dada
- Diameter penuh dada bayi

KUNCI JAWABAN:

Soal 1: Jawaban C. Memberikan ventilasi tekanan positif (VTP) dengan bag and mask

Pembahasan:

Jika denyut jantung <100 kali per menit setelah langkah awal, segera lakukan VTP dengan bag and mask.

Soal 2: Jawaban B. Melakukan kompresi dada dengan rasio 3:1 (kompresi : ventilasi)

Pembahasan:

Denyut jantung <60 kali/menit setelah ventilasi, lakukan segera kompresi dada dengan rasio 3 kompresi : 1 ventilasi.

Soal 3: Jawaban B. 1/3 diameter dada

Pembahasan:

Kedalaman kompresi dada neonatal yang direkomendasikan adalah sekitar 1/3 dari diameter anterior-posterior dada bayi.

Daftar Pustaka

- Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN). (2021). *Perinatal Nursing* (5th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). *Williams Obstetrics* (26th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Fraser, D. M., & Cooper, M. A. (2020). *Myles Textbook for Midwives* (17th ed.). London: Elsevier.
- Gabbe, S. G., Niebyl, J. R., Simpson, J. L., Landon, M. B., Galan, H. L., Jauniaux, E. R., ... & Driscoll, D. A. (2020). *Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies* (8th ed.). Philadelphia, PA: Elsevier.
- Ikatan Bidan Indonesia (IBI). (2021). *Panduan Pelayanan Kebidanan Berbasis Bukti (Evidence-Based Midwifery)*. Jakarta: Pengurus Pusat IBI.
- International Confederation of Midwives (ICM). (2021). *Essential Competencies for Midwifery Practice*. The Hague: ICM.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Kebidanan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Prawirohardjo, S. (Ed.). (2020). *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Johnson, R., & Taylor, W. (Eds.). (2021). *Skills for Midwifery Practice* (5th ed.). London: Elsevier.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., Alden, K. R., & Olshansky, E. F. (2020). *Maternity and Women's Health Care* (12th ed.). St. Louis, MO: Elsevier Mosby.

Marshall, J., & Raynor, M. (Eds.). (2020). *Myles Professional Studies for Midwifery Education and Practice: Concepts and Challenges*. London: Elsevier.

Ministry of Health Republic of Indonesia. (2021). *Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Terpadu*. Jakarta: Kemenkes RI.

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). (2020). *Guidelines for Maternity Care*. London: RCOG Press.

Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2020). *Varney's Midwifery* (Edisi terbaru). Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.

World Health Organization (WHO). (2018). *WHO Recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. Geneva: WHO Press.

World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. Geneva: WHO Press.

Buku "Materi Penting Seputar UKOM Kebidanan" hadir sebagai buku sekaligus sumber motivasi bagi mahasiswa kebidanan yang tengah bersiap menghadapi Uji Kompetensi Nasional (UKOMNAS).

Disusun dengan semangat dan penuh rasa syukur, buku ini tidak hanya membekali pembaca dengan materi esensial, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kesiapan mental untuk menapaki gerbang awal dunia profesi kebidanan.

Melalui pesan-pesan penyemangat, pembaca diajak untuk memahami bahwa UKOMNAS bukan sekadar ujian akademik, melainkan juga ujian integritas, tanggung jawab, dan dedikasi sebagai calon bidan yang berperan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Setiap usaha, kerja keras, dan ketekunan belajar yang dijalani menjadi investasi berharga untuk masa depan.

Buku ini menegaskan nilai luhur profesi kebidanan: menyelamatkan nyawa, menjaga kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Dengan dorongan untuk terus melangkah penuh keyakinan dan optimisme, buku ini menjadi sahabat setia dalam perjalanan meraih cita-cita menjadi bidan profesional, kompeten, dan berempati tinggi.

Mari persiapkan diri sebaik mungkin, melangkah dengan tekad yang kuat, dan wujudkan impian menjadi kebanggaan bangsa!

Buku "Materi Penting Seputar UKOM Kebidanan" hadir sebagai buku sekaligus sumber motivasi bagi mahasiswa kebidanan yang tengah bersiap menghadapi Uji Kompetensi Nasional (UKOMNAS).

Disusun dengan semangat dan penuh rasa syukur, buku ini tidak hanya membekali pembaca dengan materi esensial, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kesiapan mental untuk menapaki gerbang awal dunia profesi kebidanan.

Melalui pesan-pesan penyemangat, pembaca diajak untuk memahami bahwa UKOMNAS bukan sekadar ujian akademik, melainkan juga ujian integritas, tanggung jawab, dan dedikasi sebagai calon bidan yang berperan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Setiap usaha, kerja keras, dan ketekunan belajar yang dijalani menjadi investasi berharga untuk masa depan.

Buku ini menegaskan nilai luhur profesi kebidanan: menyelamatkan nyawa, menjaga kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Dengan dorongan untuk terus melangkah penuh keyakinan dan optimisme, buku ini menjadi sahabat setia dalam perjalanan meraih cita-cita menjadi bidan profesional, kompeten, dan berempati tinggi. Mari persiapkan diri sebaik mungkin, melangkah dengan tekad yang kuat, dan wujudkan impian menjadi kebanggaan bangsa!

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-10-9317-2

